



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN AGUSTUS
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 4

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 9

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 9

3.3.2 Rawat Inap 12

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 19

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 21

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 22

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 23

3.4.1 Instalasi Farmasi 23

3.4.2 Laboratorium 26

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 30

3.4.4 Radiologi 32

3.4.5 Gizi 35

3.4.6 CSSD - Laundry 37

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan 40

3.5.1 SDM 40

3.5.2 MFK dan K3RS 45

3.5.3 Security 50

3.5.4 Parkir 53

3.5.5 Humas Marketing 53

3.5.6 Penjaminan 57

3.5.7 PIPP – MOD - MPP 59

3.5.8 *Cleaning Service* 67

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum 70

3.6 Komite dan Tim 71

3.6.1 Komite Mutu 71

3.6.2 Komite PPI 101

3.6.3 Tim PKRS 110

3.6.4 Tim Prognas 112

3.6.5 Tim PPRA 150

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 156

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 157

3.8 Profil SDM 162

Bab IV Kesimpulan dan Saran 166

Bab V Penutup 166

LAMPIRAN 169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Agustus Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



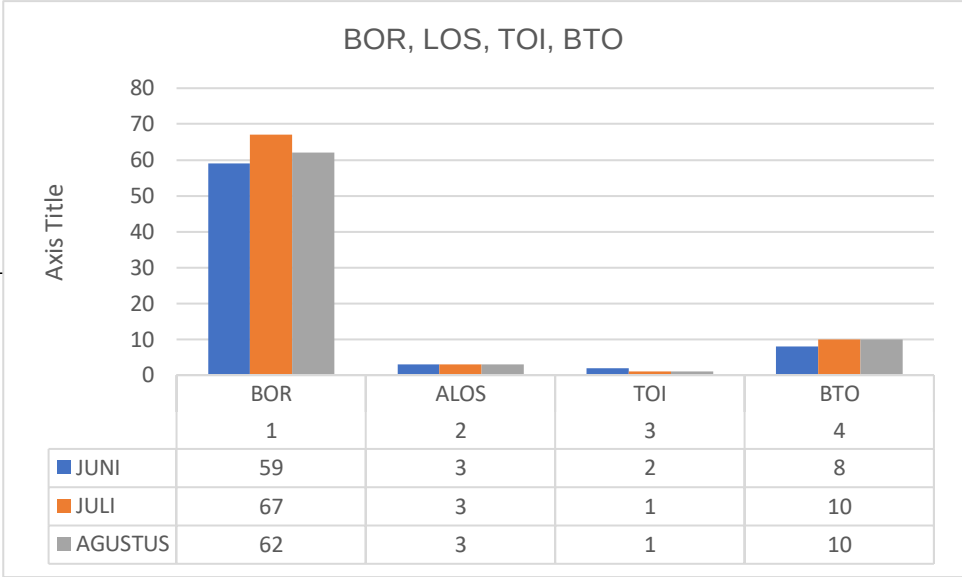
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	BOR	59	67	62
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	2	1	1
4	BTO	8	10	10

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



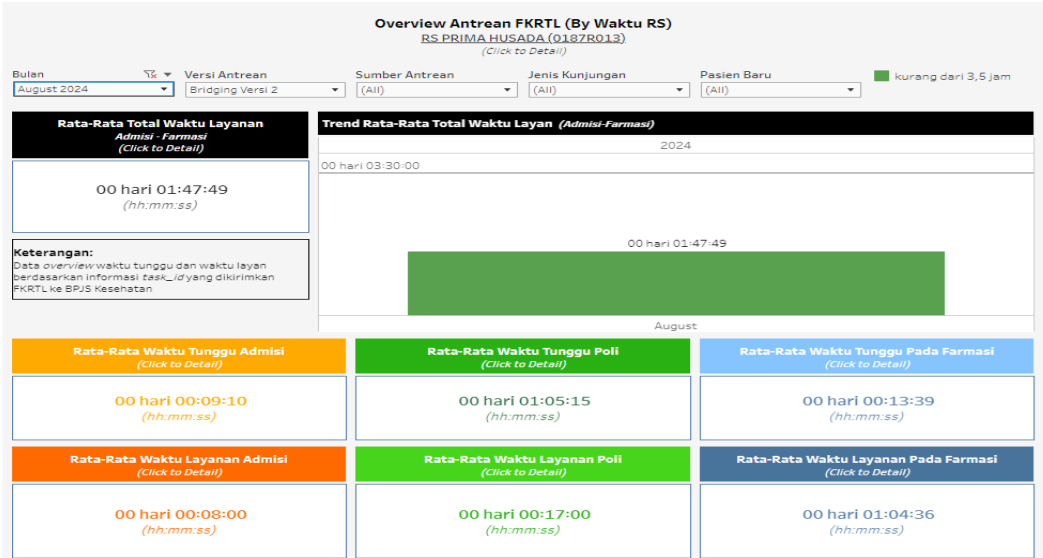
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

BOR mengalami penurunan dengan persentase sebesar 7% hal ini dikarenakan adanya penurunan kunjungan pasien.

ALOS masih tetap berada pada rata-rata 3 hari, yang masih berada di bawah standar 6-12 hari. Hal ini disebabkan karena pasien dominan jaminan BPJS, dimana terdapat keterbatasan plafon sehingga pasien yang sudah stabil dapat dipulangkan pada hari rawat ketiga hingga empat.

TOI masih relative sama dengan bulan sebelum-sebelumnya. BTO atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode berada pada sepuluh kali sedang standardnya yaitu 40-50 kali.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN	BULAN			
		Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
	Waktu Rata-Rata				
1	Total Waktu Layanan	02.34.36	02.32.53	01.56.32	01.47.49
2	Waktu Tunggu Admisi	00.13.59	00.06.00	00.07.29	00.09.10
3	Waktu Layanan Admisi	00.13.56	00.05.56	00.07.00	00.08.00
4	Waktu Tunggu Poli	01.06.11	01.05.56	01.02.53	01.05.15
5	Waktu Layanan Poli	00.17.12	00.18.20	00.16.25	00.17.00
6	Waktu Tunggu Farmasi	00.19.15	00.16.46	00.13.41	00.13.39
7	Waktu Layanan Farmasi	01.06.17	01.00.38	00.48.20	01.04.36

Analisis :
 Pada bulan Juli 2024, total waktu layanan menunjukkan penurunan yaitu lebih cepat pada angka 01.47.49. Adanya permasalahan pada sistem antrian online menyebabkan ketidak validan total waktu layanan dengan rata-rata waktu tunggu di setiap unit.

Plan	Berkoordinasi dengan programmer terkait permasalahan sistem sehingga total waktu tunggu menjadi valid
Do	Melakukan rapat koordinasi dengan programmer
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

NO	JENIS	Target	MAR 24	APR 24	MEI 24	JUNI 24	JULI 24
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	34.86%	37.2%	34.88%	Tidak ada	37.82%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	94.57%	96.2%	94.62%	Tidak ada	94.9%

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%).

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin, terdapat evaluasi dari Dir PT sehingga bimbingan doa diubah menjadi 1 kali seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil dan hypnobirthing	Untuk senam hamil sudah berjalan tetapi untuk hynobithing belum berjalan	Hypnobirthing belum berjalan karena terkendala jumlah SDM yang kurang
3	IRNA	Foto bayi	Sudah berjalan dengan baik, respon keluarga pasien juga baik	-
4	IRJA	Poli Eksekutif	Jumlah pasien mengalami peningkatan	Belum ada pasien IPD dan Saraf Sakura
5	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Memasang poster kriteria kegawatan BPJS	20% pasien masih ada yang belum paham mengenai kriteria kegawatan
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara	Proses penyelesaian oleh Programmer PT.	Dalam antrian programmer.
		2. TTD elektronik semua pasien rawat jalan, baik pasien IGD maupun rawat inap.	Follow up programmer.	Dalam antrian programmer.
		3. Fitur Iterisasi pada SIMRS.	Fitur obat iter memudahkan untuk melayani resep iterasi. Jumlah pasien iter bulan Juli 2024 yaitu 119. Jumlah pasien iter bulan Agustus 2024 yaitu 139.	Monitoring dan evaluasi sistem elektronik ITER Target 1000/tahun. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan untuk pencapaian target (sosialiasi dengan DPJP). Centralisasi Master Barang berdampak kepada pasien ITER, karena ada perbaruan master sehingga diasiasi dengan input di resep lain-lain.

		4. KPO elektronik (e-KPO)	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. Pengajuan ke progamer untuk dibuatkan fitur e-KPO yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien.	Dalam antrian programmer.
		5. Pengadaan LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.	Koordinasi dengan Kains Farmasi untuk melakukan pengajuan ke PT terkait pemindahan ruang LAF, yaitu rencana diajukan di Lantai Maternitas (ex IKO Covid).	Dalam Proses.
2	Gudang Farmasi	1. Repack sediaan farmasi sharing dose.	Repack sudah berjalan, tarif repack sudah ada.	1. Tidak ada lemari asam, sehingga repack formalin ditiadakan. 2. Alkohol repack terlalu kecil tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Stardine repack fastmoving.
		2. RFID	RFID (Radio Frequency Identification) adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang menggunakan frekuensi radio untuk mengambil data sehingga mendukung rantai manajemen, pengendalian persediaan, mengontrol penyimpanan dan pengiriman persediaan.	Pengajuan software aplikasi RFID system, tag (transponder), antena, dan reader (Interrogator)

3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses memasukan form kedalam aplikasi SIMRS.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis.
		2. Serah terima DRM menggunakan system digital.	Serah terima menggunakan spreadsheet (sudah berjalan).	Monitoring dan Evaluasi.
		3. Permintaan form menggunakan system digital.	Permintaan form dari unit menggunakan google form, sudah berjalan mulai Bulan Juni 2024.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Dokumentasi DRM lama	Melakukan scanning form kedalam SIMRS.	Pengajuan ke PT.
4	Radiologi	Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil radiograf dapat diakses.	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Pengadaan LIS.
		2. Pengadaan BDRS.	1. Proposal dan surat permintaan pelatihan sudah dibuatkan. 2. Sudah ada daftar kebutuhan pengadaan BDRS dan sudah diajukan, menunggu penawaran. 3. Penyekatan ruangan	Pengadaan BDRS.

			BDRS sudah dilakukan. 4. Legalitas dibantu pengurusan oleh Legal PT. 5. Review tarif disesuaikan dengan PHS.	
6	Gizi	1. Pengaktifan Poli Gizi di Rawat Jalan	Kolaborasi dengan Humas & Marketing.	Monitoring dan evaluasi setiap bulan
		2. MCU Gizi	Rencana diajukan review tarif ke Keuangan PT	Dalam Proses
		3. <i>Prima Healthy Meal</i>	Sudah pengajuan TOR ke PT	Menunggu ACC
7	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitor (steam plasma)	Belum terealisasi	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf.
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Sudah berjalan di Bulan Juli.	1. Kolom tidak terisi lengkap. 2. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
8	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg.	Belum terealisasi.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama.
		2. Membuat digital form untuk permintaan linen.	Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. Belum terealisasi.	Dalam proses.
		3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP.	Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP.	Dalam Proses.

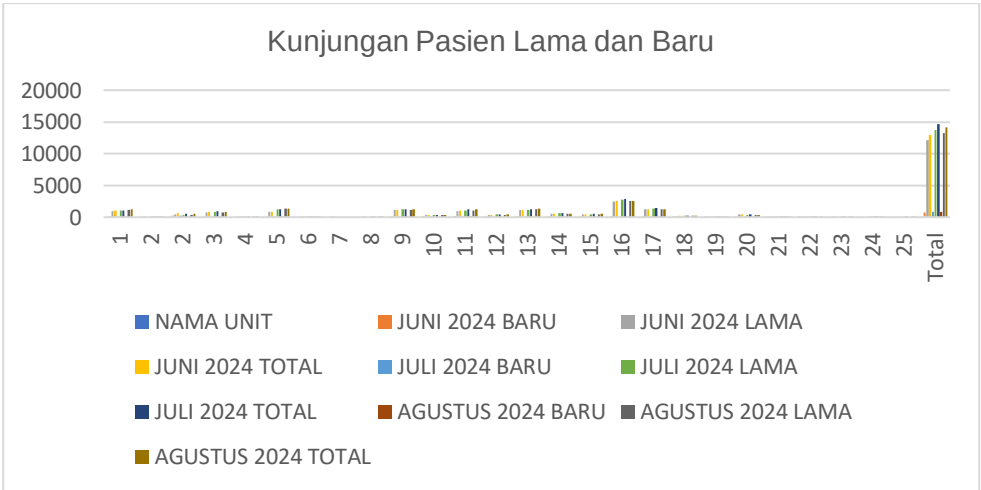
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	JUNI 2024			JULI 2024			AGUSTUS 2024		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	46	961	1007	80	995	1075	97	1164	1261
2	Anak sakura	0	1	1	0	1	1	1	2	3
2	IGD	236	435	671	199	372	571	179	379	558
3	Klinik Bedah	54	735	792	55	869	924	48	775	823
4	Klinik Bedah	0	19	19	3	33	37	0	34	34

	Plastik									
5	Klinik Fisioterapi	5	848	853	1	1255	1256	1	1309	1310
6	Klinik Gigi Periodonti	0	42	42	6	38	44	5	32	37
7	Klinik Gigi Spesialis	0	12	12	0	0	0	0	0	0
8	Klinik Ibu dan Anak	0	9	9	0	13	13	0	6	6
9	Klinik Jantung	13	1106	1119	27	1242	1269	32	1181	1213
10	Klinik Jiwa	10	337	347	8	362	370	10	352	362
11	Klinik Kandungan	108	928	1036	127	1081	1208	127	1070	1197
12	Klinik Kulit dan Kelamin	24	341	365	53	399	452	42	373	415
13	Klinik Mata	55	1116	1171	67	1189	1256	56	1250	1306
14	Klinik Orthopedi	34	528	562	34	599	633	20	508	528
15	Klinik Paru	6	442	428	14	482	496	10	484	494
16	Klinik Penyakit Dalam	53	2498	2551	50	2796	2846	71	2508	2579
17	Klinik Syaraf	29	1229	1258	37	1387	1424	51	1231	1282
18	Klinik THT	39	178	217	55	204	259	52	225	277
19	Klinik Umum	46	10	56	29	21	50	20	10	30
20	Klinik Urologi	13	405	418	33	376	409	28	291	319
21	Klinik gigi anak	2	6	8	3	4	7	3	4	7
22	Gizi	2	3	5	1	17	18	1	0	1
23	Bedah Saraf	0	5	5	0	7	7	0	7	7
24	Obgyn Sakura				2	2	4	3	5	8
25	Penyakit dalam sakura				0	1	1	0	2	2
Total		777	12180	12957	884	13745	14650	874	13274	14148



Analisis :

1. Kunjungan 3 bulan terakhir masih naik turun terlebih lagi pada bulan Agustus 2024 ini mengalami penurunan sebanyak 3,6% dari bulan Juli 2024. Analisisnya karena bulan agustus, banyak pasien yang di PRB kan dan beberapa DPJP target PRB nya ada yang sudah tercapai
2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2580 pasien. Kunjungan tersebut menurun dari bulan sebelumnya sebanyak 2846 pasien, karena banyak pasien yang di PRB kan untuk mengejar target PRB bulan Oktober 2024
3. Kunjungan poli gigi ortodonti masih sedikit karena hanya menerima pasien umum saja, poli pedodonti sudah mulai banyak pasiennya yaitu 62 pasien, dari yang sebelumnya hanya 7 pasien.

Kunjungan poli bedah syaraf sebanyak 21 pasien, kunjungan diharapkan meningkat pada bulan bulan september 2024, karena sudah bisa menerima BPJS kesehatan

Kunjungan poli sakura sudah naik dari bulan sebelumnya karena adanya diskon untuk bulan agustus

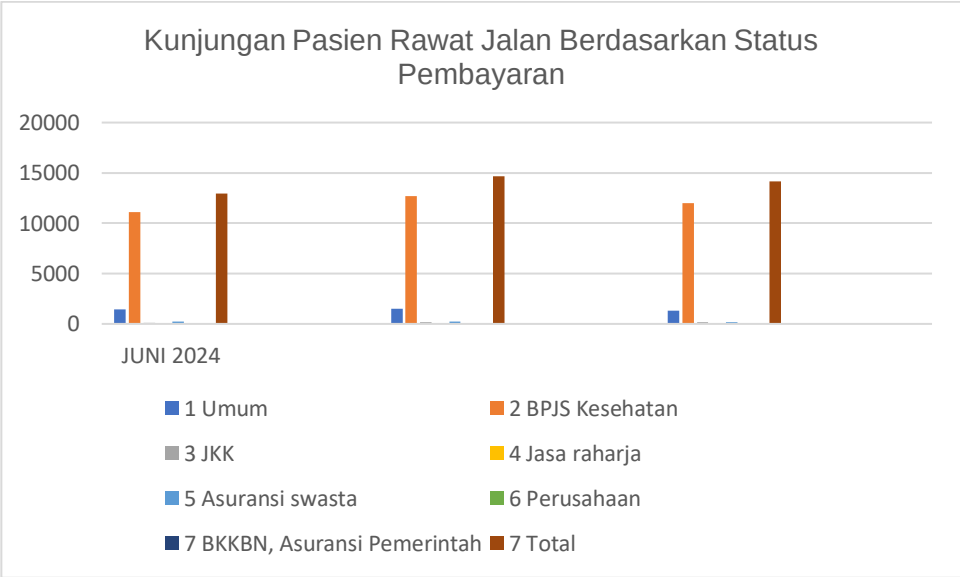
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Untuk bulan depannya membuat harga promo lagi sehingga semua bisa menikmati pelayanan poli sakura
- 2. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
- 3. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi perusahaan
- 4. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 5. Koordinasi dengan humas marketing untuk menampilkan promo di media sosial
- 6. Koordinasi dengan perawat yang ada di ruangan penjangkaran pasien umum dan asuransi

3.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN JUNI 2024	%	BULAN JULI 2024	%	BULAN AGUSTUS 2024	%
1	Umum	1435	11,07%	1499	10,23%	1287	9,65%
2	BPJS Kesehatan	11121	85,82%	12709	86,75%	12005	88,43%
3	JKK	128	0,99%	150	1,02	150	0,82%
4	Jasa raharja	22	0,17%	6	0,04%	23	0,16%
5	Asuransi swasta	226	0,03%	231	1,58%	156	1,14%
6	Perusahaan	22	0,17%	39	0,27%	19	0,23%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	0	0%	16	0,11	17	0,12
	Total	12957	100%	14650	100%	14148	100%

3.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

Kunjungan pasien selama 3 bulan terakhir berdasarkan cara bayar masih naik turun dan belum stabil terlebih untuk bulan agustus 2024 berdasarkan cara pembayaran menurun dari bulan juli sebesar 3,6%. Kunjungan terbanyak salah pasien dengan penjamin BPJS kesehatan sebesar 88,43%.Kunjungan terendah adalah pasien asuransi pemerintah sebesar 0,12 (17 pasien).Kunjungan asuransi pemerintah terbilang sedikit karena sebagian besar pasien memakai BPJS dan umum

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak

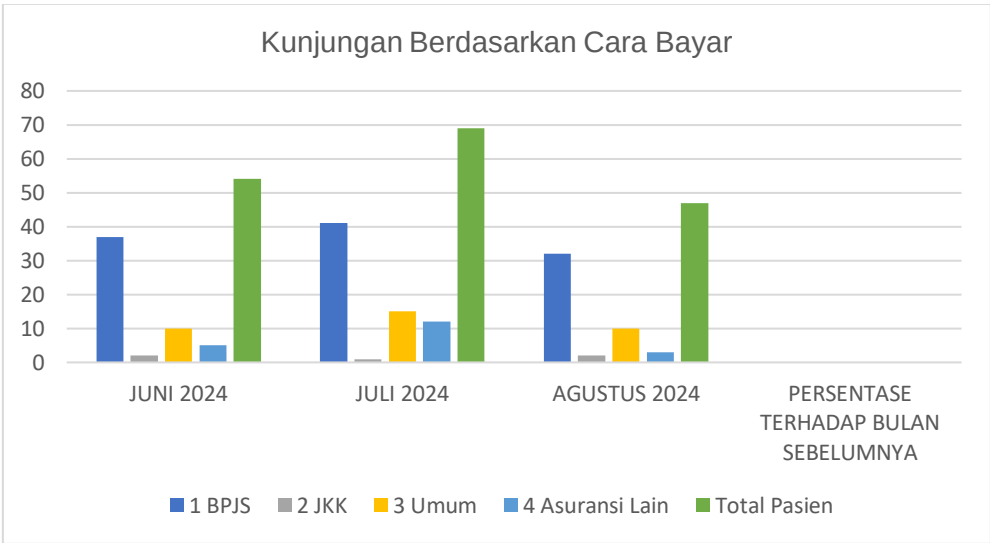
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni – Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	37	41	32	21,9%↓
2	JKK	2	1	2	50%↑
3	Umum	10	15	10	33,3%↓
4	Asuransi Lain	5	12	3	75%↓
Total Pasien		54	69	47	31,88%↓

3.3.2.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

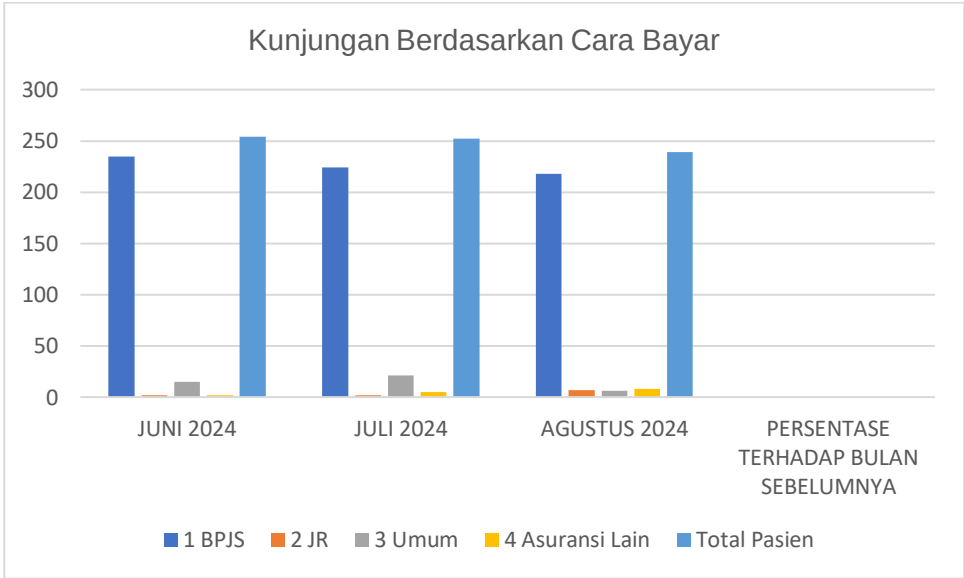
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Agustus 2024	32	10	2	3	47
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan untuk jumlah pasien bpjs masih naik turun untuk bulan agustus mengalami penurunan 21,9%	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir masih naik turun untuk bulan agustus mengalami penurunan 33,3%	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami naik turun untuk bulan agustus mengalami peningkatan 50% dari bulan juli	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil dan masih naik turun untuk bulan agustus mengalami penurunan 75%	Total pasien bulan Agustus mengalami penurunan dari bulan juli sebesar 31,8%
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap,serta bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru				

3.3.2.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.3.2.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	235	224	218	↓5,8%
2	JR	2	2	7	↑7,1%
3	Umum	15	21	6	↓71,4%
4	Asuransi Lain	2	5	8	↑37,5%
Total Pasien		254	252	239	↓5,1%

3.3.2.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Juni-Agustus 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

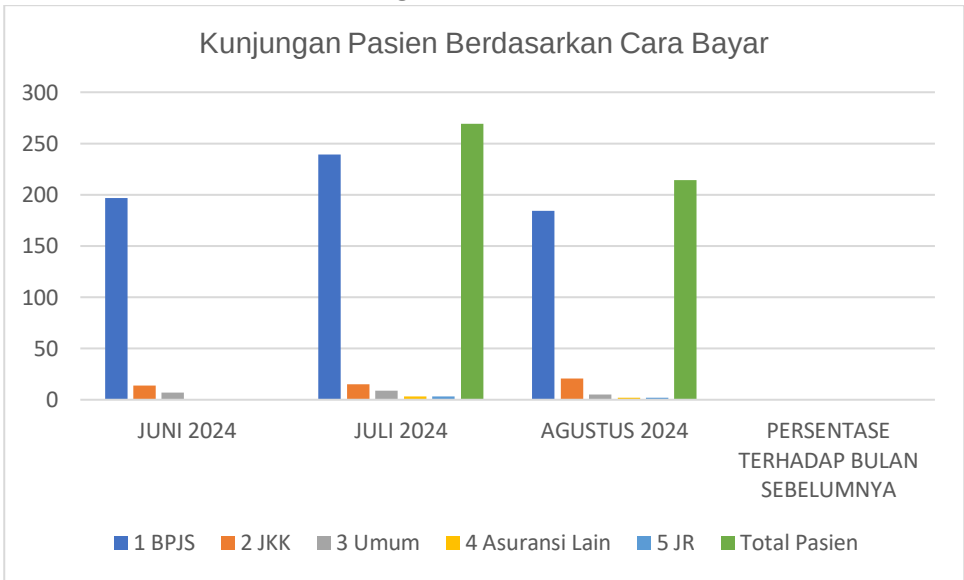
NO.	BULAN AGUSTUS 2024	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir selalu mengalami penurunan ,untuk bulan agustus 2024 mengalami penurunan 5,8%	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami naik dan turun untuk bulan agustus mengalami penurunan 71,4%	Untuk pasien JR dalam 3 bulan terakhir mengalami kenaikan untuk bulan agustus 7,1%	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir selalu mengalami kenaikan untuk bulan agustus 37,5%	Total keseluruhan bulan agustus mengalami penurunan 5,1%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya Evaluasi antrian operasi elektif, Mempercepat waktu antrian operasi,				

3.3.2.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.3.2.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	197	239	184	↓23,0%
2	JKK	14	15	21	↑40%
3	Umum	7	9	5	↓44,4%
4	Asuransi Lain	0	3	2	↓33,3%
5	JR	0	3	2	↓33,3%
Total Pasien		215	269	214	↓20,4%

3.3.2.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni – Agustus 2024)



3.3.2.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

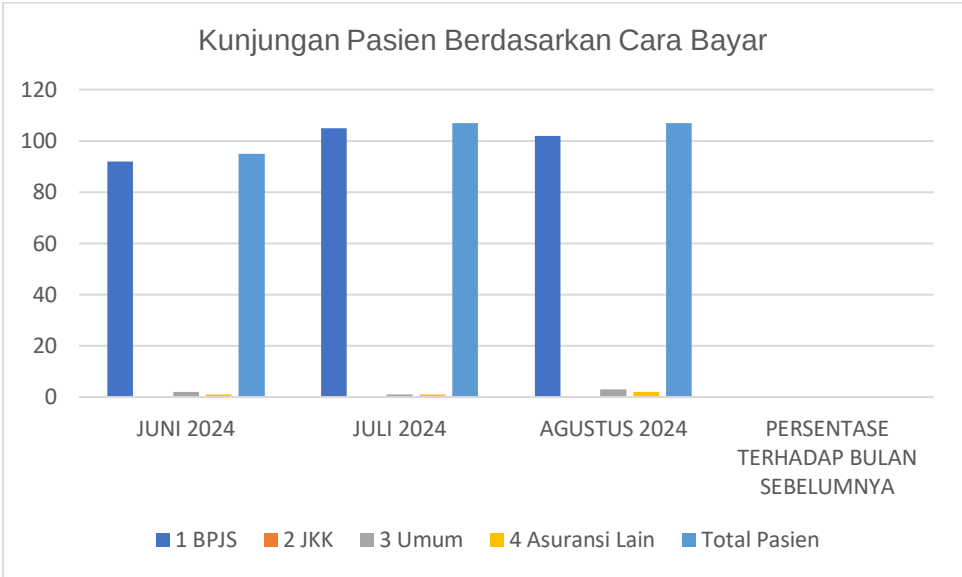
NO .	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURA NSI	
1	Analisis capaian Agustus 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami penurunan 23%	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami penurunan 44,4%	Pasien JKK 3 dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus untuk bulan agustus mengalami peningkatan 40%	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan, untuk bulan agustus mengalami penurunan 33,3%	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami penurunan untuk bulan agustus total pasien 214
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya, Selalu berkoordinasi dengan pihak managmen terlebih marketing untuk menjaring pasien baik dari pasien KLL maupun asuransi perusahaan				

3.3.2.4 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.3.2.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	92	105	102	↓ 2,85%
2	JKK	0	0	0	0
3	Umum	2	1	3	↑ 100%
4	Asuransi Lain	1	1	2	↑ 100%
Total Pasien		95	107	107	0%

3.3.2.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Juni – Agustus 2024)



3.3.2.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

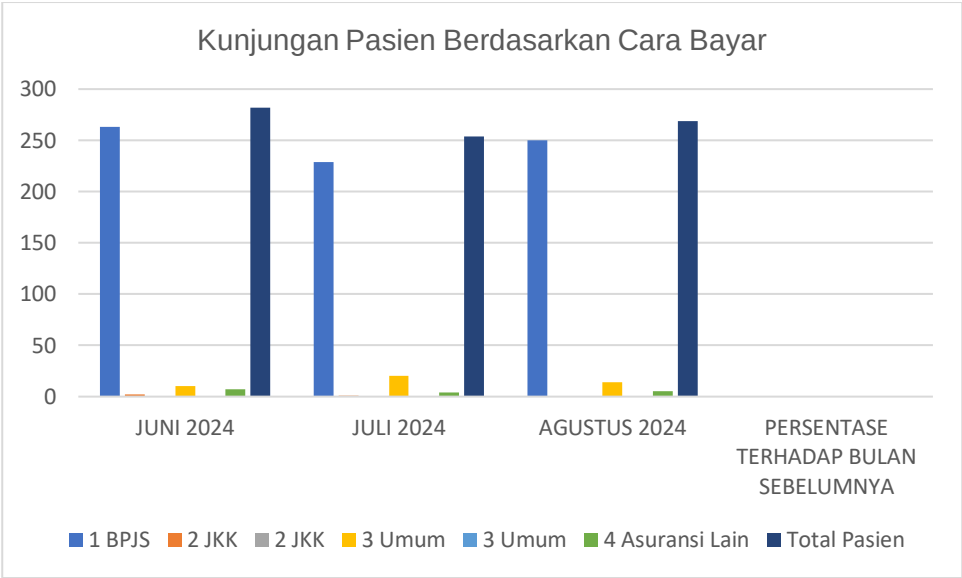
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami penurunan 2,85% (3 pasien)	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami peningkatan 100%(2 pasien)	Dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien JKK	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan agustus mengalami peningkatan sebesar 100% (1 pasien)	Pada bulan agustus total jumlah pasien 107
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

3.3.2.5 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.3.2.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	263	229	250	↑9,1%
2	JKK	2	1	0	↓ 100%
3	Umum	10	20	14	↓30%
4	Asuransi Lain	7	4	5	↑20%
Total Pasien		282	254	269	↑5,9%

3.3.2.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2024)



3.3.2.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

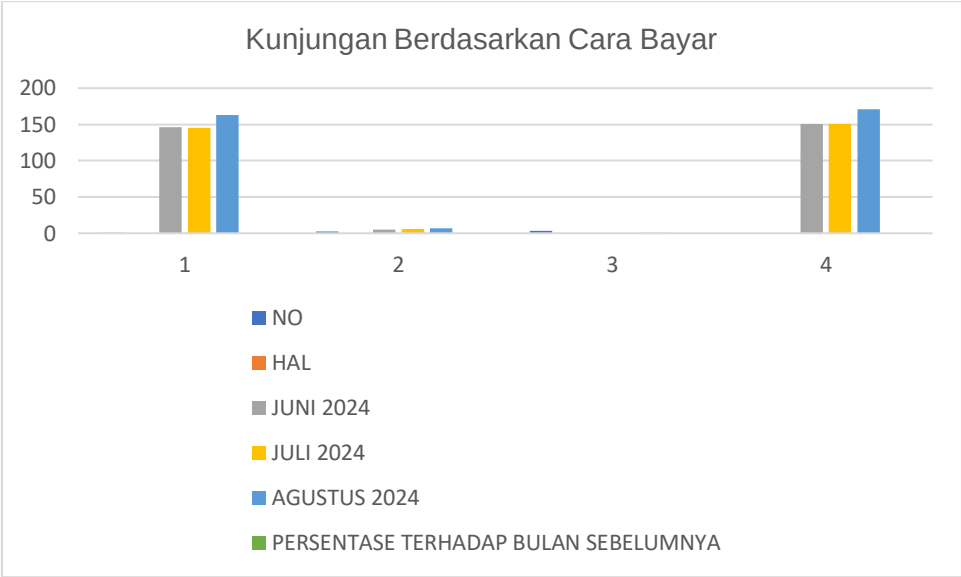
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami peningkatan 9,1 %	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami penurunan 30%	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan, untuk bulan agustus mengalami penurunan 100%	Pasien Asuransi / JR mengalami dalam 3 bulan terakhir masih mengalami peningkatan dan penurunan yang belum stabil untuk bulan agustus mengalami peningkatan 20%	Total semua pasien mengalami peningkatan 5,9%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya, mengurangi jumlah komplain terkait pelayanan maupun keramahan perawat yang kurang bagus dalam melakukan etika				

3.3.2.6 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.3.2.6.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni- Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	146	145	163	↓ 11,04%
2	Umum	5	6	7	↑ 14,2%
3	Asuransi	0	0	1	↑100%
Total Pasien		151	151	171	↑11,69 %

3.3.2.6.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)



3.3.2.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

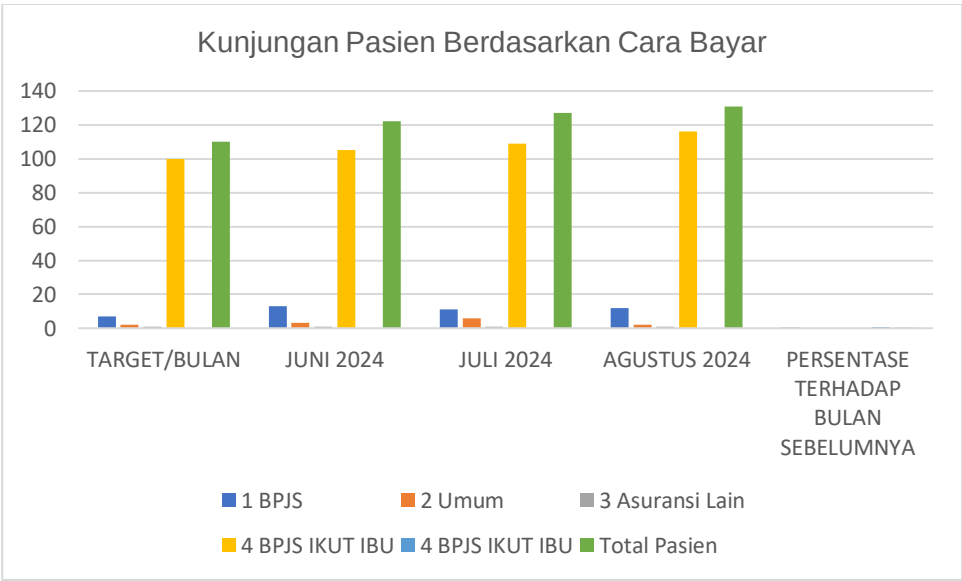
NO.	BULAN	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Juni-Agustus 2024	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus 2024 mengalami peningkatan 11,4% (18 pasien)	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir selalu mengalami peningkatan secara terus-menerus untuk bulan agustus mengalami peningkatan 14,2%(1 pasien)	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir sangat sedikit sekali,untuk bulan agustus 2024 ada 1 pasien	Total pasien bulan agustus mengalami peningkatan 11,69% (20 pasien)
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan badan jejaring yang ada di malang utara	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan badan jejaring yang ada di malang utara	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan	

3.3.2.7 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	13	11	12	↑9%
2	Umum	2	3	6	2	↓66,6%
3	Asuransi Lain	1	1	1	1	0%
4	BPJS IKUT IBU	100	105	109	116	↑6%
Total Pasien		110	122	127	131	↑3%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Agustus 2024	12	2	1	116	131
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir masih naik turun untuk bulan agustus mengalami kenaikan dari bulan juli sebanyak 9%	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir masih naik turun untuk bulan agustus mengalami penurunan dari bulan juli sebanyak 66,6%	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir kenaikan pasien tidak signifikan dan masih tetap seperti bulan sebelumnya	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan sebanyak 6% dari bulan sebelumnya	Total pasien dalam agustus mengalami peningkatan dari 3 bulan sebelumnya
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing, membuat	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatkan	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing

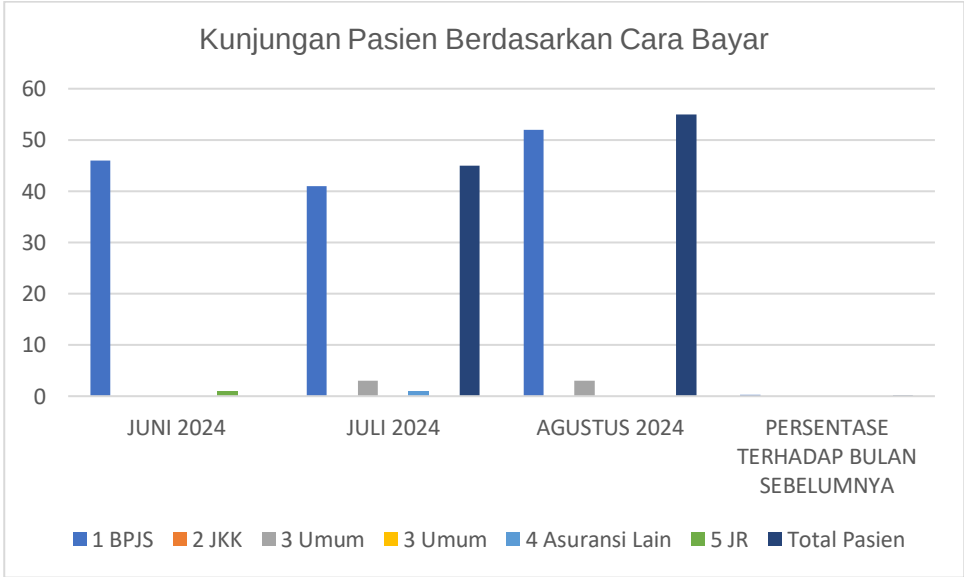
			program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	an pasien asuransi		
--	--	--	--	--------------------	--	--

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	46	41	52	↑21%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	0	3	3	0%
4	Asuransi Lain	0	1	0	↓ 100%
5	JR	1	0	0	0%
Total Pasien		46(karena pasien jr+BPJS)	45	55	↑18%

3.3.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)



3.3.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami peningkatan 11% (21 pasien)	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan agustus tetap jumlah pasien tetap	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan agustus 2024 tidak ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di ICU mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami peningkatan 18% (10 pasien)
2	RTL	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan	

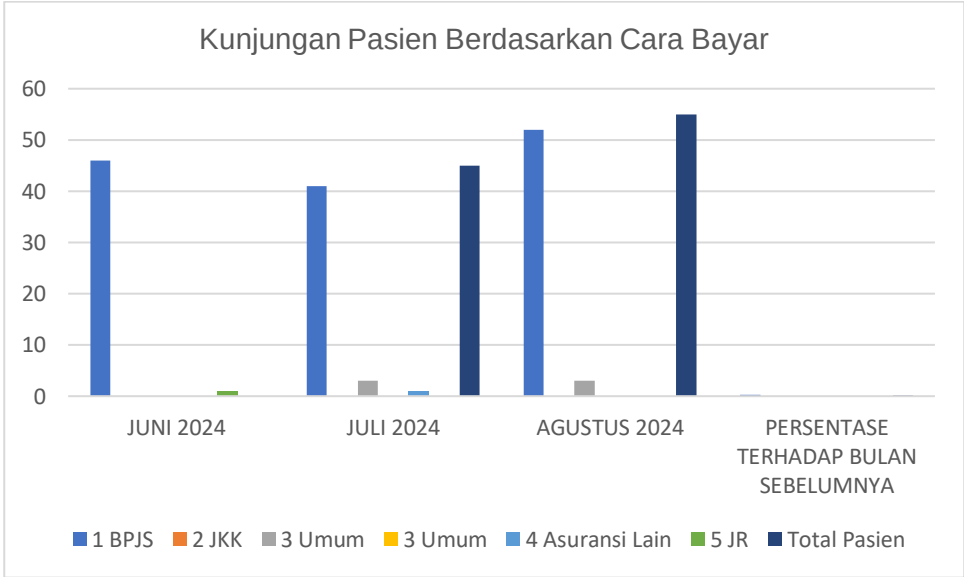
		asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	
--	--	---	---	---	---	--

3.3.4 High Care Unit (HCU)

3.3.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	16	7	9	↑21%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	0	0	0	0%
4	Asuransi Lain	0	0	0	↓ 100%
5	JR	1	0	0	0%
Total Pasien		16(karena pasien jr+BPJS)	7	9	↑18%

3.3.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)



3.3.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami peningkatan 11% (21 pasien)	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan agustus tetap jumlah pasien tetap	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan agustus 2024 tidak ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien yang ada di ICU mengalami peningkatan dan penurunan untuk bulan agustus mengalami peningkatan 18% (10 pasien)
2	RTL	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan	

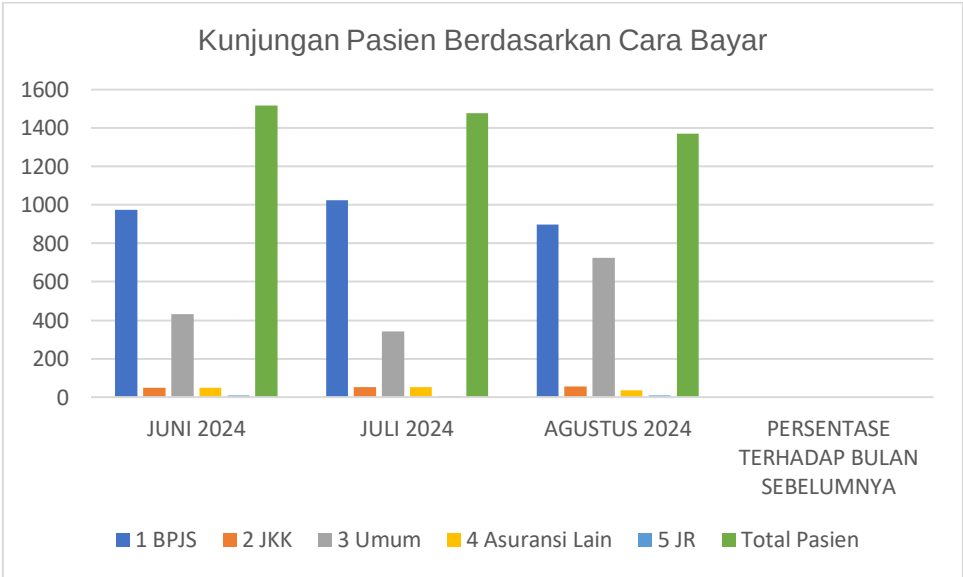
		asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	
--	--	---	---	---	---	--

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.3.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni - Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	976	1025	897	↓14%
2	JKK	49	52	56	↑7%
3	Umum	432	343	724	↑53%
4	Asuransi Lain	49	51	37	↓38%
5	JR	10	6	10	↑40%
Total Pasien		1516	1477	1370	↓8%

3.3.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni-Agustus 2024)



3.3.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN JULI	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan agustus mengalami penurunan 14%(128 pasien)	Kunjungan pasien UMUM 3 bulan terakhir belum stabil masih naik turun untuk bulan agustus pasien umum IGD meningkat 53% (381 pasien)	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan agustus meningkat 7% (4 pasien)	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan agustus mengalami 17,54% (10 pasien)	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan mengalami penurunan di bulan agustus mengalami penurunan 8%
2	RTL	Meningkatkan capaian	Meningkatkan capaian	Meningkatkan capaian	Meningkatkan capaian	Meningkatkan capaian

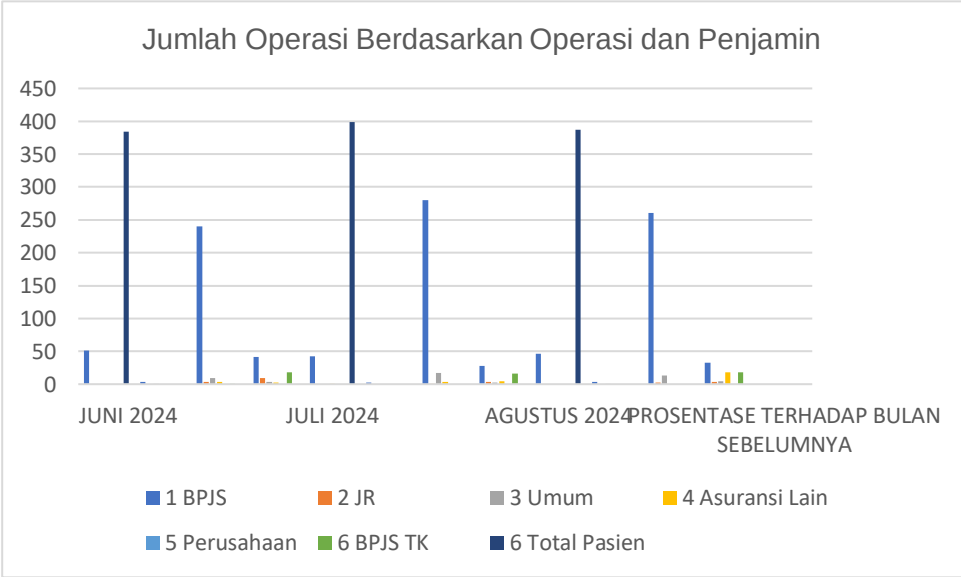
		kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)
--	--	---	---	--	--	--

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.3.6.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Juni-Agustus 2024)

NO	HAL	JUNI 2024				JULI 2024				AGUSTUS 2024				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		k	s	b	kh	k	s	b	kh	k	s	b	kh	
1	BPJS	51	3	240	41	42	2	280	28	46	3	261	33	
2	JR	0	0	3	9	0	0	1	3	0	0	2	3	
3	Umum	0	1	9	3	0	0	17	2	0	1	13	4	
4	Asuransi Lain	0	0	3	2	1	0	3	4	0	0	0	18	
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
6	BPJS TK	0	0	1	18	0	0	0	16	0	0	0	18	
	Total Pasien	384				399				387				↓3,0%

3.3.6.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Juni-Agustus 2024)



3.3.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami naik turun untuk bulan agustus 2024 mengalami penurunan 2,5% (9 pasien)	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan terakhir masih belum stabil untuk bulan agustus 2024 mengalami peningkatan 11,11% (2 pasien)	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir masih naik turun untuk bulan agustus 2024 mengalami penurunan 5,2% (1 pasien)	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan agustus meningkat 100%(1 pasien)	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan agustus 2024 meningkat 20% (1 pasien)	Total pasien untuk bulan agustus 2024 mengalami penurunan 3% (9 pasien)
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada					

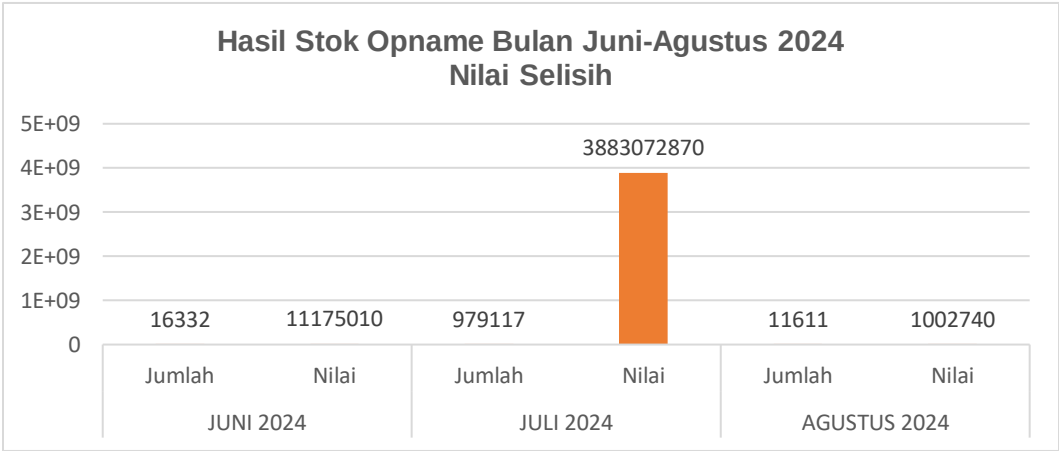
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

3.4.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Juni-Agustus 2024

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH SEDIAAN					
		JUNI 2024		JULI 2024		AGUSTUS 2024	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	819.115	2.593.871.439	836.069	3.131.198.853	732.380	2.267.670.139
	Sistem	827.882	2.613.227.305	0	0	732.927	2.285.414.509
	Selisih	8.767	-11.866	836.069	+3.131.198.853	547	-17.744.369
DEPO FARMASI	Fisik	136.177	513.147.816	141.263	656.152.980	147.379	519.778.015
	Sistem	129.153	493.659.843	0	0	136.326	510.064.361
	Selisih	7.024	+19.487.974	141.267	+656.152.980	11.053	+9.713.656
IKO	Fisik	1.733	77.805.982	1.781	95.721.037	2.479	111.929.273
	Sistem	2.017	85.864.060	0	0	2.490	102.895.820
	Selisih	284	-8.058.077	1.781	+95.721.037	11,00	+9.033.453
GUDANG RETUR	Fisik	0	0	0	0	0	0
	Sistem	257	243.021	0	0	0	0
	Selisih	257	-243.021	0	0	0	0
Total Selisih		16.332	+11.175.010	+979.117	+3.883.072.870	11.611	+1.002.740

3.4.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Juni-Agustus 2024



3.4.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

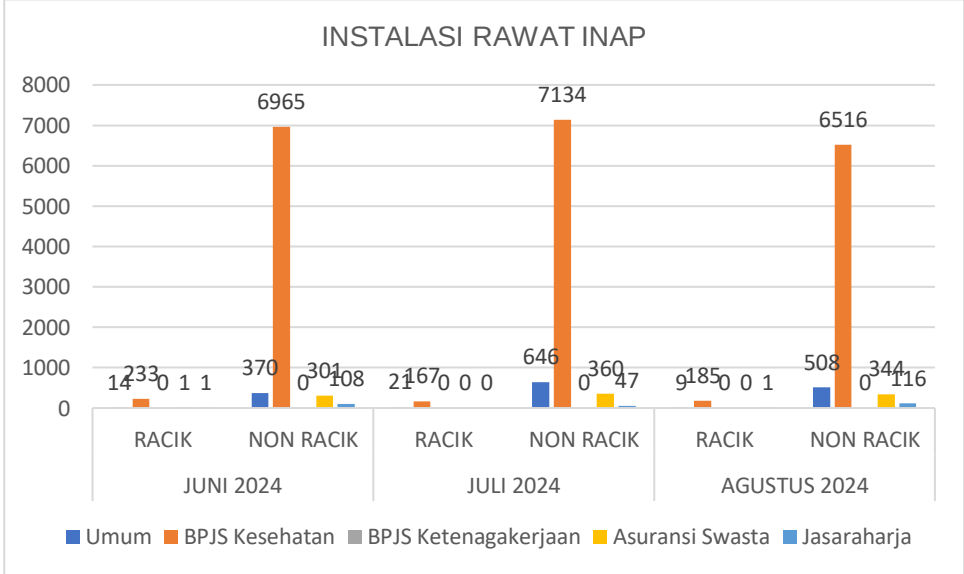
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar - 17.744.369 , hal ini disebabkan karena :		
1.	Master non-aktif muncul di lembar kerja SIMRS 1) F00067 Bactesyn 1.5g Inj 2) F00069 Benzatin Benzil Penicillin Serbuk Inj 2.400.000 3) F00142 Carnexid Inj 4) F00158 Cefotaxim Inj - Dexa 5) F00160 Ceftazidim Inj – Berno 6) F00159 Ceftazidim Inj – Dexa 7) F00162 Ceftizoxime Inj Berno 8) F00189 Ceropid Inj 9) F00194 Colinaar Inj 10) F00232 Cyclofem Inj 11) F00287 Omeprazole Inj 12) F00324 Foricef Inj 13) F00348 Granisentrone Inj 3 mg / 3 ml 14) F00374 Hyson Inj 15) F00404 Kalfoxim Inj 16) F00469 Mersibion 17) F00613 Picyn Inj 750 mg 18) F00627 Prazotec Inj 19) F00678 Rixone Inj 20) F00758 Tramal Inj 21) F00773 Ulceranin 22) F00821 Vascon Inj 23) F00834 Vitadion Inj	1. Update kertas kerja di sistem dan master barang. 2. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Gadis, Adel, Slamet). Lakukan croscek data inputan stok opname oleh TTK lainnya. Lakukan validasi data oleh apoteker setelah TTK input data stok opname. 3. Selisih stok akan dilakukan penelusuran dan penyesuaian stok opname.
2.	Terdapat ketidaksesuaian sistem dengan fisik 1) F01703 pds II vio 5/0 70 cm z1013h di rak benang (pada sistem terdapat stok 127 pcs, sedangkan fisik 0 karena kesalahan input so juli) 2) F00155 – cefoperazone sodium inj 1 g – mahakam (pada sistem jumlah stok ada 8 vial sedangkan fisik 0, terjadi karena adanya mapping / barang yang sudah non aktif namun diaktifkan kembali) 3) F02898 aquadest 20 l di rak b3 (terdapat selisih kurang 2 pcs karena lab belum merelease permintaan) 4) F00343 gliquidone tab 30 mg - ogb dexa di rak high alert (terdapat selisih kurang 400 pcs)	
3.	Terdapat adanya barang yang sama tetapi beda master barang 1) F01403 gelang pasien biru dewasa – one med dan F01405 gelang pasien dewasa biru di rak alkes (dinonaktifkan salah satu)	

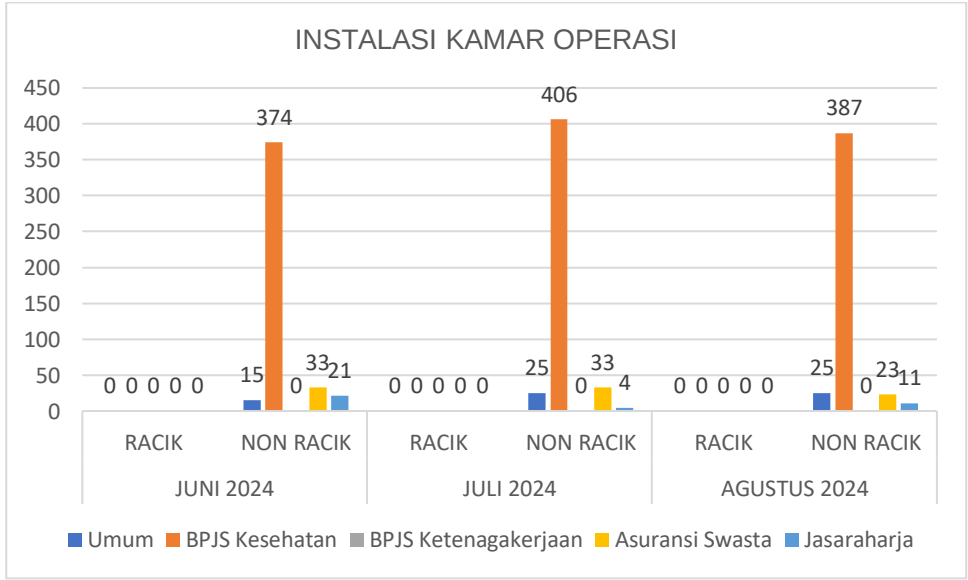
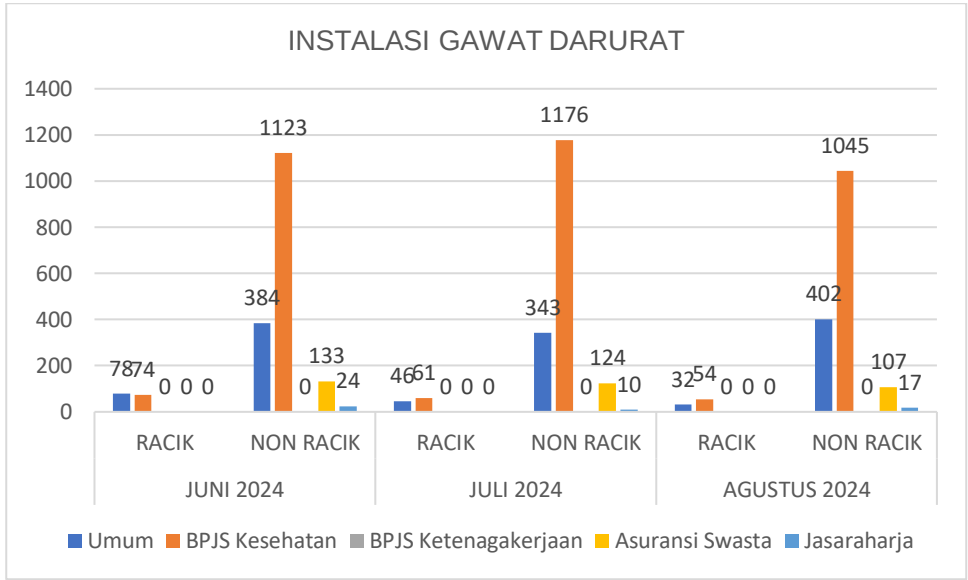
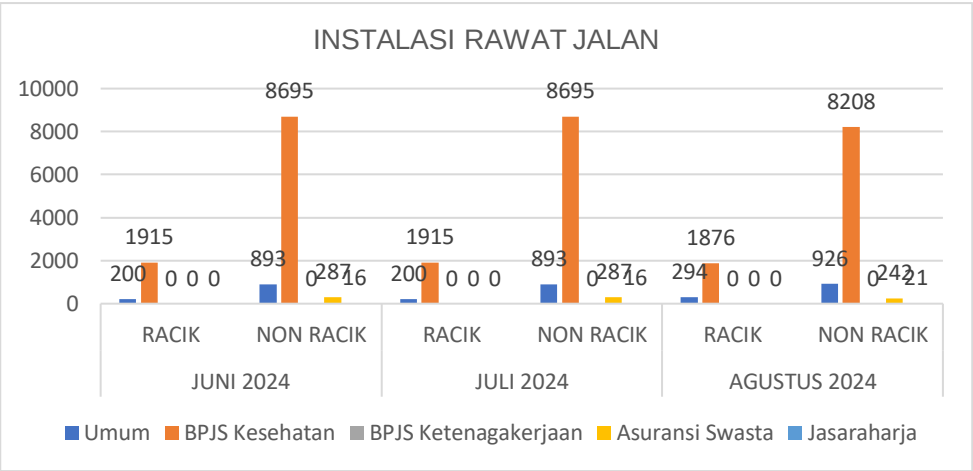
	2) F02329 kasa hydrofil steril uk. 16/16 dan F01529 kasa steril 16x16 cm – nasaco (dalam lembar kerja system). Kode F01529 di master barang : Sterimar baby spray (non aktif)	
Depo Farmasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +9.713.656 , hal ini disebabkan karena :		
1.	Master non-aktif muncul di lembar kerja SIMRS 1) F00067 Bactesyn Inj 1,5 g 2) F00069 Benzatin Benzil Penicillin Serbuk Inj 2.400.000 3) F00142 Carnexid Inj 4) F00158 Cefotaxim Inj - Dexta 5) F00160 Ceftazidim Inj – Berno 6) F00159 Ceftazidim Inj – Dexta 7) F00162 Ceftizoxime Inj Berno 8) F00189 Ceropid Inj 9) F00194 Colinaar Inj 10) F00232 Cyclofem Inj 11) F00287 Omeprazole Inj 12) F00324 Foricef Inj 13) F00348 Granisentrone Inj 3 mg/ 3 ml 14) F00374 Hyson Inj 15) F00404 Kalfoxim Inj 16) F00469 Mersibion 17) F00613 Picyn Inj 750 mg 18) F00627 Prazotec Inj 19) F00678 Rixone Inj 20) F00758 Tramal Inj 21) F00773 Ulceranin 22) F00821 Vascon Inj 23) F00834 Vitadione Inj	1. Update kertas kerja di sistem dan master barang oleh progamer. 2. Lakukan setiap pekerjaan sesuai SPO (evaluasi kinerja staff yaitu Ferra A.). Lakukan croscek data inputan stok opname oleh TTK lainnya. Lakukan validasi data oleh kepala instalasi setelah TTK input data stok opname. 3. Koordinasi Kains dengan pengadaan dan progamer untuk mengaktifkan master barang.
2.	Terdapat selisih 2 vial, karena stok yang diinput pada SO bulan Juli adalah picyn inj 750 mg, sementara dosis yang tersedia fisiknya adalah picyn 1.5 g.	
3.	Barang tidak ada master : 24) Pila venodenol. 25) Laminaria M.	
Instalasi Kamar Operasi Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar +9.033.453 , hal ini disebabkan karena :		
1.	Perawat utang input ke pasien sehingga terjadi selisih fisik kurang.	Dilakukan random stok setiap hari dan jika perawat utang input langsung koordinasi untuk segera input.
2.	Ditemukan barang tidak bertuan di IKO sehingga terjadi selisih fisik lebih.	Pengecekan barang tidak sesuai jumlah FS dilakukan setiap hari. Jika ditemukan barang tidak bertuan maka membuat berita acara untuk dimasukkan dalam system, jika terjadi selisih stok.
3.	Ditemukan salah input bmhp dan obat di simrs tidak sesuai barang yang terpakai.	Dilakukan random stok setiap hari dan jika perawat salah input langsung koordinasi untuk segera revisi inputan bmhp dan obat.
4.	Tidak ada rak Cairan inf gelafusal 500 ml (sehingga tidak masuk di stok opname) Fisik 2 flash, disistem 0.	Koordinasi Kains dan keuangan update rak dan kertas kerja.
Gudang Retur Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah mencapai target, namun masih ada kendala saat stok opname yaitu :		
1.	Tidak terdapat rak gudang retur.	Penyesuaian centralisasi master barang.

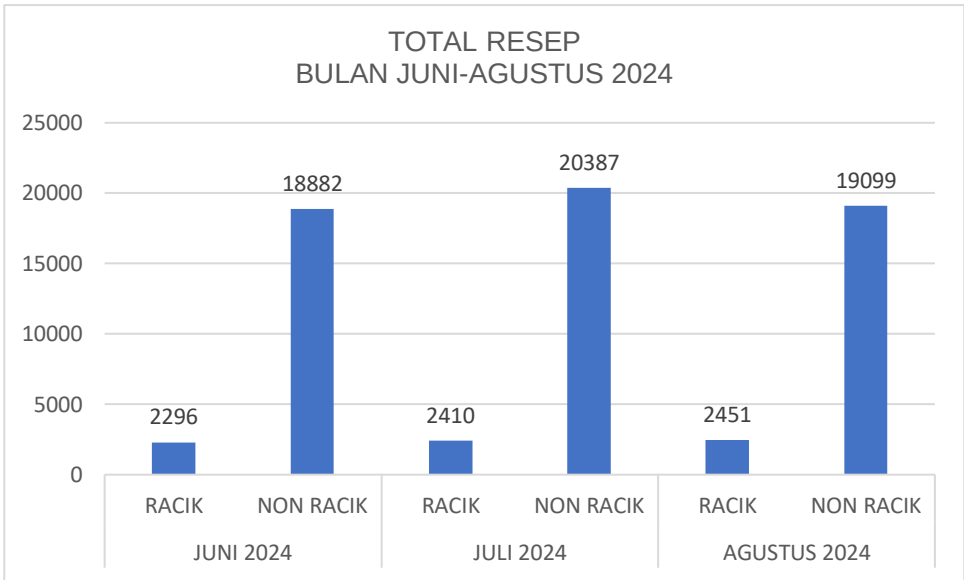
3.4.1.4 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Juni - Agustus 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN/JENIS RESEP					
			JUNI 2024		JULI 2024		AGUSTUS 2024	
			RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1.	IRNA	Umum	14	370	21	646	9	508
		BPJS Kesehatan	233	6965	167	7134	185	6516
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	1	301	0	360	0	344
		Jasaraharja	1	108	0	47	1	116
Total			249	7993	188	8375	195	7679
2.	IRJA	Umum	200	893	200	893	294	926
		BPJS Kesehatan	1915	8695	1915	8695	1876	8208
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	287	0	287	0	242
		Jasaraharja	0	16	0	16	0	21
Total			1895	8782	2115	9891	2170	9397
3.	IGD	Umum	78	384	46	343	32	402
		BPJS Kesehatan	74	1123	61	1176	54	1045
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	133	0	124	0	107
		Jasaraharja	0	24	0	10	0	17
Total			152	1664	107	1653	86	1577
4.	IKO	Umum	0	15	0	25	0	25
		BPJS Kesehatan	0	374	0	406	0	387
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	33	0	33	0	23
		Jasaraharja	0	21	0	4	0	11
Total			0	443	0	468	0	446
Total Resep			2296	18882	2410	20387	2451	19099

3.1.1.1 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Juni – Agustus 2024







Analisis :

1. Hasil jumlah resep selama 3 bulan mengalami penurunan jumlah resep di Bulan Agustus 2024.
2. Kunjungan pasien umum pada Bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Bulan Juli 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Juli 2024 sebanyak 2174 resep umum dan Bulan Agustus 2024 sebanyak 2196 resep umum.
3. Kunjungan pasien BPJS pada Bulan Agustus 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Bulan Juli 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Juli 2024 sebanyak 19554 resep BPJS dan Bulan Agustus 2024 sebanyak 17606 resep BPJS.
4. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasaraharja pada Bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan tidak signifikan jika dibandingkan dengan Bulan Juli 2024, dengan total resep yaitu : Bulan Juli 2024 sebanyak 881 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja dan Bulan Agustus 2024 sebanyak 882 resep Asuransi Swasta dan Jasaraharja .
5. Secara keseluruhan total resep pada Bulan Agustus 2024 mengalami penurunan dan berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien ke RS.

Rencana Tindak Lanjut :

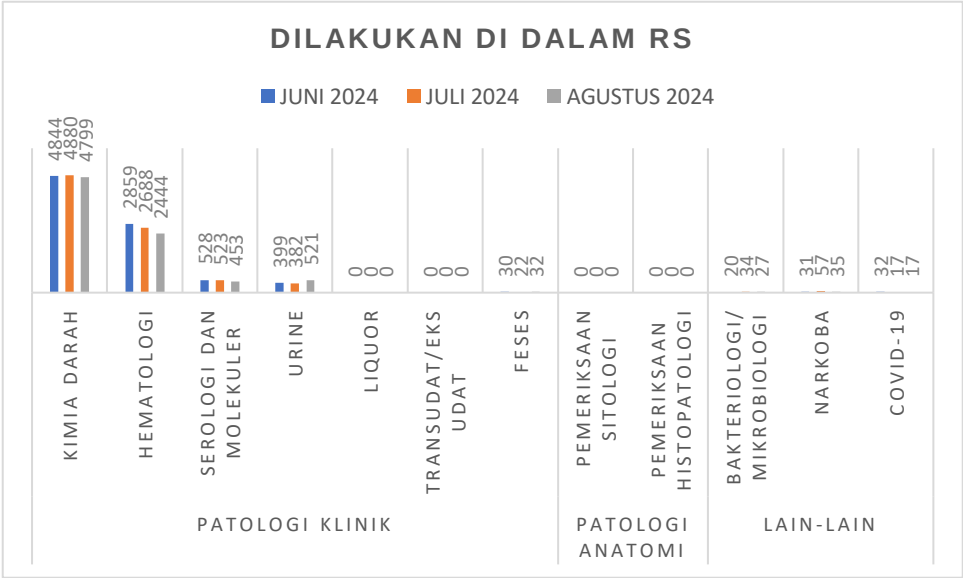
1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di social media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
3. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
4. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal.

3.1.2 Laboratorium

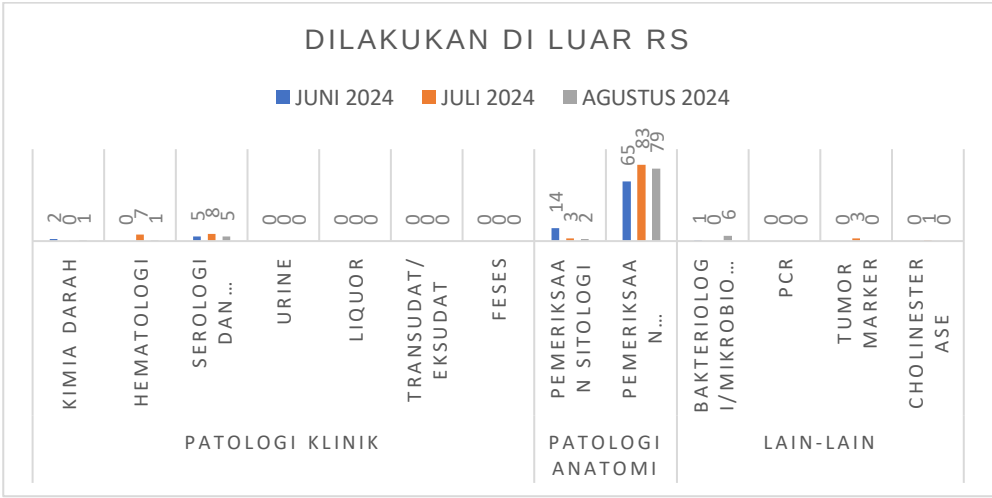
3.1.2.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Juni - Agustus 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
Dilakukan di RS				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4844	4880	4799
	Hematologi	2859	2688	2444
	Serologi dan Molekuler	528	523	453
	Urine	399	382	521
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	30	22	32
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	20	34	27
4.	Narkoba	31	57	35
5.	Covid-19	32	17	17
Dirujuk				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	2	0	1
	Hematologi	0	7	1
	Serologi dan Molekuler	5	8	5
	Urine	0	0	0
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	0	0	0
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	14	3	2
	Pemeriksaan Histopatologi	65	83	79
3.	Bakteriologi/Mikrobiologi	1	0	6
4.	PCR	0	0	0
5.	Tumor Marker	0	3	0
6.	Cholinesterase	0	1	0

3.1.2.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit



3.1.2.3 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit



Analisis :

- 1. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, rincian Bulan Agustus 2024 yaitu :
 - a) Patologi Anatomi : 81 sampel
 - b) Patalogi Klinik : 7 sampel
 - c) Bakteri/Mikrobiologi : 6 sampel
- 2. Terjadi peningkatan pemeriksaa urine pada Bulan Agustus 2024, yaitu Bulan Juli 2024 sebanyak 382 pemeriksaan sedangkan Bulan Agustus 2024 sebanyak 521 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena DS Penyakit Dalam mengadvicekan pasien untuk melakukan pemeriksaan urine lengkap guna melihat glukosa didalam urine.

Rencana Tindak Lanjut

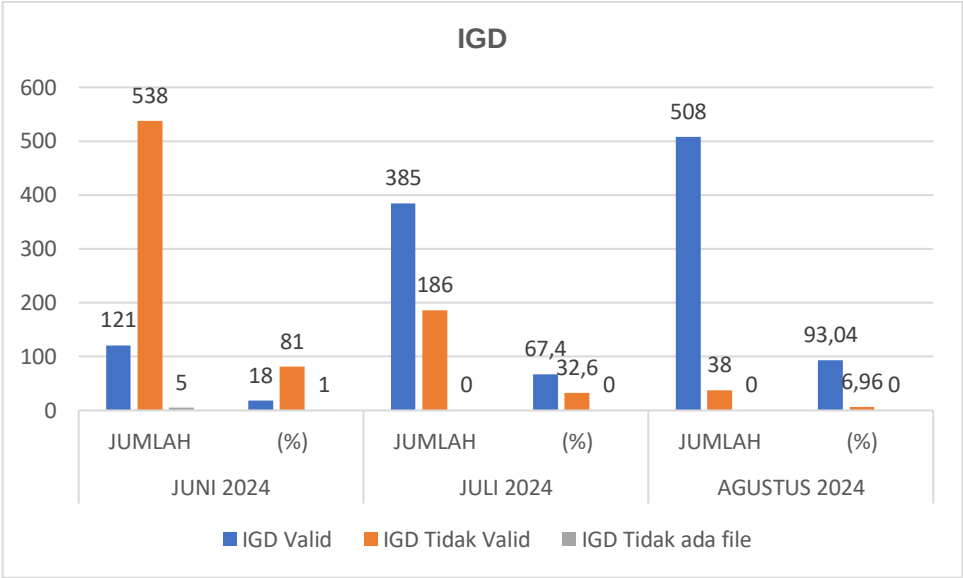
- 1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan BDRS di RS Prima Husada Malang, untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu.
- 2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 3. Perbaiki serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- 4. Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok.

3.1.3 Rekam Medis – Pendaftaran

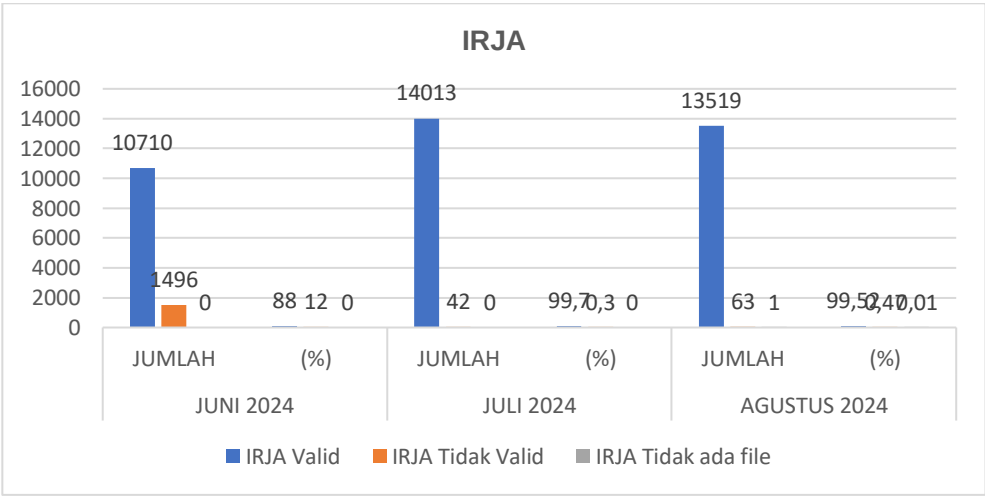
3.1.3.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Juni-Agustus 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			JUNI 2024		JULI 2024		AGUSTUS 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	121	18	385	67,4	508	93,04
		Tidak Valid	538	81	186	32,6	38	6,96
		Tidak ada file	5	1	0	0	0	0
		Total	664		571		546	
2.	IRJA/POLI	Valid	10710	88	14013	99,7	13519	99,52
		Tidak Valid	1496	12	42	0,3	63	0,47
		Tidak ada file	0	0	0	0	1	0,01
		Total	12206		14055		13583	

3.1.3.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Juni - Agustus 2024



3.1.3.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Juni - Agustus 2024



Analisis :

1. Terjadi kenaikan signifikan pada data valid di IGD sebanyak 508 Data E-RM dari 546 Data E-RM atau sebesar 93.04%, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyetoran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD.
2. Masih ditemukan 6.96% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis, setelah ditelusur sudah pengkajian awal IGD sudah diisi lengkap tetapi tidak terbaca, system bermasalah.
3. Terjadi peningkatan tidak signifikan data tidak valid di IRJA, tetapi tidak lebih dari 1%. Ditemukan 1 berkas yang tidak ada file, hal ini disebabkan inputan perawat tidak muncul di RM sehingga tidak bisa dilakukan validasi.

Masalah :

1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
2. Permasalahan di IGD tidak bisa diperbaiki langsung karena tidak bisa batal kunjungan, pembatalan harus melalui PT.
3. Berikut link permasalahan yang ditemui

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

Ketidaklengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :

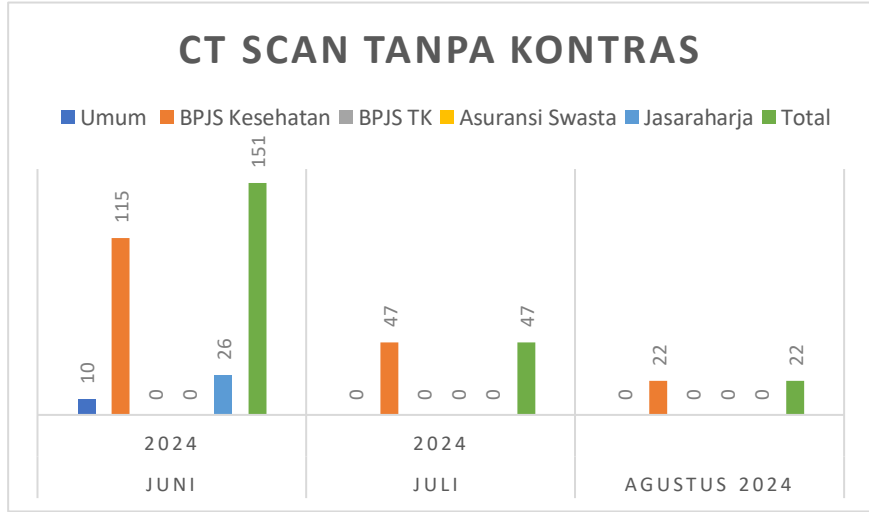
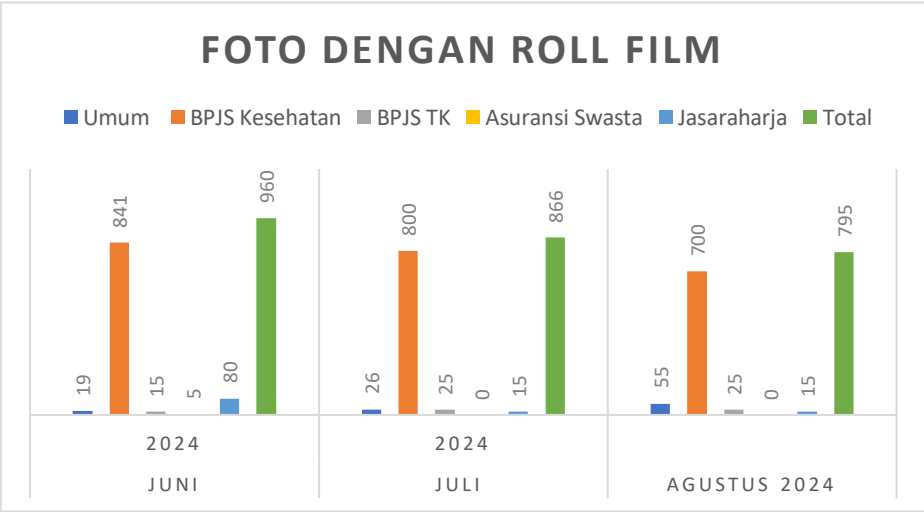
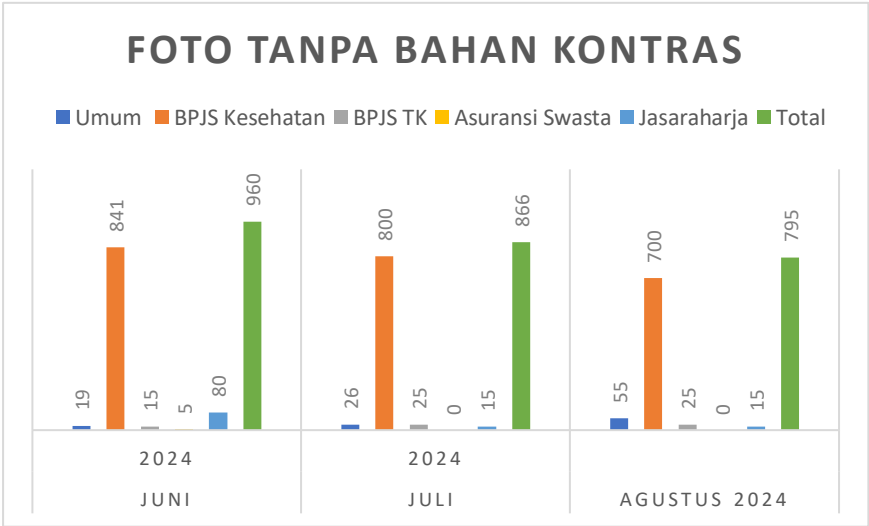
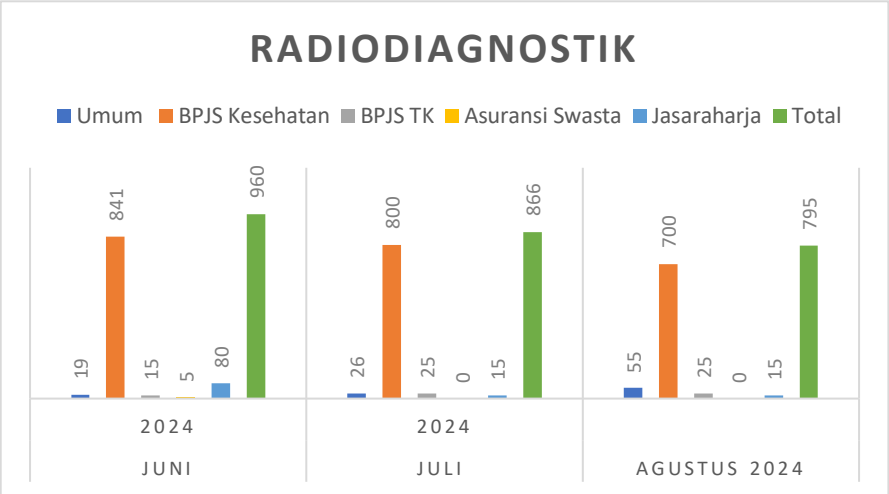
- 1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
- 2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
- 3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

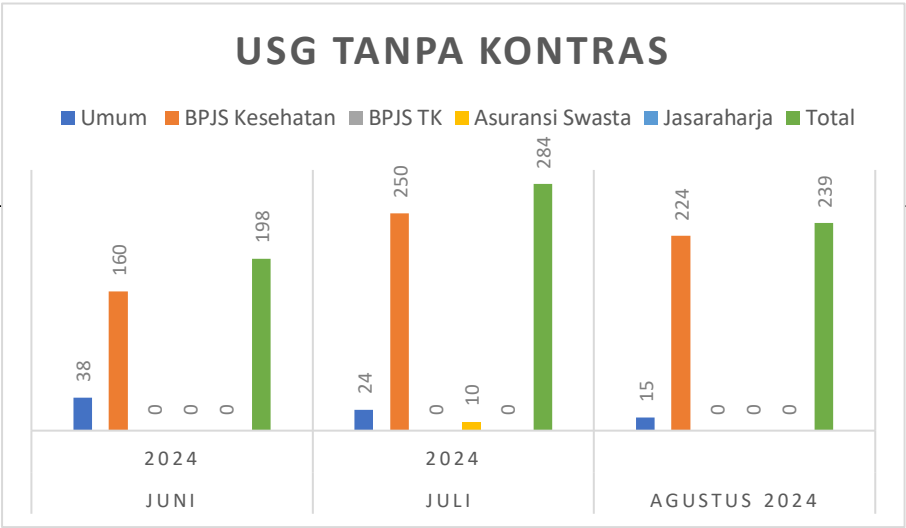
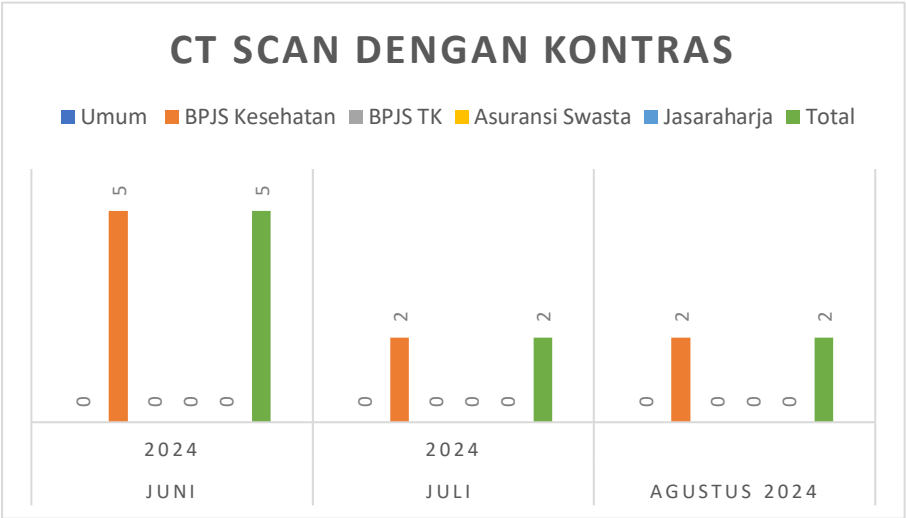
3.1.4 Radiologi

3.1.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni - Agustus 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
1.	Radiodiagnostik	Umum	19	26	55
		BPJS Kesehatan	841	800	700
		BPJS TK	15	25	25
		Asuransi Swasta	5	0	0
		Jasaraharja	80	15	15
TOTAL			960	866	795
2.	Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	19	26	55
		BPJS Kesehatan	841	800	700
		BPJS TK	15	25	25
		Asuransi Swasta	5	0	0
		Jasaraharja	80	15	15
TOTAL			960	866	795
3.	Foto Dengan Rol Film	Umum	19	26	55
		BPJS Kesehatan	841	800	700
		BPJS TK	15	25	25
		Asuransi Swasta	5	0	0
		Jasaraharja	80	15	15
TOTAL			960	866	795
4.	CT Scan Tanpa Kontras	Umum	10	0	0
		BPJS Kesehatan	115	47	22
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	26	0	0
TOTAL			151	47	22
5.	CT Scan Dengan Kontras	Umum	0	0	0
		BPJS Kesehatan	5	2	2
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	0	0
		Jasaraharja	0	0	0
TOTAL			5	2	2
6.	USG Tanpa Kontras	Umum	38	24	15
		BPJS Kesehatan	160	250	224
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	10	0
		Jasaraharja	0	0	0
TOTAL			198	284	239

3.1.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni - Agustus 2024





Analisis :

- Pelayanan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 795
 - USG Tanpa Kontras : 239
 - CT Scan Tanpa Kontras : 22
- Pada Bulan Agustus 2024 pemeriksaan CT Scan mengalami penurunan secara signifikan, hal ini disebabkan karena alat CT Scan rusak mulai Bulan Juli 2024 dan baru bisa digunakan per tanggal 24 Agustus 2024.
- Jumlah pemeriksaan CT Scan yang dirujuk sebagai berikut :
 - RSUD Lawang : 14 pasien
 - RSPH Sukorejo : 5 pasien
- Pasien yang membutuhkan pemeriksaan CT Scan di Poli Spesialis dijadwalkan menunggu kondisi CT Scan PHM bisa digunakan, kecuali kondisi pasien cito.
- Ditemukan peningkatan kunjungan pasien umum pada pemeriksaan radiodiagnostik, peningkatan 100% sebanyak 55 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

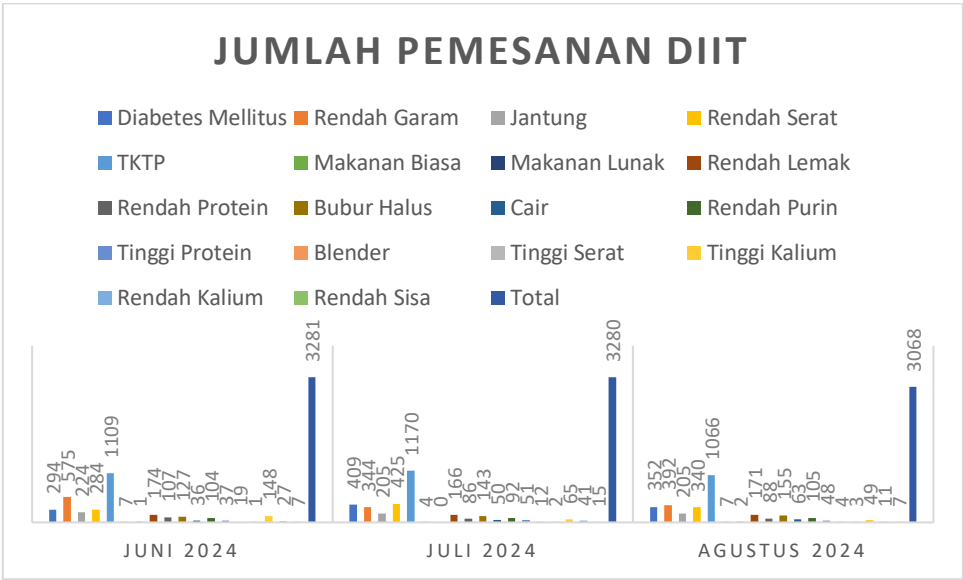
- 1. Koordinasi dengan ATEM PT untuk pengajuan hardware baru demi menunjang pelayanan yang komprehensif, penggantian CIRS sudah dilakukan oleh PT Philips dan PT Berca pada tanggal 24 Agustus 2024.
- 2. Koordinasi dengan IPSRS untuk melakukan pemeliharaan alat secara berkala.
- 3. Koordinasi dengan Humas&Marketing untuk melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan, jika CT Scan sudah bisa digunakan.

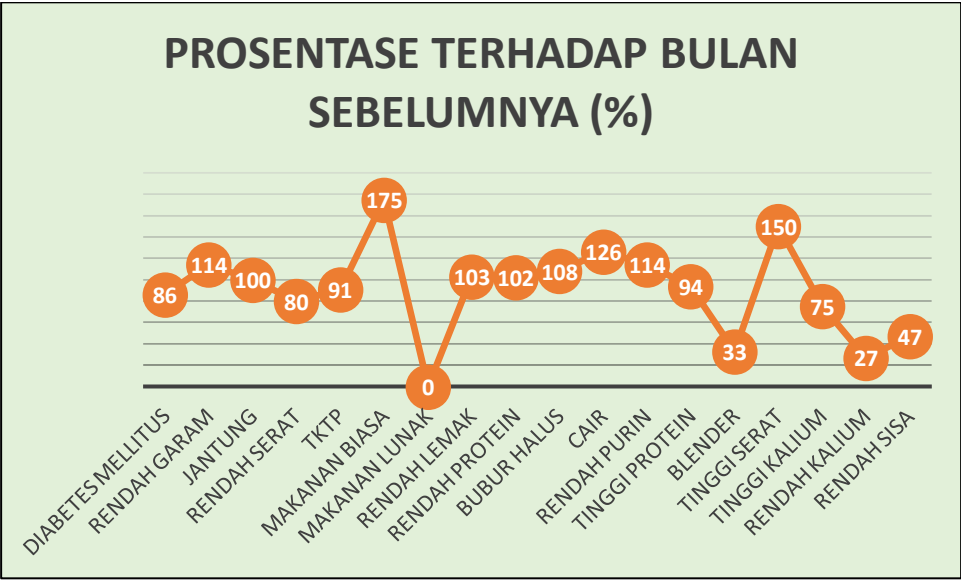
4.4.5 Gizi

4.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Juni - Agustus 2024

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIIT			PRESENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024	
1.	Diabetes Melitus	294	409	352	86
2.	Rendah Garam	575	344	392	114
3.	Jantung	224	205	205	100
4.	Rendah serat	284	425	340	80
5.	TKTP	1109	1170	1066	91
6.	Makanan biasa	7	4	7	175
7.	Makanan Lunak	1	0	2	0
8.	Rendah Lemak	174	166	171	103
9.	Rendah Protein	107	86	88	102
10.	Bubur Halus	127	143	155	108
11.	Cair	36	50	63	126
12.	Rendah Purin	104	92	105	114
13.	Tinggi Protein	37	51	48	94
14.	Blender	19	12	4	33
15.	Tinggi serat	1	2	3	150
16.	Tinggi Kalium	148	65	49	75
17.	Rendah Kalium	27	41	11	27
18.	Rendah Sisa	7	15	7	47
TOTAL		3281	3280	3068	94

4.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Juni - Agustus 2024





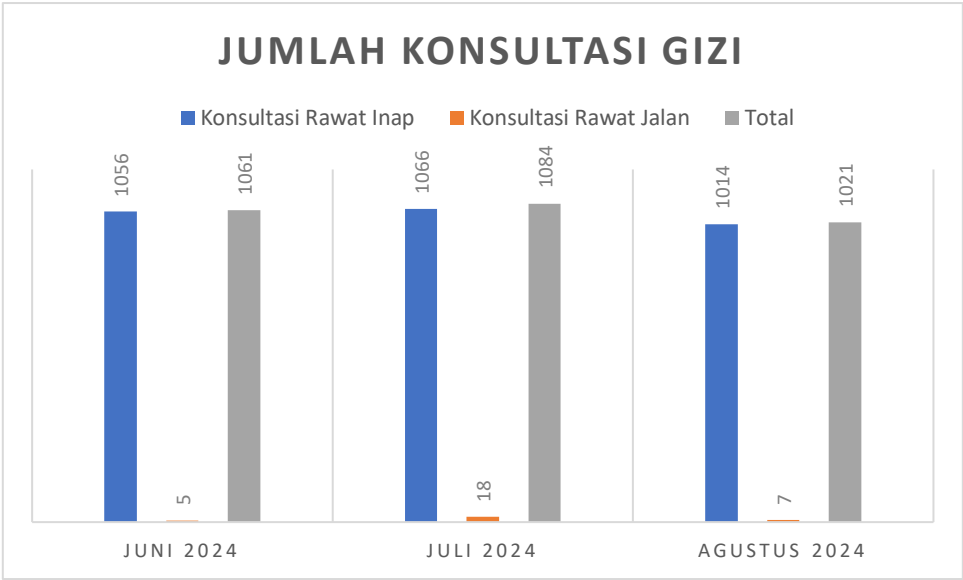
Analisis :
Dari grafik jumlah pemesanan diit diatas, jumlah pemesanan stabil dalam 2 bulan terakhir. Jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP dan berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien rawat inap yang tidak signifikan. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan, menu rawon sudah diperbaiki dengan ditambahkan daging sapi sebagai protein hewani.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
 2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.

4.4.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi Juni - Agustus 2024

NO	INDIKASI	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
1.	Konsultasi Rawat Inap	1056	1066	1014
2.	Konsultasi Rawat Jalan	5	18	7
Total		1061	1084	1021

4.4.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi Juni - Agustus 2024



Analisis :

- 1. Data jumlah konsultasi gizi pada pasien rawat inap terjadi penurunan tetapi tidak signifikan, berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
- 2. Data jumlah konsultasi gizi pada rawat jalan mengalami penurunan, yaitu 7 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU Gizi.
- 3. Menjalankan Prima Health Meals.

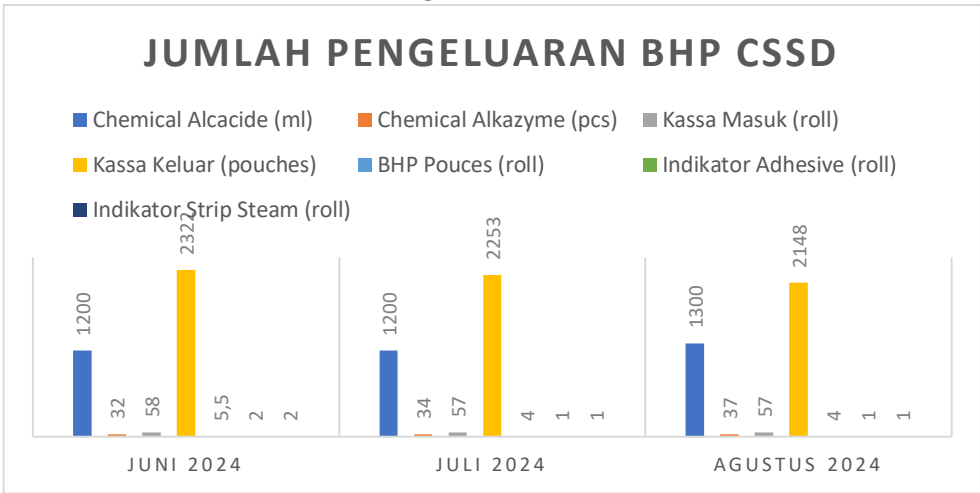
4.4.6 CSSD – Laundry

4.4.6.1 CSSD

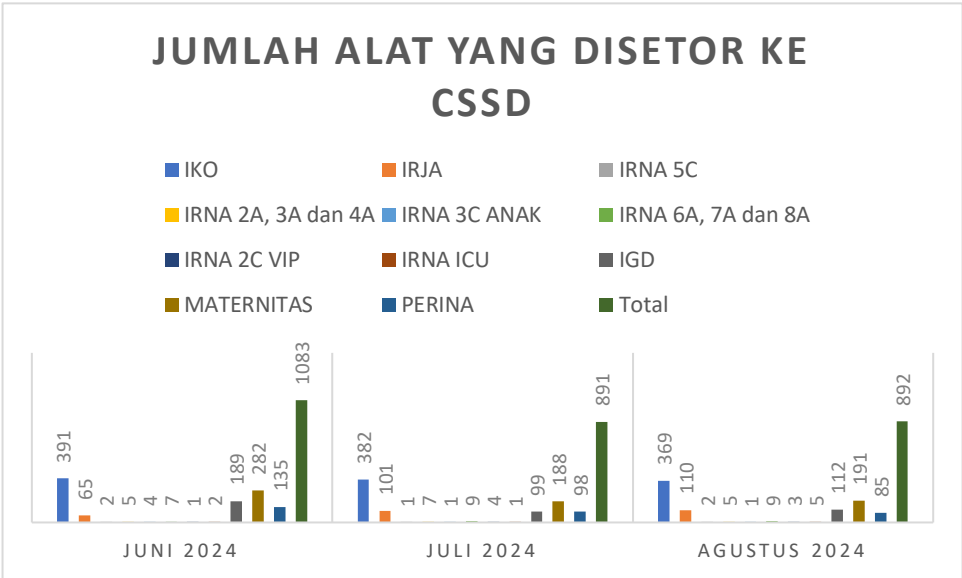
4.4.6.1.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan Juni - Agustus 2024

NO	HAL	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
BHP				
1	Chemical Alcalide (ml)	1200	1200	1300
2	Chemical Alkazyme (pcs)	32	34	37
3	Kassa Masuk (roll)	58	57	57
4	Kassa Keluar (pouches)	2322	2253	2148
5	BHP Pouces (roll)	5.5	4	4
6	Indikator Adhesive (roll)	2	1	1
7	Indikator Strip Steam (roll)	2	1	1
Alat yang disetor (set)				
8	Unit IKO	391	382	369
9	IRJA	65	101	110
10	IRNA 5C	2	1	2
11	IRNA 2A, 3A dan 4A	5	7	5
12	IRNA 3C ANAK	4	1	1
13	IRNA 6A, 7A dan 8A	7	9	9
14	IRNA 2C VIP	1	4	3
15	IRNA ICU	2	1	5
16	IGD	189	99	112
17	MATERNITAS	282	188	191
18	PERINA	135	98	85
Jumlah		1083	891	892

4.4.6.1.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan Juni - Agustus 2024



4.4.6.1.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan Juni – Agustus 2024



Analisis :

- 1. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terakhir yaitu sejumlah 1.142 set, diikuti dari Unit Maternitas 661 set dan IGD 400 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
- 2. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid, namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.
- 3. Terjadi peningkatan penggunaan alat di IGD dan IRJA, karena pasien rawat luka bertambah.
- 4. Peningkatan penggunaan chemical berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan alat di unit yang terbanyak melakukan tindakan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
- 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
- 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.

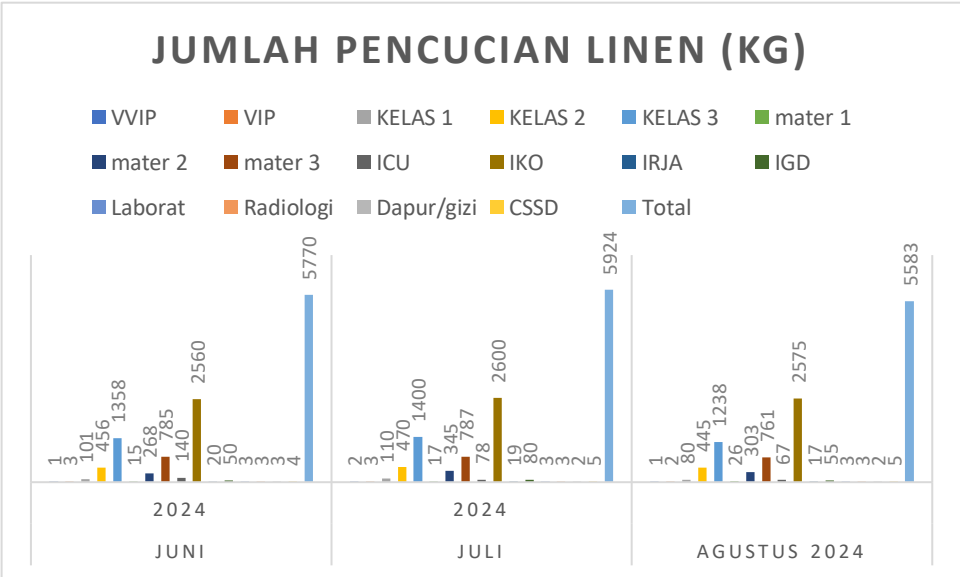
4.4.6.2 Laundry

4.4.6.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Juni – Agustus 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN (KG)		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
1	VVIP	1	2	1
2	VIP	3	3	2
3	KELAS 1	101	110	80
4	KELAS 2	456	470	445
5	KELAS 3	1358	1400	1238
6	mater 1	15	17	26
7	mater 2	268	345	303
8	mater 3	785	787	761
9	ICU	140	78	67

10	IKO	2560	2600	2575
11	IRJA	20	19	17
12	IGD	50	80	55
13	Laborat	3	3	3
14	Radiologi	3	3	3
15	Dapur/gizi	3	2	2
16	CSSD	4	5	5
TOTAL		5770	5924	5583

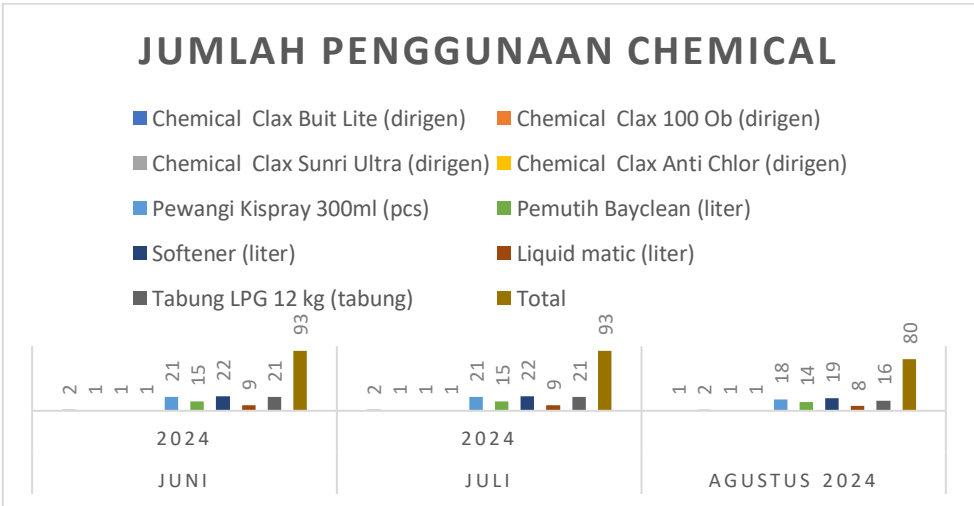
4.4.6.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Bulan Juni - Agustus 2024



4.4.6.2.3 Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan Juni - Agustus 2024

NO	ASAL UNIT	JUMLAH PER BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
1	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	2	1
2	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	1	1	2
3	Chemical Clax Sunri Ultra (dirigen)	1	1	1
4	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1	1	1
5	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	21	21	18
6	Pemutih Bayclean (liter)	15	15	14
7	Softener (liter)	22	22	19
8	Liquid matic (liter)	9	9	8
9	Tabung LPG 12 kg (tabung)	21	21	16
TOTAL		93	93	93

4.4.6.2.4 Grafik Jumlah Penggunaan Chemical Laundry Bulan Juni – Agustus 2024



Analisa :

- 1. Terdapat penurunan jumlah pencucian linen dari bulan sebelumnya yaitu sebanyak 341kg, berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap, dan sebanding dengan penggunaan chemical yang juga mengalami penurunan.
- 2. Dalam 3 bulan terakhir jumlah pencucian linen terbanyak dari Unit IKO mencapai rata-rata angka 2578kg setiap bulannya, hal ini disebabkan jumlah operasi per hari bisa mencapai diatas 5 operasi dengan operator yang berbeda dan diikuti dari ruang perawatan kelas 3, yaitu mencapai rata-rata angka 1332kg setiap bulannya.
- 3. Pencatatan penimbangan linen menggunakan timbangan beras masih manual, resiko angka tidak terbaca dengan baik, sehingga jumlah yang dihasilkan kurang valid.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Rencana akan dilakukan permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan.
- 2. Rencana akan dilakukan pencatatan menggunakan google spreadsheet per hari nya.

4.5 Kinerja Umum dan Keuangan

4.5.5 SDM

3.5.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	43	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	0	4	0
		S1 Analis Farmasi		1	0	1	0
		D3 Farmasi		16	4	12	0
		SMK		7	0	7	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis		8	0	8	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
		SMK		2	1	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	4	1	2	1
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		3	0	3	0

		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	26	11	1	10	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Kebidanan		3	0	3	0
		D3 Kebidanan		2	0	2	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	S1 Teknik Elektro	6	1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	6	3	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		16	6	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 3A & 4A	Profesi Ners	20	16	0		
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A & 7A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0
28	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	0	8	0

29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	6	2	1	1	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekteraris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	2	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
		SMP		5	0	4	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		2	0	2	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesilais Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
51	Dokter Spesialis THT-KL	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0

53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Gigi Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Gigi Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Gigi Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Umum	Pendidikan Profesi Dokter	8	8	1	7	0
Total			471				

Keterangan :
Pada bulan Agustus terdapat penambahan staf pada Unit Farmasi (apoteker 1 orang), Unit Rehab Medis (Fisioterapis 1 orang)

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1		
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1		
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1		

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	01 Agustus 2024	Orientasi Khusus	Apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm	Profesi Apoteker	Apoteker	01 Agustus 2024	Karyawan baru
2	01 Agustus 2024	Orientasi Khusus	Amalia Lusyanti, A.Md.Kes	D3 Fisioterapis	Fisioterapis	01 Agustus 2024	Karyawan baru
3	01 Agustus 2024	Orientasi Khusus staf Mutasi	Moch. Mas'ud, A.Md.Kep	D3 Keperawatan	Perawat	01 Agustus 2024	Karyawan mutasi dari MS PTP
4	01 Agustus 2024	Orientasi Khusus staf Mutasi	Slamet Budiono, S.Ak	S1 Akuntansi	Akuntan	01 Agustus 2024	Karyawan mutase dari PT DPM

Keterangan : Pada bulan Juni 2024 tidak terdapat orientasi khusus staf baru

3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	12 Agustus 2024	Internal – ToT	Training of Trainer Pelatihan NICU	Seluruh perawat pelaksana sejumlah 46	Dihadiri oleh 40 peserta	Membagikan materi ToT kepada peserta.
2	21 Agustus 2024	Internal	MFK	Seluruh karyawan sejumlah 422	Dihadiri oleh 300 peserta	Membagikan materi kepada karyawan.

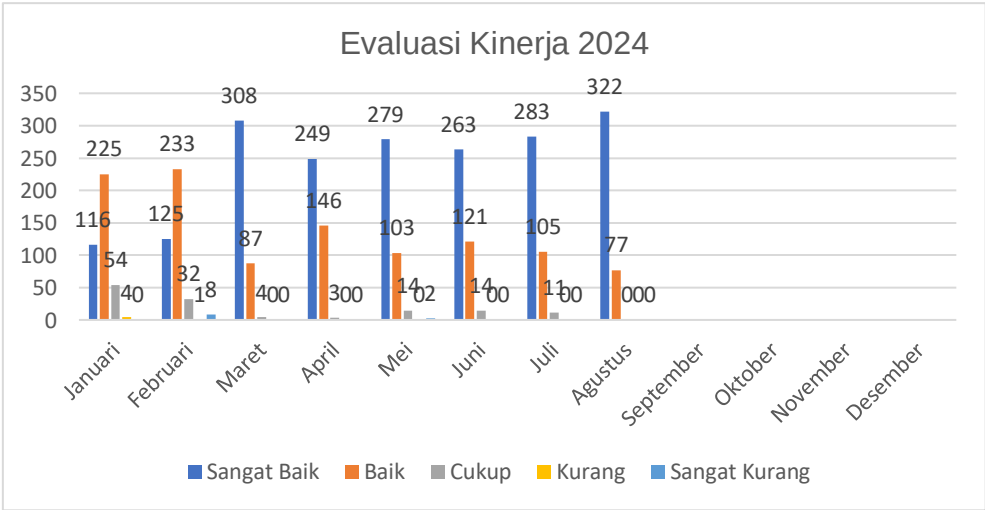
Keterangan :

Pada bulan Agustus 2024 terdapat 2 pelaksanaan diklat internal yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	KATEGORI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Sangat Baik	116	125	308	249	279	263	283	322
2	Baik	225	233	87	146	103	121	105	77
3	Cukup	54	32	4	3	14	14	11	0
4	Kurang	4	1	0	0	0	0	0	0
5	Sangat Kurang	0	8	0	0	2	0	0	0

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :
Peningkatan pada kategori “sangat baik”, tertinggi selama Januari-Agustus 2024 dan nominal kategori “cukup”, “kurang”, “sangat kurang” adalah 0

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 3. Mempertahankan staf yang masih terlambat

3.5.1.6 Konseling
3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024

NO	JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Konseling	0	13	11	12	5	2	8	20

Analisis :
18 konseling adalah tentang kontrak N-ED dan 2 konseling terkait tata tertib

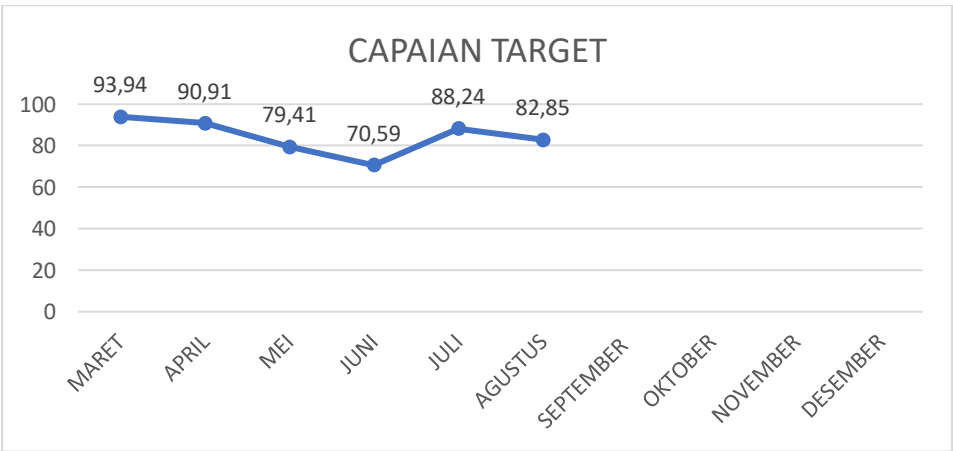
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.2 MFK dan K3RS
3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

NO	KET	TARGET	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Capaian Maintenance	90%	93,94	90,91	79.41	70.59	88.24	82.85



Analisis :
Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis klinik Mutiara sehat.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Follow up ke Karu/Ka unit untuk memberikan info ketika alat medis yang belum di maintenance tidak dalam kondisi dipakai.
- 2. Koordinasi dengan PT untuk wewenang alat medis klinik

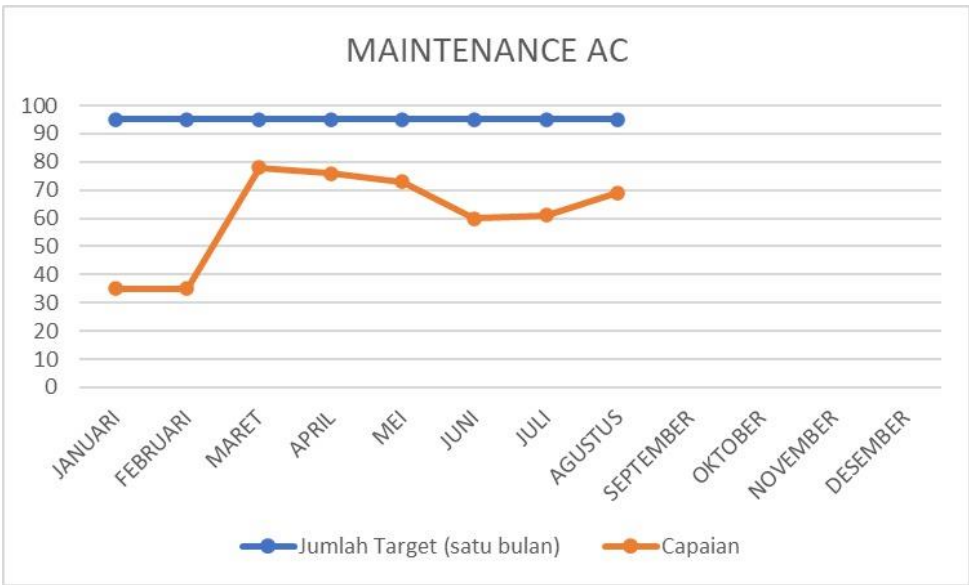
3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

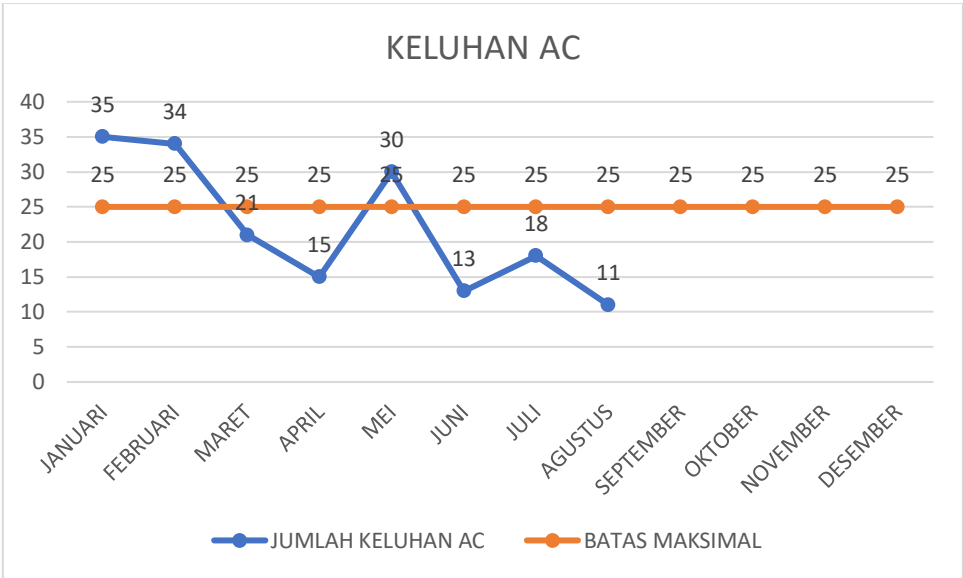
3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	JANUARI	95	54	57%	BELUM MENCAPAI TARGET
2	FEBRUARI	95	69	73%	BELUM MENCAPAI TARGET
3	MARET	95	94	99%	BELUM MENCAPAI TARGET
4	APRIL	95	61	64%	BELUM MENCAPAI TARGET
5	MEI	95	94	99%	BELUM MENCAPAI TARGET
6	JUNI	95	89	94%	BELUM MENCAPAI TARGET
7	JULI	95	60	63%	BELUM MENCAPAI TARGET
8	AGUSTUS	95	69	72%	BELUM MENCAPAI TARGET

3.5.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintenance AC



3.5.2.2.1.3 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



Analisis :
Sudah terdapat progress perbaikan yang baik terhadap pemeliharaan AC baik secara fisik maupun pelaporan ini berdampak pada keluhan staf di unit terhadap AC mulai berkurang. Pada bulan ini berada pada angka 11 laporan keluhan, masih dibawah batas maksimal yaitu 25 keluhan, sehingga progress bulan ini sudah baik namun perlu perhatian pada bulan September agar grafik tidak meningkat.

Beberapa penyebab yang mengakibatkan target maintenance masih tidak tercapai :

- 1. Adanya tugas insidental diluar jadwal IPSRS RSPHM
- 2. AC ruangan masih terdapat pasien / dalam pemakaian

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan evaluasi terutama terkait sistem pencatatan dan target perbulan.
- 2. Pembuatan aplikasi 47ocal IPSRS sebagai reminder

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Tidak mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Tidak mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Tidak mencapai target

Analisis :
Pada bulan Agustus, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	3x/bulan	2x/bulan	67%	Sudah mencapai target
4	April	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 3x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervisi, petugas sudah berkeliling dan melakukan pencatatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

TANGGAL	STOK LIQUID	SEBELUM PENGISIAN	PENGUNAAN	SATUAN	KETERANGAN	PENGIRIMAN
01/08/2024	3335	3045	290	MMHG		
02/08/2024	3045	2788	257	MMHG		
03/08/2024	2788	2567	221	MMHG		
04/08/2024	2567	2405	162	MMHG		
05/08/2024	2405	2217	188	MMHG		
06/08/2024	2217	2066	151	MMHG		
07/08/2024	2066	1887	179	MMHG		
08/08/2024	1887	1520	367	MMHG	SEBELUM PENGISIAN	
08/08/2024	1368	3178		MMHG	SESUDAH PENGISIAN	1810
09/08/2024	3178	3057	121	MMHG		
10/08/2024	3057	2850	207	MMHG		
11/08/2024	2850	2707	143	MMHG		
12/08/2024	2707	2467	240	MMHG		
13/08/2024	2467	2245	222	MMHG		
14/08/2024	2245	1997	248	MMHG		
15/08/2024	1997	1745	252	MMHG		
16/08/2024	1745	1334	411	MMHG	SEBELUM PENGISIAN	
16/08/2024	1334	3252		MMHG	SESUDAH PENGISIAN	1918
17/08/2024	3252	3058	194	MMHG		
18/08/2024	3058	2881	177	MMHG		
19/08/2024	2881	2667	214	MMHG		
20/08/2024	2667	2356	311	MMHG		
21/08/2024	2356	2074	282	MMHG		
22/08/2024	2074	1810	264	MMHG		

23/08/2024	1810	1484	326	MMHG	SEBELUM PENGISIAN		
23/08/2024	1484	3377		MMHG	SESUDAH PENGISIAN	1969	
24/08/2024	3377	3087	290	MMHG			
25/08/2024	3087	2967	120	MMHG			
26/08/2024	2967	2760	207	MMHG			
27/08/2024	2760	2568	192	MMHG			
28/08/2024	2568	2250	318	MMHG			
29/08/2024	2250	1990	260	MMHG			
30/08/2024	1990	1740	250	MMHG			
31/08/2024	1740	1368	372	MMHG			
			0	MMHG			
			0	MMHG			
			0	MMHG			
			0	MMHG			
			0	MMHG			
			0	MMHG			
			0	MMHG			
			6668	MMHG			
JUMLAH TOTAL PENGISIAN LIQUID OKSIGEN BULAN INI						5697	MMHG
RATA-RATA PENGGUNAAN OKSIGEN PER HARI			395,5	MMHG			
RATA- RATA PENGISIAN LIQUID PER BULAN INI						2848,5	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Pemeliharaan IPAL	1x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Pemeliharaan filter air	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Pemeliharaan lift	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Pemeliharaan UPS	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

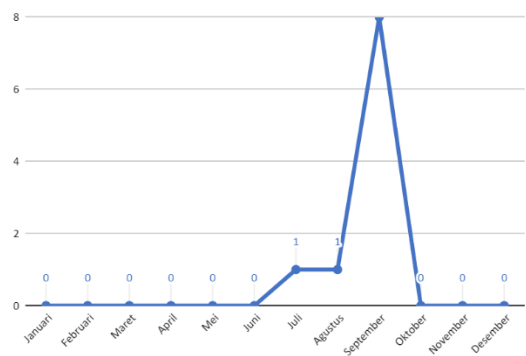
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1.	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	0	0	0	1	1

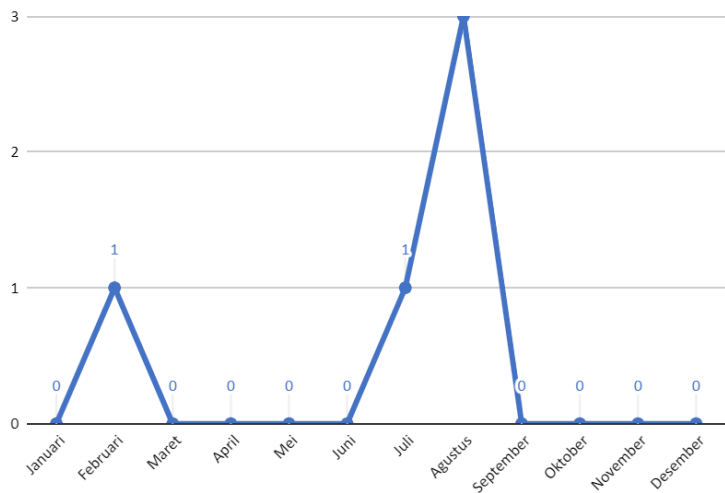
3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	1	0	0	0	0	1	3

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

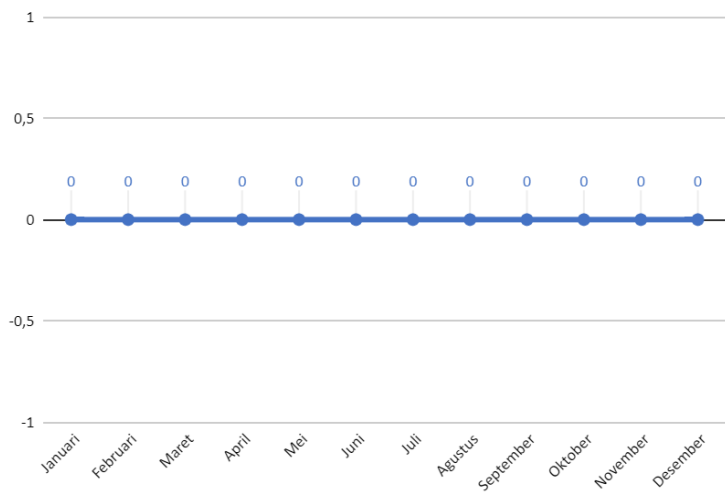
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

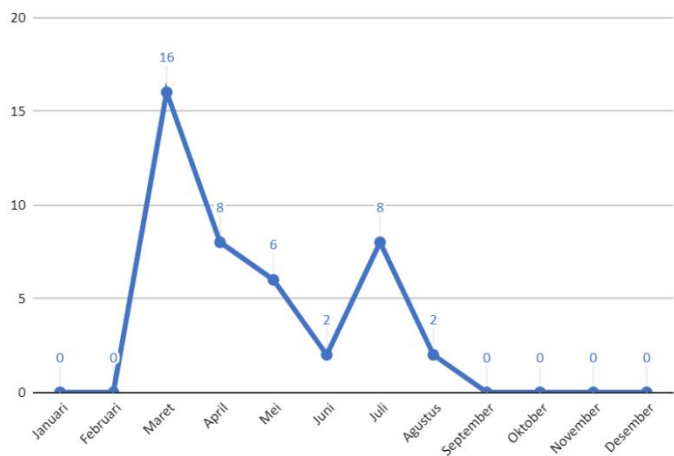


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	Tidak tercatat	Tidak tercatat	16	8	6	2	8	2



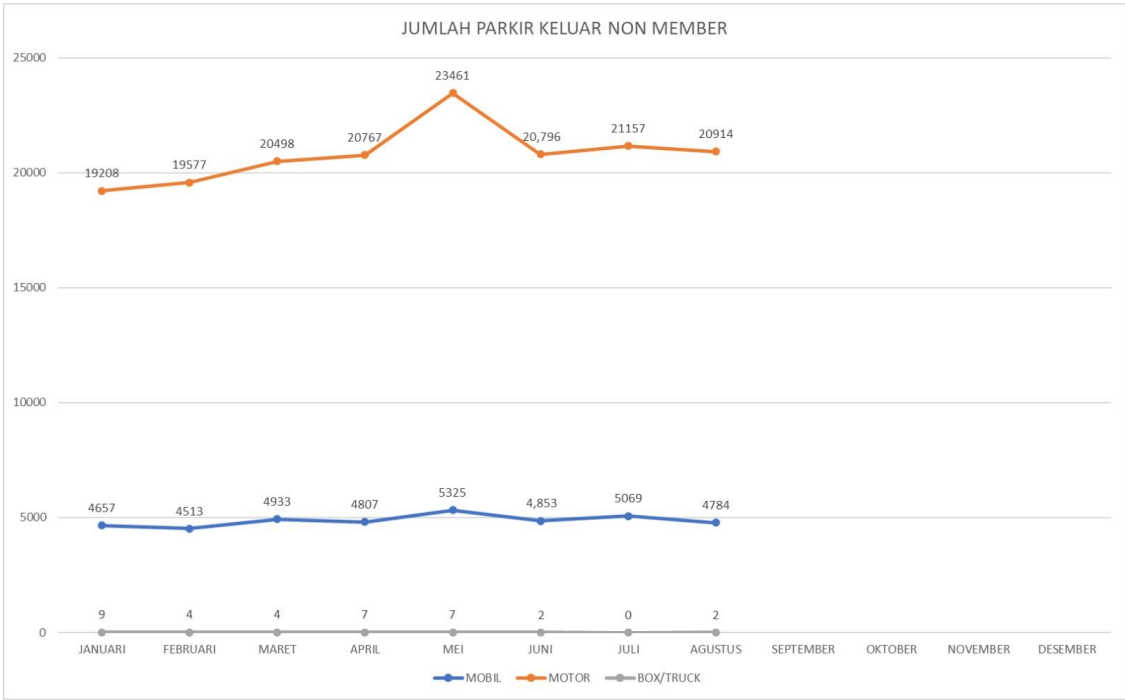
Analisis :
Angka kejadian merokok mengalami kenaikan pada bulan ini. Beberapa faktor yang mengakibatkan:

- 1. Karakter pasien berbeda-beda setiap bulannya
- 2. Tanda dilarang merokok tidak terlihat dengan baik
- 3. Ruang dibelakang Samator menjadi tempat yang tertutup untuk istirahat dan merokok

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Penurunan jumlah parkir di Bulan Agustus searah dengan penurunan pasien dibanding bulan Juli 2024

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

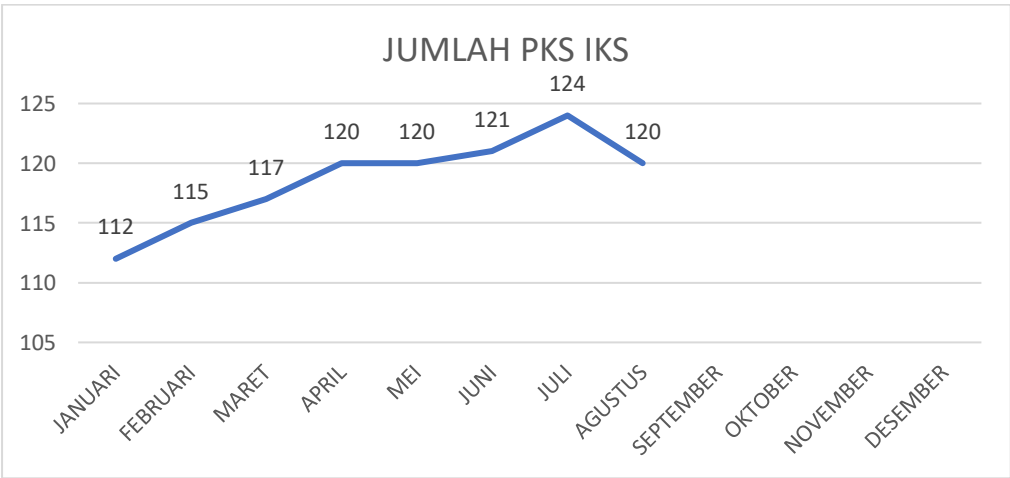
3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Jumlah PKS IKS AKTIF	112	115	117	120	120	121	124	120

3.5.5.1.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Bulan Agustus 2024

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Pesta Pora Abadi	Review pihak kedua	-
2	PT Tentrem Sejahtera	Review pihak kedua	-
3	PT Ustegra	Review pihak kedua	-
4	PT Randi Cones Indonesia	Review pihak kedua	-
5	PT Kharisma Selaras	Review pihak kedua	-
6	RS Universitas Brawijaya	Review ulang oleh RSUB	Ada beberapa notice terkait kesepakatan
7	PT New Minatex	Review pihak kedua	-
8	CV Barokah Plywood	Review Pihak Kedua	-
9	PT Indostar Building Material	Review Pihak kedua	-
10	PT Enak Jaya Makmur (Enak Eco)	Review Pihak kedua	-
11	PT Indonusa Algaemas Prima	Review Pihak Kedua	-
12	PT Duta Kharisma Sentosa	Review Pihak Kedua	-
13	PT Mahadaya Karya Sentosa	Review Pihak Kedua	-
14	PT Bangun Sarana Wreksa	Review Pihak Kedua	-

Analisis :

Progress penyelesaian PKS dari Bulan Juli (20 PKS) ke Agustus 2024 (14 PKS).

Rencana Tindak Lanjut :

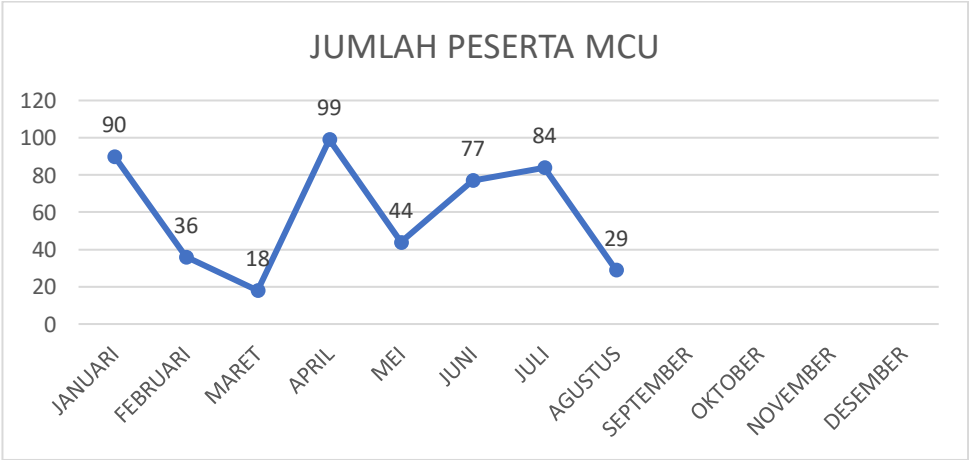
- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
- 2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	JUMLAH PESERTA MCU	90	36	18	99	37	50	84	29

3.5.5.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU



NO	BULAN	JUMLAH PASIEN	REVIEW
1	Januari	90	Analisis : Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up menurun dibandingkan bulan sebelumnya.
2	Februari	36	
3	Maret	18	
4	April	37 62 Free	
5	Mei	37 7 (PT Indonesian Marine)	Review hasil kunjungan dengan PDSA Plan 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan 2. Mempromosikan program MCU 3. Mereview tarif/biaya pemeriksaan
6	Juni	50 8 (PT Magicsoft Technology Indonesia 19 (BBIB)	
7	Juli	46 38 (PT Indonesian Marine)	
8	Agustus	29	
			Do 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain Study 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU. 2. Perusahaan memilih harga MCU paling murah diantara vendor. 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan. Action 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT
1	Jumlah Kunjungan	6	10	19	4	7	17	16	4

3.5.5.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal



Analisis :
Fluktuatif dikarenakan Sebagian perusahaan sudah dikunjungi dan persiapan corporate gathering

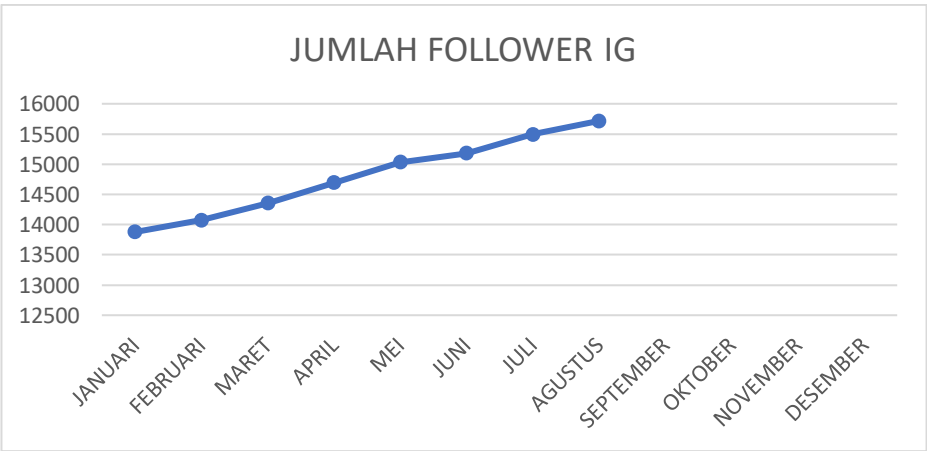
Rencana Tindak Lanjut :
Menghubungi HRD dalam list perusahaan untuk menjadwalkan kunjungan kembali bagi perusahaan yang belum.

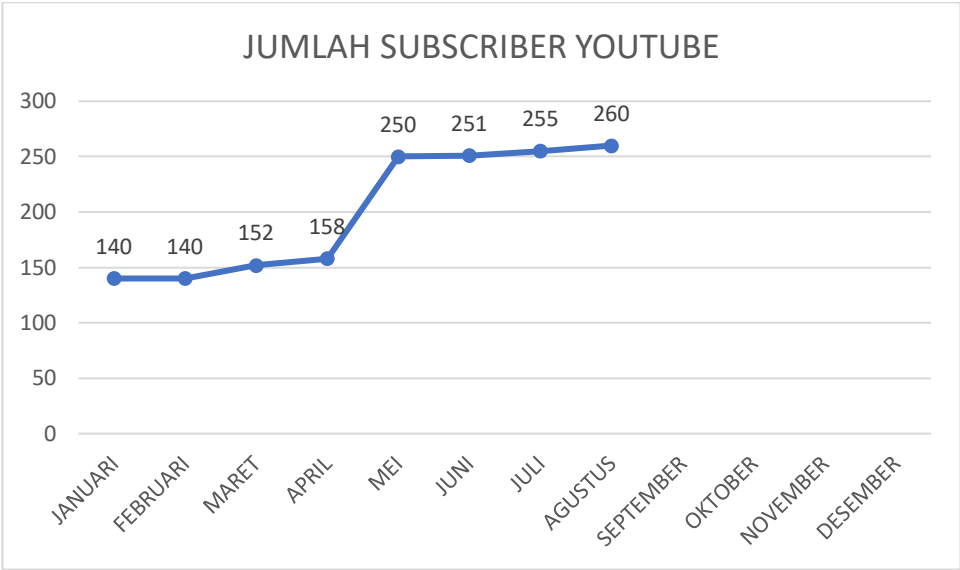
3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Tabel Follower Media Sosial yang Dikelola RS Prima Husada Malang

BULAN	FOLLOWER		UNFOLLOW	
	INSTAGRAM	YOUTUBE	INSTAGRAM	YOUTUBE
Januari	13877	140	265	0
Februari	14076	140	22	0
Maret	14353	152	22	0
April	14692	158	18	0
Mei	15034	250	29	0
Juni	15181	251	31	0
Juli	15493	255	13	0

Analisis :
1. Digital marketing untuk mengelola Youtube belum ada masih menjadi satu di PT.
2. Follower Instagram meningkat karena tim PKRS aktif melakukan upload dan promosi di media sosial.





3.5.6 Penjaminan

3.5.6.1 Piutang

3.5.6.1.2 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Agustus 2024

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814		-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779		-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702		-
	FPK PEND REGULER FEBRUARI	373.212.100	10.06.2024	19.06.2024	373.212.100		-
	FPK PEND II FEB 2024	58.112.500	09.07.2024	17.07.2024	58.112.500		-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
	FPK AMBULANCE MARET 24	5.280.000	14.06.2024	10.06.2024	5.280.000		-
	FPK ALKES MARET 24	3.465.000	14.06.2024	10.06.2024	3.465.000		-
	FPK OR MARET 24	471.764.386	15.07.2024	22.07.2024	471.764.386		-
	FPK PEND MARET 2024	383.291.100	09.07.2024	17.07.2024	309.918.000	73.373.100	-
	FPK PEND MARET 2 2024	90.791.600	20.08.2024	29.08.2024	90.791.600		-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500	-
	FPK OBAT KRONIS APRIL 2024	477.096.910	26.07.2024	05.08.2024	477.096.910		-
	FPK AMBULANCE APRIL 24	3.270.000	14.06.2024	10.06.2024	3.270.000		-
	FPK ALKES APRIL 24	3.630.000	14.06.2024	10.06.2024	3.630.000		-
	FPK Pending April 2024	289.580.800	07.08.2024	19.08.2024	289.580.800		-
5	FPK MEI 2024	7.537.333.400	23.06.2024	01.07.2024	7.493.109.800	44.223.600	-
	FPK OBAT KRONIS MEI 2024	487.109.484	26.07.2024	12.08.2024	487.109.484		-
	FPK Alkes Mei 2024	3.465.000	24.07.2024	07.08.2024	3.465.000		-
	FPK Ambulance Mei 2024	5.145.000	24.07.2024	07.08.2024	5.145.000		-
6	FPK JUNI 2024	6.959.035.980	24.07.2024	31.07.2024	6.868.943.180	90.092.800	-
	FPK Alkes Juni 2024	8.470.000	24.07.2024	07.08.2024	8.470.000		-
	FPK Ambulance Juni 2024	6.945.000	24.07.2024	07.08.2024	6.945.000		-
7	FPK JULI 2024	7.160.148.298	20.08.2024	29.08.2024	7.122.971.498	37.176.800	-
8	Reguler Agustus Belum FPK	7.058.307.000					7.058.307.000
		70.117.847.923			62.729.641.623	329.899.300	7.058.307.000

3.5.6.1.3 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	APRIL 24	RJ	11.384	11.366	2	4	0,0%
		RI	1.082	990	-	33	3%
2	MEI 24	RJ	12.641	12.628	3	13	0,1%
		RI	1.098	1.026	-	72	7%
3	JUNI 24	RJ	11.095	11.090	-	5	0,0%
		RI	1.024	922	-	102	10%
4	JULI 24	RJ	12.691	12.682	-	9	0,1%
		RI	995	924	-	71	7%

3.5.6.1.4 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG													
PERIODE 2024													
									Y	Z	AA	AB	
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH PIUTANG
		a	b	(a-b-c= d)	e	f	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	Total
PERIODE AGUSTUS 2024 :													
1	Asuransi	213.006.481	167.536.330	43.543.619	184.026.708	65.005.787	116.124.540	159.668.158	132.307.473	21.951.223	-	-	155.075.749
2	Perusahaan	195.285.233	102.376.448	92.901.285	55.936.247	3.791.534	52.144.713	145.045.998	66.360.704	19.903.133	15.155.408	46.225.647	156.216.291
3	Mandiri Inhealth	34.900.251	33.773.371	372.039	16.147.105	-	16.147.105	16.519.144	16.147.105	372.039	-	-	16.519.144
4	Jasa Raharja	80.286.343	66.676.581	13.609.761	202.761.423	18.054.924	184.706.500	198.316.261	198.316.261	-	-	-	198.316.261
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.469.523.639	657.793.480	811.671.717	604.624.287	-	604.624.287	1.416.296.004	1.132.572.165	281.314.277	-	352.000	1.416.296.004

Keterangan :

1. Cut Off Piutang per 31 Agustus 2024 saldo Rp 1.416.296.004
2. Piutang Perusahaan PT Toppas terbayar tgl 02/9/24 Rp 46.225.647,- (mutase September 2024) sisa piutang bulan juni proses verifikasi oleh auditor
3. BPJS TK proses pembayaran di bulan September 2024.

3.5.6.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Kode I11.0 (Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure) kurang sesuai, harap menggunakan I50 (Congestive heart failure),	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
2.	Pasien rawat inap dan masih di IGD dan dirujuk	Klaim Pending	Ditagihkan Rawat Jalan
3.	Penggunaan kode J960 (ARDS) diminta Reslesi J96 (Respiratory Failure, unspicifeied)	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
4	Rujukan internal pada hari yang berbeda namun jadwal DPJP ada pada hari yang sama	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending

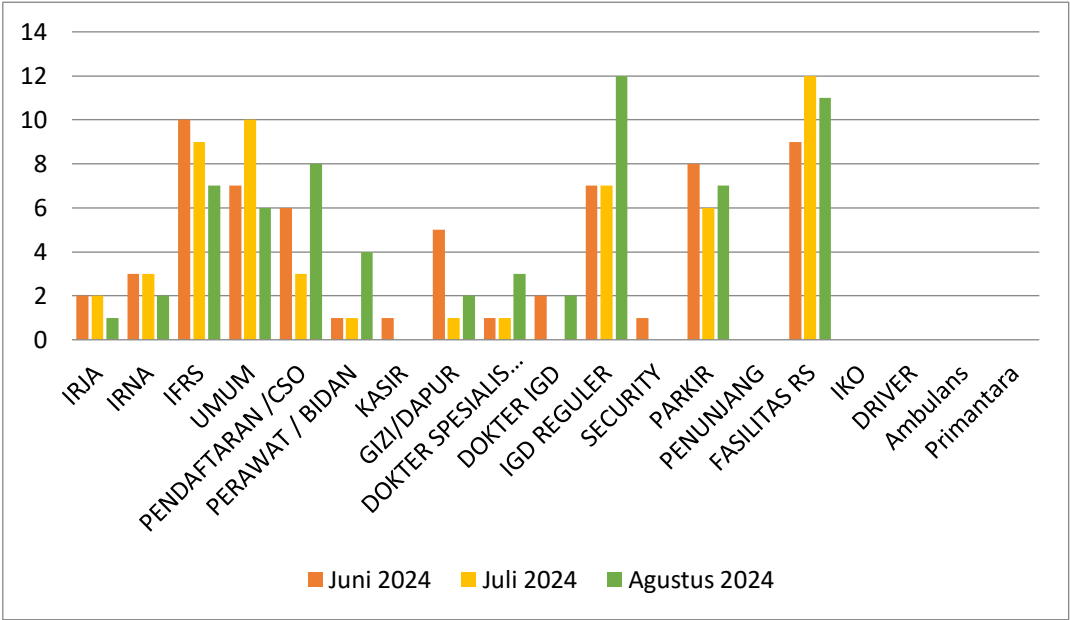
3.5.7 PIPP – MOD – MPP

3.5.7.1 Laporan Komplain Pasien

3.5.7.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Agustus 2024

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1.	IRJA	2	2	1
2.	IRNA	3	3	2
3.	IFRS	10	9	7
4.	UMUM	7	10	6
5.	PENDAFTARAN	6	3	8
6.	PERAWAT / BIDAN	1	1	4
7.	KASIR	1	0	0
8.	GIZI/DAPUR	5	1	2
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	1	1	3
10.	DOKTER IGD	2	0	2
11.	IGD REGULER	7	7	12
12.	SECURITY	1	0	0
13.	PARKIR	8	6	7
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	9	12	11
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		63	54	65

3.5.7.1.2 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Agustus 2024



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Agustus 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Agustus 2024 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan juni sebanyak 63 kasus complain. Pada bulan juli menurun sebanyak 53 kasus complain. Sedangkan pada bulan Agustus naik menjadi 65 kasus komplan
2. Komplain terbanyak pada bulan Agustus 2024 yaitu dari IGD sebanyak 12 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 13 jenis complain dengan rincian :
 - 1) Fasilitas RS sebanyak 6 kasus yang meliputi :
Keluhan TV tidak menyala dan tidak ada suara, alat pemanggil perawat tidak fungsi, ditambah wifi di ruangan rawat inap, lokasi kasir yang terlalu jauh dari IGD
 - 2) Parkir sebanyak 5 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
Tiket parkir gratis untuk rawat inap, parkir yang nyaman ada penutup bagi roda 2, parkiran diperluas agar tidak parkir di pinggir jalan, tariff parkir terlalu mahal
 - 3) UMUM sebanyak 2 kasus terkait masih banyaknya perokok di area rumah sakit prima husada malang.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Agustus 2024

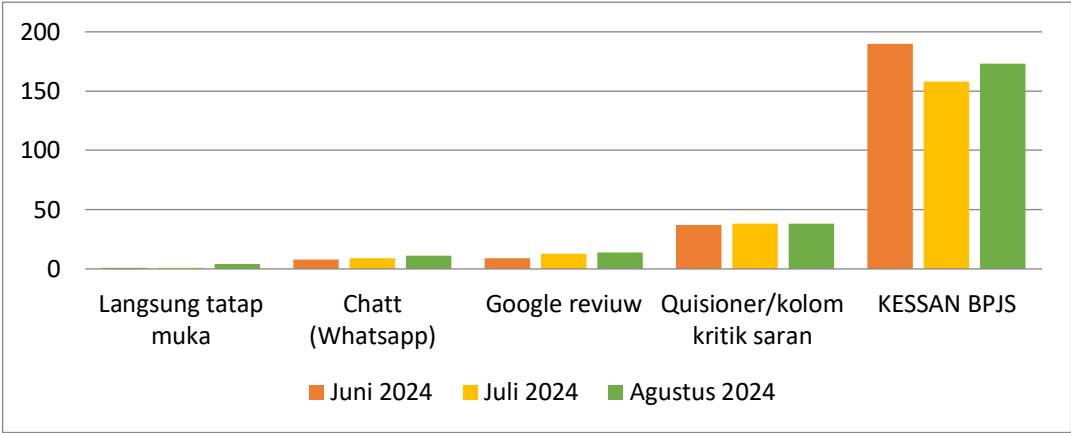
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
1.	Langsung tatap muka	1	1	4
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	8	9	11
	b. Google review	9	13	14
3.	Quisioner/kolom kritik saran	37	38	38
4.	KESSAN BPJS	190	158	173

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	0	0	18	155

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Agustus 2024



Analisis :
Pada bulan Agustus 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 38 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari google review sebanyak 14 kasus, chat WA sebanyak 11 kasus dan secara tatap muka / langsung 4 kasus

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Agustus 2024

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 '	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 '	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	4	0	1
					100%		
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	11	0	0
					100%		
3.	Google rewiuw	100%	100%	100%	13	0	0
					96%		
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	38	0	12
					85%		15%
5.	KESSAN	100%	0	100%	173	0	0
					100%		

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Agustus 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Kuisisioner dengan capaian 85%, dan dari tatap muka sebanyak 2% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 13 jenis complain dengan rincian :

- 1) Fasilitas RS sebanyak 6 kasus yang meliputi :
Keluhan TV tidak menyala dan tidak ada suara, alat pemanggil perawat tidak fungsi, ditambah wifi di ruangan rawat inap, lokasi kasir yang terlalu jauh dari IGD dan pendaftaran IGD
- 2) Parkir sebanyak 5 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir yang meliputi :
Tiket parkir gratis untuk rawat inap, parkir yang nyaman ada penutup bagi roda 2, parkir diperluas agar tidak parkir di pinggir jalan, tariff parkir terlalu mahal untuk RS
- 3) UMUM sebanyak 2 kasus terkait masih banyaknya perokok di area rumah sakit prima husada malang.

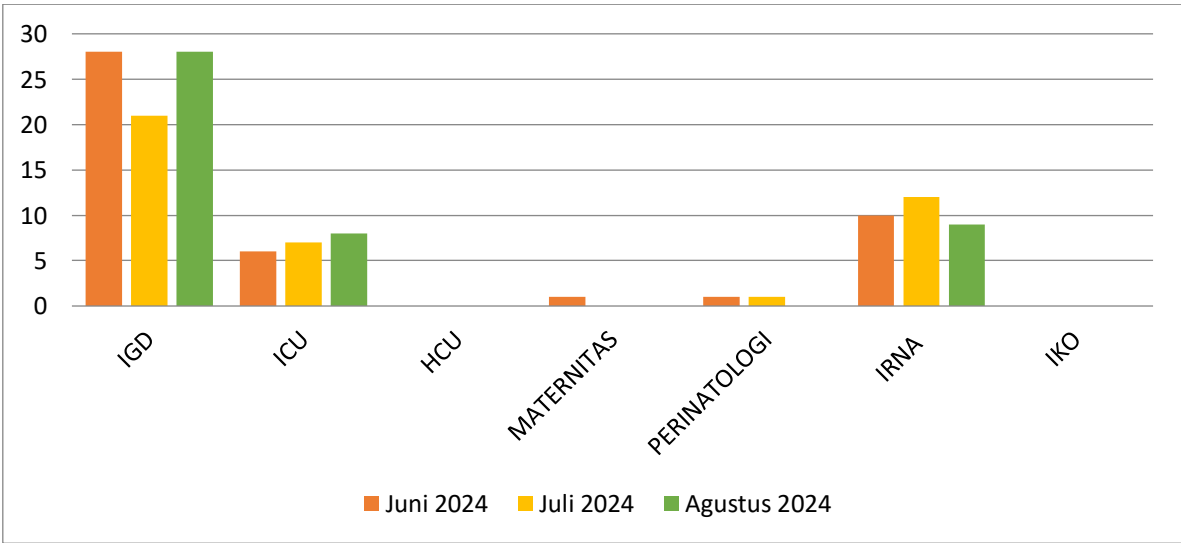
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Agustus 2024

NO	UNIT PERUJUK	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
1.	IGD	28	21	28
2.	ICU	6	7	8
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	1	0	0
5.	PERINATOLOGI	1	1	0
6	IRNA	10	12	9
7	IKO	0	0	0
Total		30	46	41

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Agustus 2024



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Tn. Mislam	IRNA	Appendicitis akut, AKI st III	dr.Zaki Sp.B konsul dr. Ardhi Sp.PD	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Pro HD	2	tidak
2	Tn. Rochmad Arief	IGD	hemiparase sin susp CVA Infark 2nd Attack, HT Emergency	dr. Syahrir Sp.S	RST Dr. Soepraoen	Pro Unit Stroke	2	tidak
3	Tn. Yerico Armi Nanlohy	IGD	CKS 345, Vullnus App regio frontalis	dr. Zaki Sp.B	RST Dr. Soepraoen	Pro ICU	1	tidak
4	Ny. Warsiati	IGD	Obs Dyspnea dd CKD st 5	dr. Heri Sp.PD	RST Dr. Soepraoen	Pro HD	2	tidak
5	Ny Sudjilah	ICU	Pneumonia, ADHF HHD, CKD, Sepsis	dr Mira, Sp.JP	RST Dr. Soepraoen	Back up HD	2	tidak
6	Ny Niti	IGD	STEMI	dr Mira, Sp.JP	RST Dr. Soepraoen	Pro primary PCI dam TPM	1	tidak
7	Ny. Siti Rubaiyah	IRNA	HEMATEMESIS	dr. Heri Sp.PD	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Pro Endoscopy Scleroterapi	3	tidak
8	Ny. Dyas Ady Gale	IGD	Pneumonia, HIV, TB Paru	dr. Yunita Sp.P (K)	RSSA	Pro ARV	2	tidak
9	Tn Yatmari	ICU	CVA ICH	dr Fahimma, Sp.S	RSUD Kanjuruan	Pro stroke unit	3	tidak
10	Ny Tharisa Sabrina	IGD	CKD, HT	dr Heri, Sp.PD	RSUD Lawang	Pro HD	2	tidak
11	Ny Satri	IGD	CVA ICH. CKD	dr Fachri, Sp.BS	RST Dr. Soepraoen	Pro evakuasi hematom, back up HD	2	tidak
12	Ny Mudjiati	ICU	Acute respiratory failure, COPD AE, susp pneumonia	dr Andy, Sp.P	RS Lavalette	Pro ICU	6	tidak
13	Tn Sugiono	IRNA	CVA emboli, HF, CAD	dr Yoga, Sp.JP	RSSA	Pro stroke unit	5	tidak
14	Tn Gatot Supriadi	IRNA	CVA Infark	dr Farid, Sp.N	RSSA	Pro stroke unit	3	tidak
15	Ny. yayuk mariani	IGD	Kompartement Sindrom	dr. Arianto, Sp. OT	RS Karsa Husada	Pro Perawatan kompartement	2	tidak
16	Ny. Marmunah	IGD	Syok Hipovolemik, Spetic condition, Transaminitis, Azotemia dt ACKD, DM	dr. Heri Sp.PD	RST Dr. Soepraoen	Pro Perawatan kompartement	2	tidak
17	Tn. Supeno	IRNA	hematemesis, Melena	dr. Heri Sp.PD	RSSA	Pro Endoscopy	2	Tarif rs : 2.240.760 Plavon : 1.347.400 Minus : 893.360
18	Ny. Nova Amelia	IRNA	CF Head Radius Ulna sinistra	dr. Arianto, Sp. OT	RST Dr. Soepraoen	Pro ORIF (Locking)	2	tidak
19	Ny. Sarwiningsih	IRNA	DOC+azotemia prorenal+Dm Hiperglikemia	dr. heri, Sp. PD Konsul dr. Farid, Sp. N	RSSA	Pro Perawatan kompartement	2	tidak
20	Ny. Rita Anggraeni	ICU	Respiratory failure, VT post ROSC, pneumonia	dr. Heru sp, An raber dr. farid sp, S	RSSA	Pro ICU ventilator selanjutnya	4	tidak
21	Tn. Junaedi Mailana	ICU	UAP, Cadiogenic syok, DM type 2	dr. Miryanti,	RST Dr. Soepraoen	Pro Immediete invasive strategy	2	tidak

				Sp. JP				
22	Tn. Mahmud	IGD	Susp Ruptur Uretra	dr. Pradana, Sp. U	RSSA	Pro OP urologi	2	tidak
23	Tn. Satari	IGD	D.o.c, Susp Resp failure, Desaturasi, Susp AKI, DM, Hipokalemia	dr. Elvi, Sp. P	RSSA	Pro ICU	2	tidak
24	Ny. ALFIYAH	IGD	Obs. Dyspneu, CKD, Konstipasi	dr. Heri, Sp. PD	RS Lavalette	Pro HD	1	tidak
25	Tn. Heriadi	ICU	Nstemi, Syock Cardiogenik, Septic Condition, DM Hipoglikemia, Pneumonia	dr. Heri, Sp.PD Raber dr. Mira Sp.JP	RST Dr. Soepraoen	Pro Immediate Invasif Strategi	2	tidak
26	Tn. Syaiful Yuniansyah	ICU	COPD AE, Pneumonia, sepsis dd kanker paru, efusi pleura dex, susp tb paru, candidiasis oral, trombositopenia, transaminitis, azotemia	dr. andy Sp.P raber dr. Ardhi Sp.PD	IGD IPIT RSSA	Pro ICU TB	3	tidak
27	Tn. Bakri	ICU	CVA Emboli, Leukositosis	dr. Dewi Sp.S raber dr. Mira Sp.JO	RS Karsa Husada	Pro stroke unit	2	tidak
28	Ny. Ngateni	IGD	ACUTE ON CKD, ALO UREMICUM, HIPERKALEMIA, ANEMIA	dr. Ardhi Sp.PD	RST Dr. Soepraoen	Pro HD	1	tidak
29	Tn. Mukayat	IRNA	Tumor otak, hemiparase dex, HHD	dr. Farid Sp.S konsul dr. Ira Sp.JP, konsul dr. Eko Sp.KFR	RSSA	Operasi besar bedah syaraf	2	tidak
30	Tn. Khusen Sukron	IGD	Anemia dr Hematemesis melena ec gastritis erosif	dr. Heri Sp.PD	RST Dr. Soepraoen	Perawatan lama	2	tidak
31	Ny Ni Wayan	IGD	Volume depletion, Susp B20, Candidiasis oral	dr Heri, Sp.PD	RST Dr. Soepraoen	Pro ARV	2	tidak
32	Ny. Lamini	IGD	CVA ICH SUBKORTEKS, HIPOKALEMIA	dr. Dewi Sp.S	RS Karsa Husada	Pro Stroke Unit	2	tidak
33	Tn. Rakimin	IGD	CKD, HHD, DF, Anemia, HT	dr. Yoga, Sp. JP	RS Lavalete	pro HD	2	tidak
34	Tn. Djari	IGD	Bradiaritmia Simptomatik dt AF SVR, CHF (LV Failure), TR moderate, MR-PR-AR mild	dr. Ira, Sp. JP	RSSA	pro TPM	1	tidak
35	Ny. Aliyah	IGD	ALI pedis S, AF RVR NVR, Susp CKD	dr. Miryanti, Sp. JP	RST Dr. Soepraoen	Pro resvaskularisasi	1	tidak
36	Nn. Serli Indayani	IGD	Obs. Dyspnea, TB Milier	dr. Yunita Sp.P (K)	RS Lavalete	Pro ruangan Isolasi TB	2	tidak
37	Tn Rawi	IGD	1. CVA emboli	dr Syahrir, Sp.N	RSUD Lawang	Pro stroke unit	2	tidak
38	Tn. Yoyok Agus Prianto	IGD	CVA ICH	dr. Syahrir Sp.S	RST Dr. Soepraoen	Pro stroke unit	2	tidak
39	Ny. Painem	IRNA	SVT Berulang, ADHF dt HHD, Sinus node	dr. Mira Sp.JP	RS Karsa Husada	Pro CVCU	5	Tarif rs : 5.599.323 Plavon :

			dysfunction					4.920.400 Minus : 678.923
40	Ny. Susiowati	IRNA	NSTEMI dd UAP, AF, Pneumonia, Efusi pleura dex minimal	dr. Ira, Sp. JP	RSSA	Pro PCI	4	tidak
41	Tn. Haryo kumbo Broto	IGD	Trauma tumpul abdomen, susp peritonitis dt abdominal organ injury, CF distal radius sin (smith fraktur), Vull laceratum labia superior, Multiple vull excoriatum	dr. Zaki Sp.B raber dr. Arianto Sp.OT	RST Dr. Soepraoen	Pro bedah digestif	1	tidak
42	DARTO	IGD	1. ACUTE ON CKD, ANEMIA NORMOSITIK-NORMOKROMIK,	dr Heri, Sp.PD	RS Lavalette	Pro HD	1	tidak
43	GINAJAH	IGD	CKD, Hiperkalemi, UAP	dr. Ardhi , Sp.PD co. dr. Yoga Sp.JP	RSSA	Pro HD	1	tidak

Analisis :

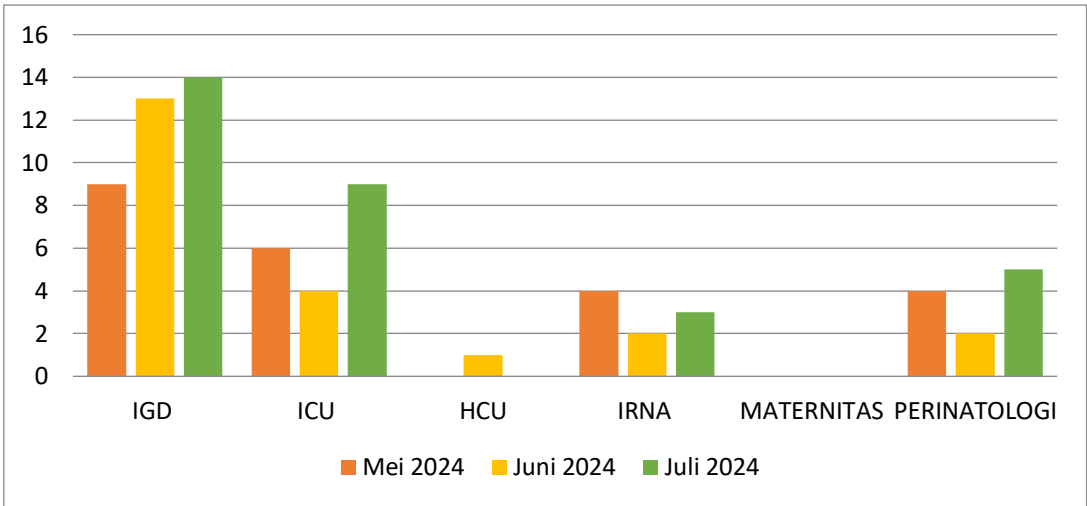
- Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam 3 bulan terakhir, pada bulan Juni sebanyak 46 pasien. Pada bulan Juli 2024 sebanyak 41 pasien, Sedangkan pada bulan agustus 2024 sebanyak 43 pasien dengan rincian : IGD 25 pasien, IRNA 9 pasien, ICU 8 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro HD = 8 kasus
 - Pro unit stoke = 8 kasus
 - Pro PCI = 2 kasus
 - Pro Bedah digestif = 1
 - Pro ventilator = 1
 - Pro ICU TB = 3
 - Pro ARV = 2
- Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya bulan Juli 2024 sebesar Rp. 696.516 Sedangkan pada bulan Agustus 2024 terdapat 2 pasien dengan jumlah total minus : Rp. 1.572.283

Rencana Tindak Lanjut:

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Juli 2024

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	JUNI 2024	JULI 2024	AGUSTUS 2024
1.	IGD	13	14	25
2.	ICU	4	9	8
3	HCU	1	0	0
4.	IRNA	2	3	9
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	PERINATOLOGI	2	5	1
Total		22	31	43



NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	Ny. Aminah	ICU	Hematemesis melena, Anemia dt GL Bleeding, Syock Hipovolemic, Sepsis, MODS, AKI st 3	dr. Farid Sp.S
2	Ny. Suparmiatun	IRNA	DM Hiperglikemia	dr. Heri Sp.PD
3	Tn. Mislikan	IRNA	HR, AR, CAD, Pneumonia, NSTEMI	dr, Ira Sp.JP raber dr. Yunita Sp.P
4	Ny Li'ah	ICU	ARDS, CVA emboli	dr Farid, Sp.N raber dr Heru, Sp.An
5	An Reifansyah Ramadhan Prasetya	IGD	Obs dypsnea, anemia, melena	dr Andira
6	Tn Kasiyanto	IGD	DOA	dr Sofia
7	Tn. Asil	IGD	DOA	dr. Nur Rohman
8	Tn. Rochmad	ICU	ARDS, CVA ICH	dr. farid, Sp. N raber dr. Heru, Sp. An
9	Tn. Riza Kurniawan	IGD	DOA	dr. rino
10	Ny. Nurcholifah	IGD	DOA	dr. rino
11	Tn Tadjab	ICU	DOC, DM Hiperglikemi	dr Ardhi, Sp.PD
12	Ny Sri Murtini	IRNA	Obs Dyspneu dd Pneumonia	dr Yunita, Sp.P
13	By. Ny. Marhayah	NEO	IUFD	dr Humaira, Sp. OG
14	Tn. Buchori	IRNA	DM HIPERGLIKEMI, DM GASTROPARY, STATUS EPILEPTIKUS, SEPSIS	dr. Heri Sp.PD
15	Tn Hariyanto	IRNA	ARDS, Shock sepsis, Pneumonia, TB Paru	dr Elvi, Sp.P
16	By. Ny. yulianti	NEO	IUFD	dr. Humaira, Sp. OG
17	Ny Saeni	ICU	Pnemonia, sepsis, susp TB, efusi pleura DM tp 2, hiponatremi	dr. Yunita Sp P konsul dr Zora Sp PD
18	Tn. Siyadi	IGD	Ganggreen Necrotic fascitis regio extremitas dex, nausea vomiting, obs dypneu	dr. Zaki Sp.B
19	Ny. Karianti	IGD	Cardiac Arest	dr. Yoga Sp.JP

Analisa :

- 1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Agustus 2024 sebanyak 19 pasien
- 2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD sejumlah 7 pasien, ICU sebanyak 6 pasien, IRNA 4 pasien, dan Neonatologi sebanyak 2 pasien.
- 3. Pada bulan Agustus 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 4 kasus.
- 4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.1 Laporan MPP

3.5.7.1.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		JULI 2024	AGUSTUS 2024	SEPTEMBER 2024
1	Usia lanjut	319	372	
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastrofik	516	620	
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	6	4	
4	Perkiraan biaya tinggi	184	142	
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	8	34	
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	0	1	
7	Potensial komplain tinggi	24	42	
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	615	751	
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	77	146	
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	795	964	
11	Berpotensi masalah hukum	0	0	
12	Naik kelas pelayanan	15	15	
13	Lain - lain	176	115	

3.5.7.1.2 Kelengkapan Pengisian Form A-B dan Dischard Planning Bulan Agustus 2024

NO	NAMA PETUGAS	FORM MPP	DISCARD PLANING
		JUMLAH	JUMLAH
1	Wiwit Indah Yanti, S. Kep, Ns	695	123
2	Sisca Puspitasari, S. Kep, Ns	360	122

3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

NO	JENIS	TARGET	CAPAIAN JUNI	CAPAIAN JULI	CAPAIAN AGUSTUS
1	SEIRI / RINGKAS	30	61%	48%	49,38%
2	SEITON / RAPI	40	89%	85%	82,21%
3	SEISO / RESIK	330	54%	56%	55,67%
4	SEIKETSU / RAWAT	40	72%	74%	71,51%
5	SHITSUKE / RAJIN	60	69%	72%	70,74%

SEIRI / RINGKAS	DESKRIPSI
Penempatan Alat Kebersihan di Janitor	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Janitor. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Janitor, peralatan kebersihan ditempatkan ppada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Penempatan alat kebersihan di Trolley	Alat kebersihan ditempatkan dan ditata dengan rapi di Trolley. Namun bagi ruangan yang tidak memiliki Trolley, peralatan kebersihan ditempatkan pada suatu tempat tertentu dalam kondisi bersih dan rapi
Kondisi bak pembersih / kereta peras	Kondisi bahan pembersih yang ada di bak pembersih / kereta peras tidak kotor. Maksimal 2x penggantian. Jika sebelum 2x sudah kotor amaka harus diganti. Pel harus dalam kondisi bersih
SEITON / RAPI	
Kerapian baju petugas CS	CS menggunakan baju sesuai seragam dengan rapi dan bersih
Penggunaan ID card	CS Menggunakan id card sesuai aturan
Penanganan sampah Medis dan Non Medis	
Penempatan sampah medis dan nonmedis	tempat sampah diberi kantong plastik sesuai warna dan fungsinya. Sampah medis dan nonmedis tidak boleh tercampur.
Penempatan plastik	Tempat sampah dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh, tidak kotor, tidak ada sampah berceceran
SEISO / RESIK	
Lantai	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih, dan sudut lantai harus bebas noda.
Langit – Langit / Plafon	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kaca Luar – Dalam	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, bebas noda, dan mengkilap.
Jendela / Tralis	Jendela / tralis bersih, tidak berdebu, dan tidak bernoda.
Tirai (vertical blind, gordyn)	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan rapi.
Lampu	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Saklar & stopkontak	Tidak berdebu, tidak bernoda, dan tidak basah.
Sarana pemadam kebakaran	Bersih, tidak berdebu, tidak kotor, dan tidak digunakan untuk menyimpan barang.
Objek Berbahan Stainless	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, tidak berminyak, dan tidak ada lawa – lawa.
Dinding	Bersih, tidak bernoda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Wastafel dan eye wash	Pembuangan mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada bercak air disekelilingnya, tidak bau, kering, kaca cermin bersih, bening, tidak berdebu, tidak bernoda, kran tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Kamar Mandi	Kebersihan dan bau
Ruangan	Tidak bau amis, pesing, dan anyir.
Plafon/langit-langit	Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Kasa nyamuk	Bersih, tidak bernoda, tidak ada lawa – lawa, dan tidak berdebu.
Dinding Keramik	Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, dan nat dinding bersih.
Closed	Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak ada percakan air disekelilingnya, dan tidak bau.

Kran	Tidak berkarat, tidak basah, dan tidak kusam.
Pintu	Bersih, tidak ada noda, dan mengkilap.
Urinoir	Bersih, tidak ada noda, tidak bau, dan tidak berkarat.
Bak Mandi	Tidak menguning karena lumut, tidak kotor, dan tidak ada jentik.
Ember dan Gayung	Bersih dan tidak berlumut.
Lantai	Bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak bau, dan sudut lantai harus bebas noda.
Keset	Tidak berdebu, tidak basah, tidak bau, dan tidak ada sampah.
Tempat Sampah	Dilapisi kantong plastik sesuai jenis limbah, tidak penuh (terisi kurang dari 2/3 bagian), tidak kotor, dan tidak ada sampah berceceran
Tangga	Bersih dan bebas sawang
Railing	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan bila diusap tidak membekas.
Lantai (anak tangga & Bordes)	Tidak berdebu, tidak ada sampah, tidak basah, dan tidak bau.
Dinding	Tidak berdebu, tidak ada noda, dan tidak ada bercak.
Plafon	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Lift	Lantai dan dinding tidak berdebu, tidak bernoda, mengkilat, harum, dan sudut lantai harus bebas noda.
Dek Level	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa / sampah / daun kering.
Pagar	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Spoel hock/Dapur	Bebas dari kotoran, tidak ada noda, tidak berdebu, dan tidak ada lawa – lawa.
Pembersihan Tempat Sampah / Trolly	Pembersihan tempat sampah / trolly dilakukan secara rutin, kondisi tidak berdebu, dan ada jadwal pembersihannya juga.
SEIKETSU / RAWAT	
Poles lantai di ruangan	Sudah dilakukan dan/atau dijadwalkan poles lantai, baik basah dan atau kering maksimal 1x/bulan
Pemakaian APD	APD masker, sepatu, sarung tangan
Penandaan alat kebersihan	Hijau strip 1 (-) : kantor, Hijau strip 2 (=) : dapur, Biru (selasar), kuning (r. perawatan/pelayanan, merah : kamar mandi
Kebersihan Diri Petugas	Pakaian bersih, Badan bersih, Tidak berbau tidak sedap
SHITSUKE / RAJIN	
Kompetensi CS Memperagakan Cuci tangan dengan benar	Dapat mempraktekan lengkap sesuai SOP cuci tangan
Kompetensi CS dalam menanggapi response keluhan	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup
Kompetensi CS dalam mengikuti arahan kordinator	Segera di TL dan dilaporkan dalam grup

Analisis :

Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih fluktuatif, akan dievaluasi untuk bulan September 2024

Rencana Tindak Lanjut :

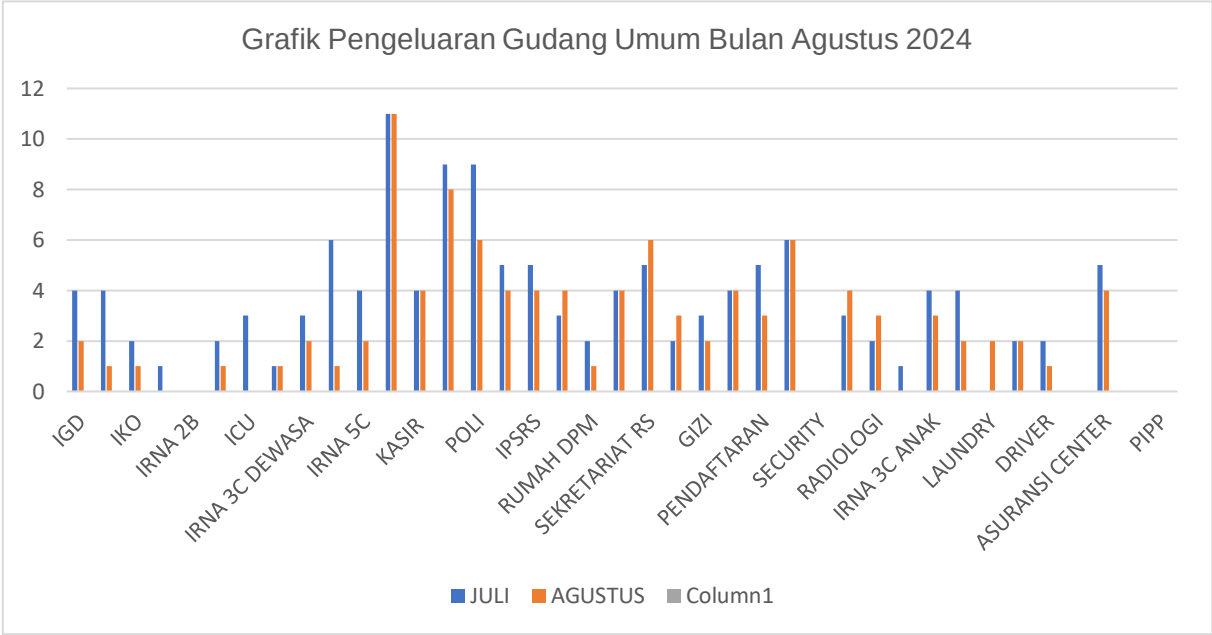
Monitoring dan evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG	
		JULI	AGUSTUS
1	IGD	4	2
2	MATERNITAS	4	1
3	IKO	2	1
4	IRNA 2A	1	0
5	IRNA 2B	0	0
6	IRNA 2C	2	1
7	ICU	3	0
8	IRNA 3A	1	1
9	IRNA 3C DEWASA	3	2
10	IRNA 4C+4A	6	1
11	IRNA 5C	4	2
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	11
13	KASIR	4	4
14	DAPUR	9	8
15	POLI	9	6
16	CLEANING SERVICE	5	4
17	IPSRS	5	4
18	GUDANG FARMASI	3	4
19	RUMAH DPM	2	1
20	SEKRETARIAT PT	4	4
21	SEKRETARIAT RS	5	6
22	CSSD	2	3
23	GIZI	3	2
24	REKAM MEDIS	4	4
25	PENDAFTARAN	5	3
26	DEPO FARMASI	6	6
27	SECURITY	0	0
28	LABORATORIUM	3	4
29	RADIOLOGI	2	3
30	FISIOTERAPI	1	0
31	IRNA 3C ANAK	4	3
32	NS NICU	4	2
33	LAUNDRY	0	2
34	LANTAI 6A,7A,8A	2	2
35	DRIVER	2	1
36	SIMRS	0	0
37	ASURANSI CENTER	5	4
38	DPW	0	0
39	PIPP	0	0

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat dan dapur,poli

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

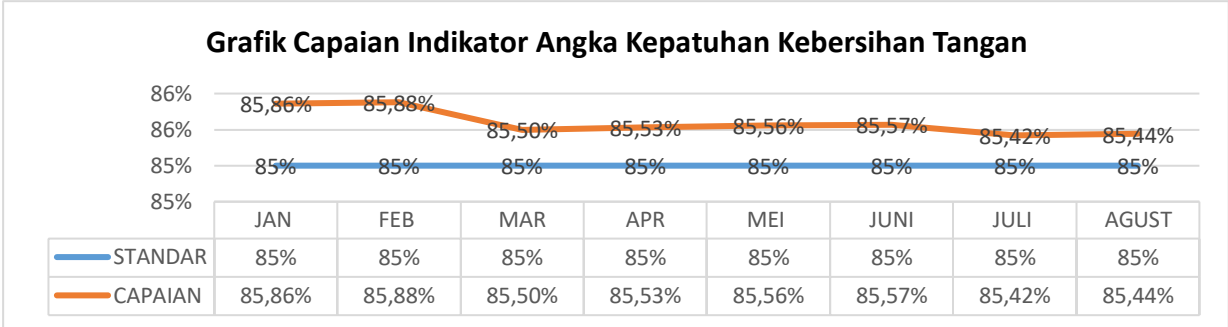
3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '24	Feb '24	Mar '24	Apr '24	Mei '24	Jun '24	Juli '24	Agust '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL										
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86 %	85,88 %	85,5%	85,53 %	85,56 %	85,57%	85,42%	85,44%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04 %	93,15 %	93,3%	93,52 %	93,73 %	93,8%	93,92%	93,24%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9 %	81,2%	98,78 %	100%	99,99 %	99,95%	99,93%	99,96%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2 %	91,7%	95,74 %	52,7%	63,8%	72,8%	80,97%	85,74%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19 %	79,08 %	79,28 %	78,06 %	76,32 %	78,47%	78,3%	79,04%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69 %	98,8%	98,46 %	97,5%	98,9%	99,69%	100%	100%

9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8 %	71,62 %	67,56 %	66,7%	100%	92,5%	100%	100%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47 %	97,47 %	99,54 %	99,67 %	95,86 %	96,51%	98,64%	98,72%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89 %	99,63 %	99,82 %	99,63 %	100%	100%	99,38%

3.6.1.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



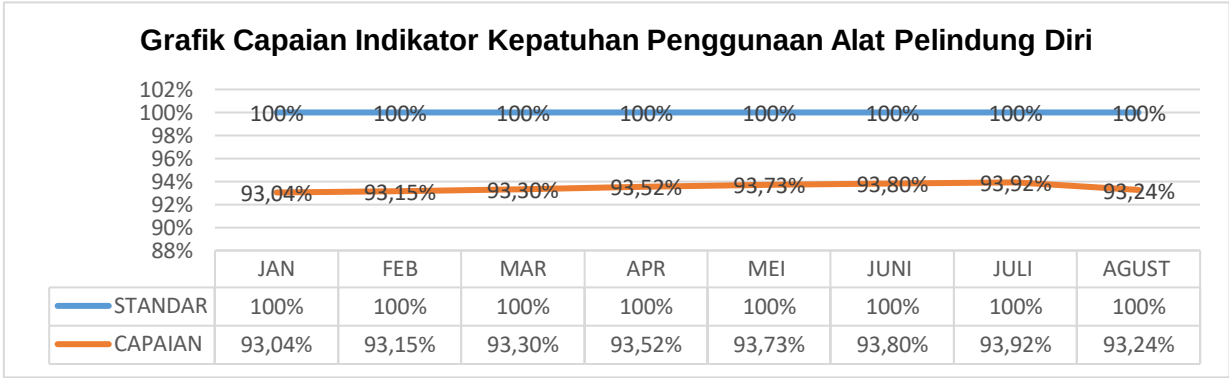
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,44%, meskipun sedikit menurun dari bulan lalu. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	6. Satu bulan

3.6.1.1.2

Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

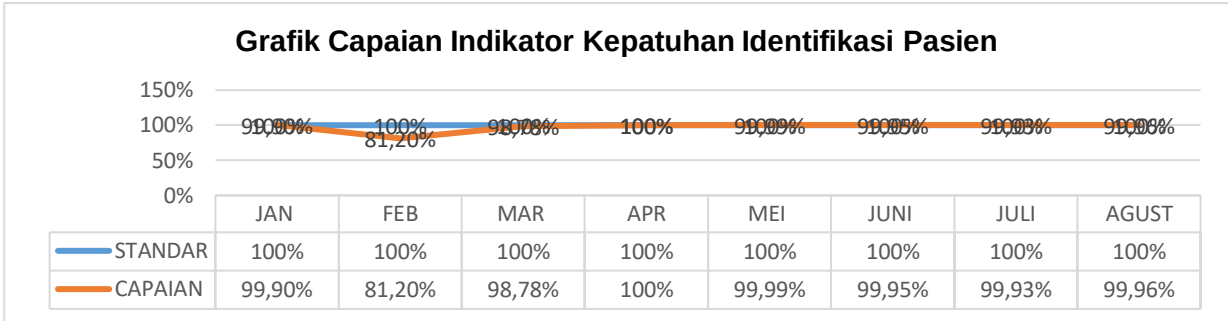


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,24% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkakepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. 2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidakpatuhan teman-teman di unitnya. 3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 4. Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			5. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

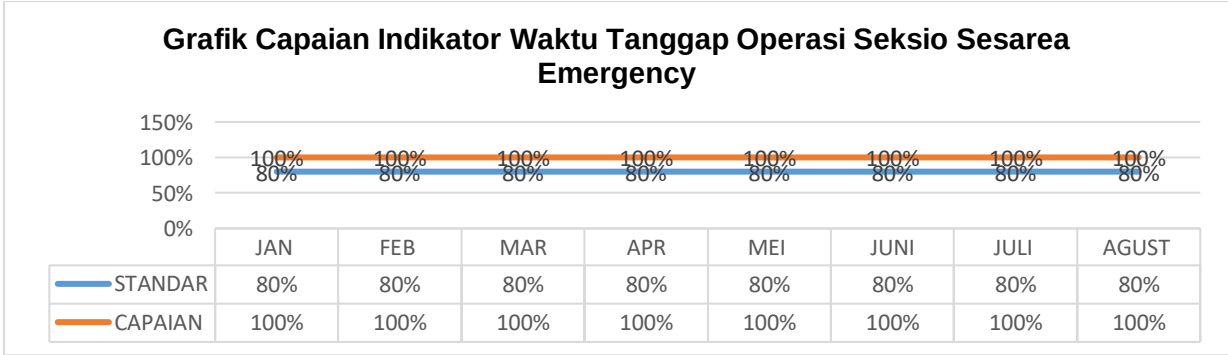
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	6. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 1. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 2. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Juli capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien. Pada bulan Agustus, capaian meningkat dari bulan Juli walaupun masih belum mencapai standart 100%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

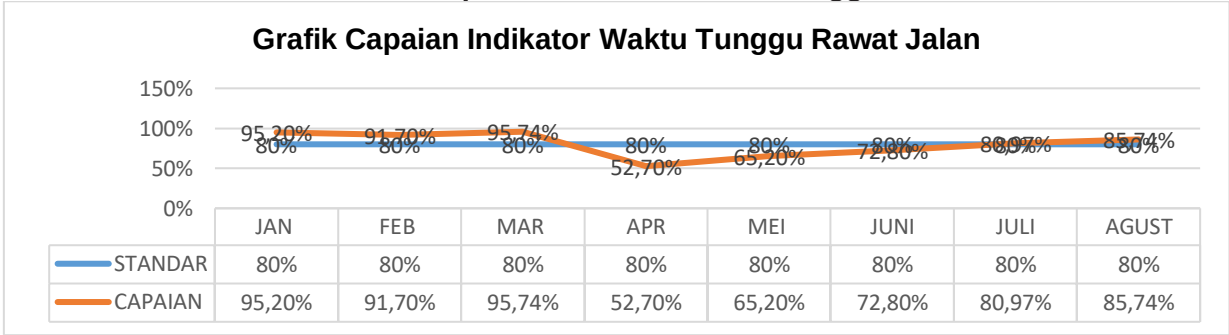
3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisa Capaian :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

3.6.1.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

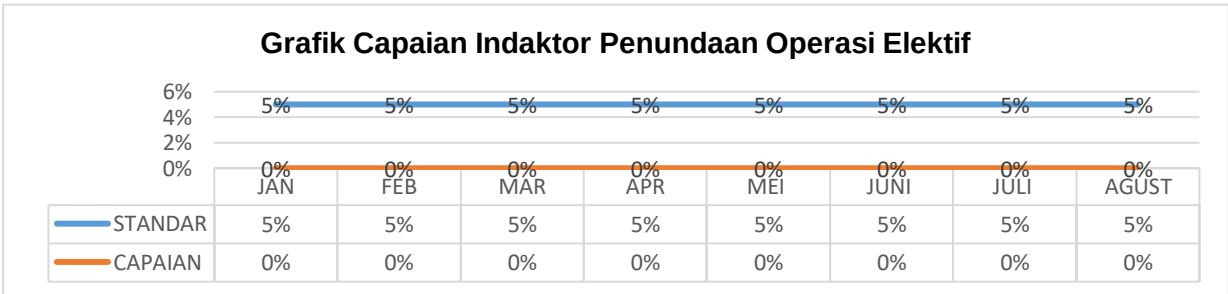
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart jika dilihat dari input mutu pada SIMRS, tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP. Pada bulan Mei tahun 2024 diketahui prosentase waktu tunggu rawat jalan 65,2%, bulan Juni 72,8%, bulan Juli 80,97% dan bulan Agustus 85,74%. 1. Dpjp tepat waktu : dr. Aida, Sp.OG, dr. Akhmad Syahrir, Sp.N, dr. Ardhi Bustami, Sp. PD, dr. Dewi Maharani, Sp.S, dr. Dicky, Sp.A, dr.Vita, Sp.KK, dr.Humaira, Sp.OG, dr.Ira, Sp.JP, dr.Miryanti, Sp.JP, dr.Nimim, Sp.THT.KL, dr.Pradana,Sp.U, dr.Yoga, Sp.JP, dr.Zora, Sp.PD , dr Viona Sp.A, dr.Elvi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S 2. Dpjp Tidak tepat waktu : dr.Andi,Sp.B, dr.Andy,Sp.P, dr.Iwan,Sp.B, dr.Nurhadi,Sp.M, 3. Dpjp dengan tindakan lama : dr. Anton, Sp.B, dr.Huda, Sp.KJ, dr.Didid, Sp.KJ, dr.Eko, Sp.KFR.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan SDM.	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.6 Penundaan Operasi Elektif

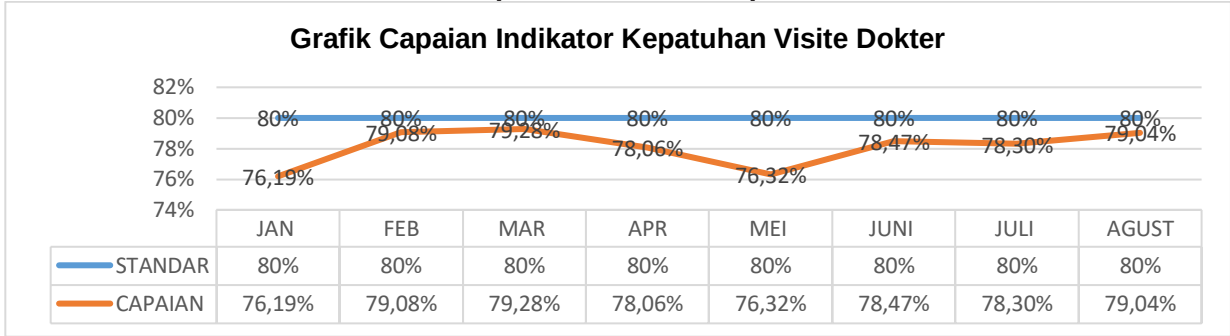
3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Analisa Capaian :

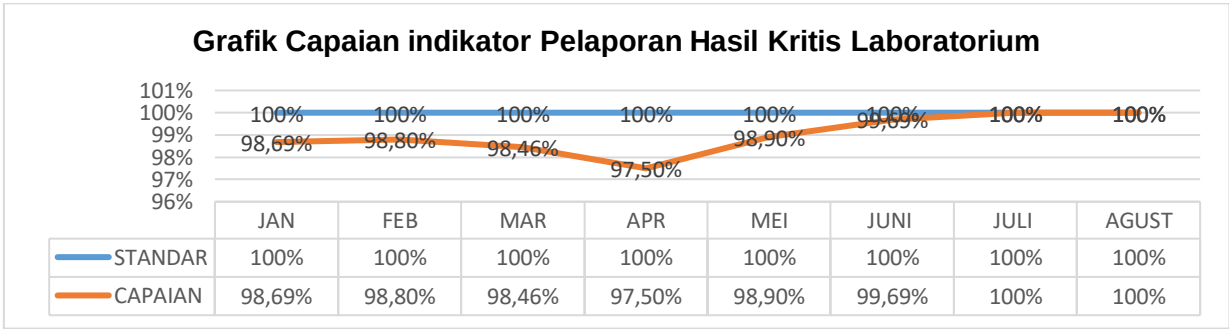
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

3.6.1.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter
3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkan nya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr, dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

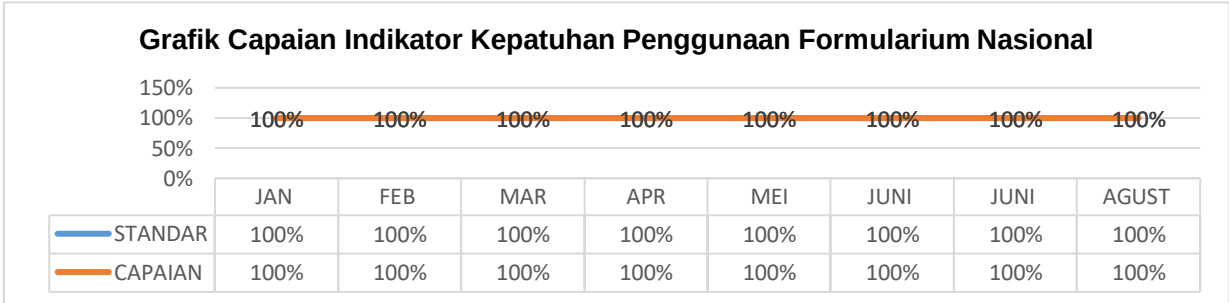


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.

STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024 masih belum mencapai standart. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap. Capaian meningkat pada bulan Juli dan Agustus, pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Juli dan Agustus mencapai standart 100%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan

3.6.1.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

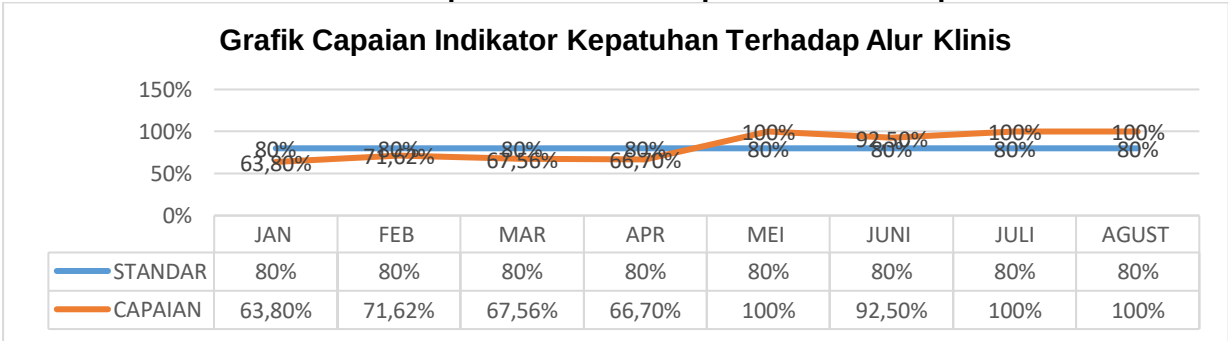


Analisis Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga Agustus Tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

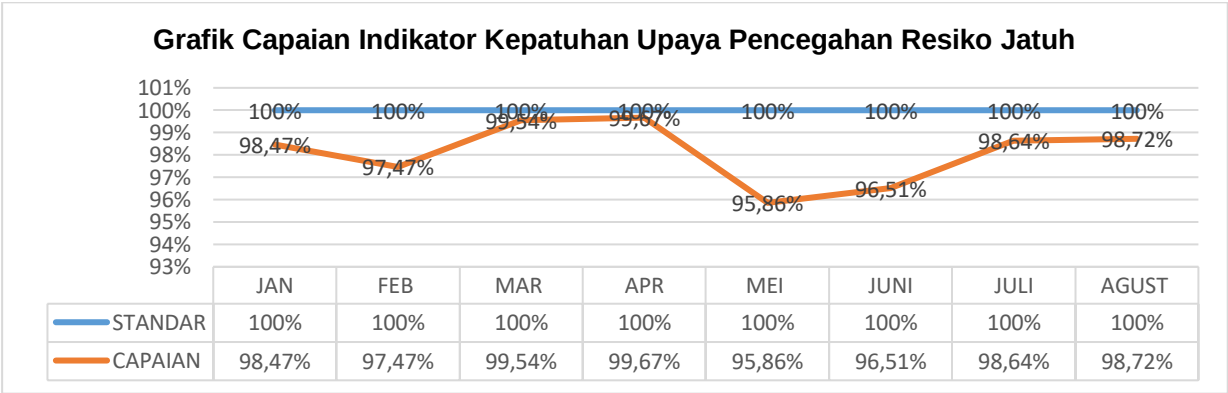
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.				
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadap alur klinis dapat dianalisa.	Komite mutu	Satu bulan

3.6.1.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

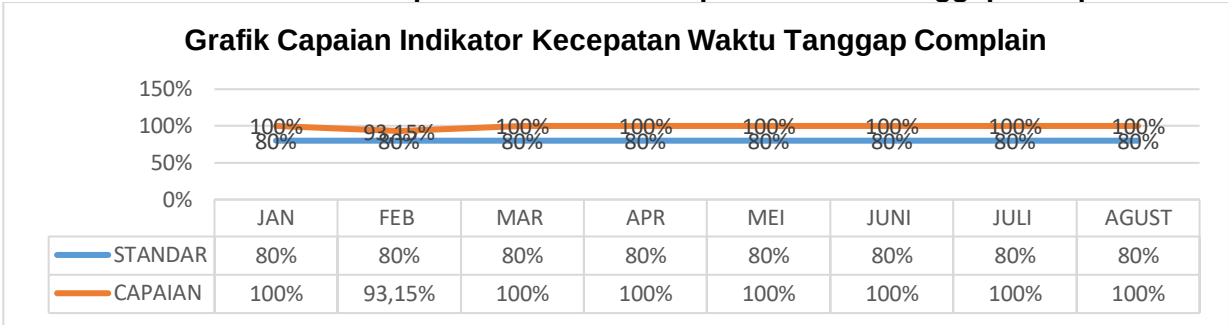
3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

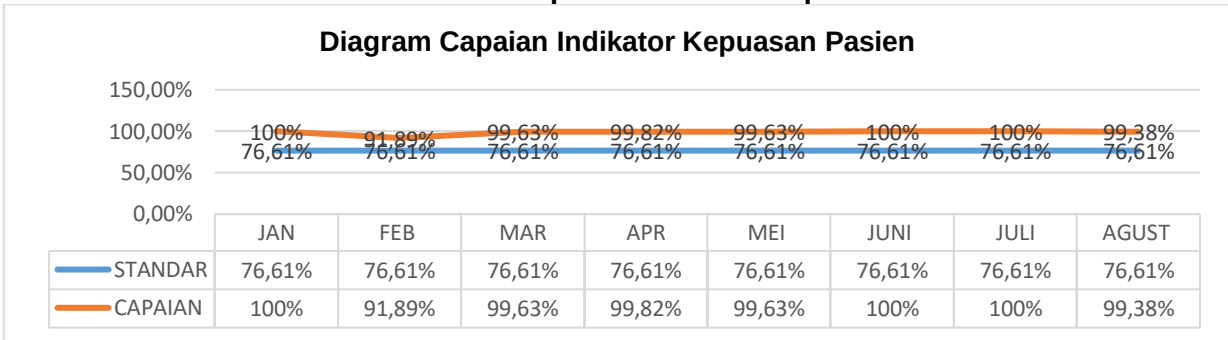
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap kompalin pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam. Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret hingga Agustus capaian kembali meningkat menjadi 100%.

3.6.1.1.13 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis :
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 sudah mencapai standar

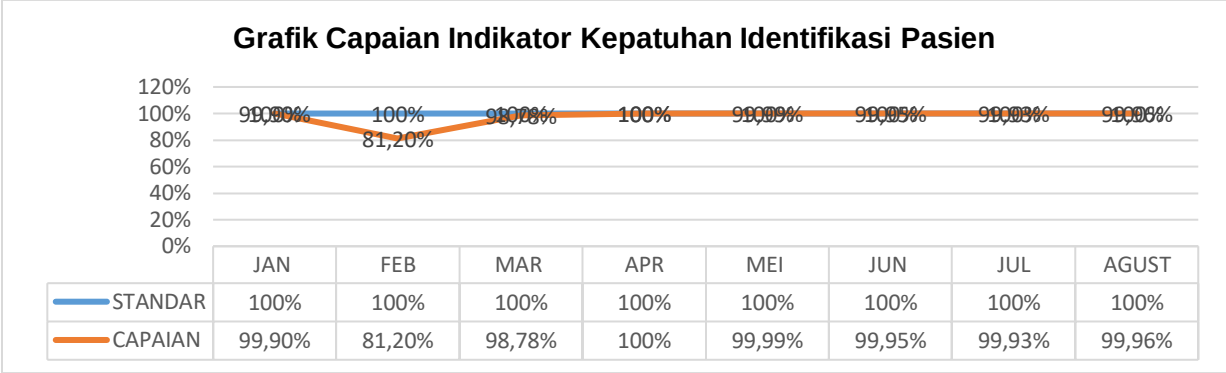
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%	99,95%	99,93%	99,96%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%	85,57%	85,42%	%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%	95,51%	98,64%	98,72%

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

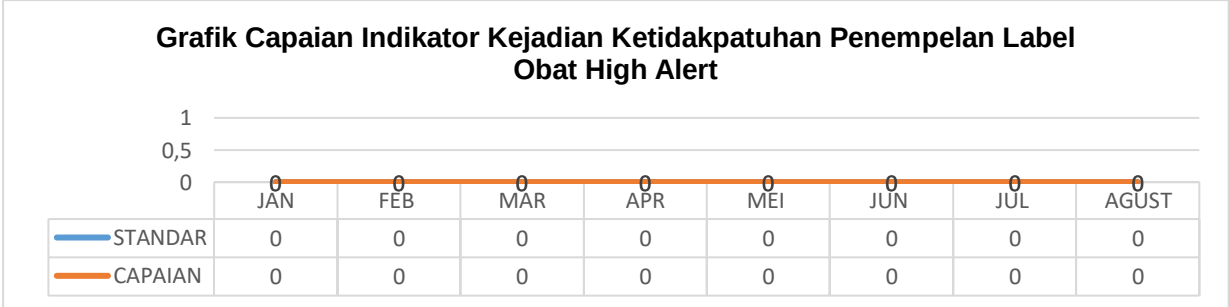
3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei hingga Juli capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien. Pada bulan Agustus, capaian meningkat dari bulan Juli walaupun masih belum mencapai standart 100%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

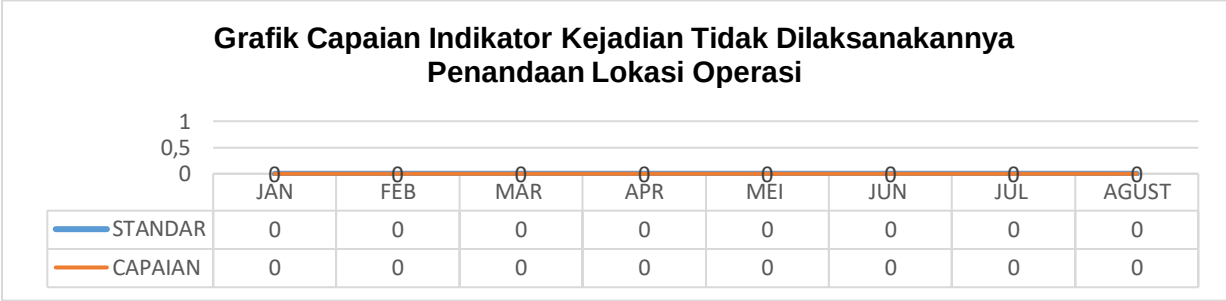


Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 telah mencapai standar.

3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

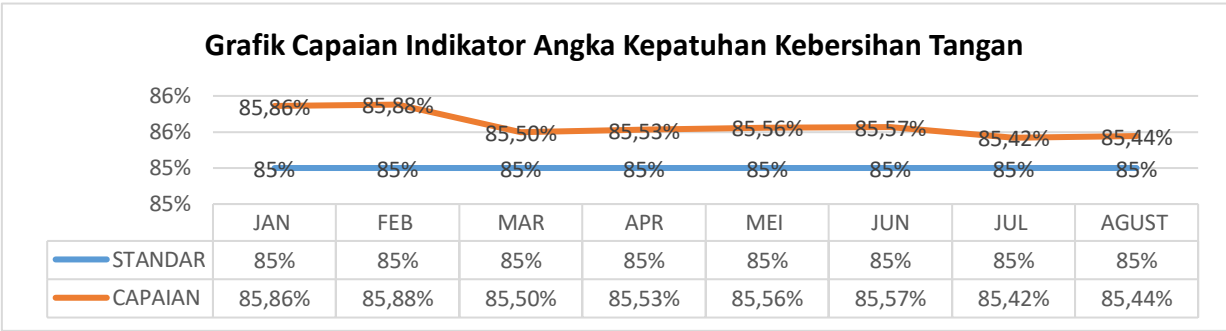
3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi



Analisis : Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 telah mencapai standar.

3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

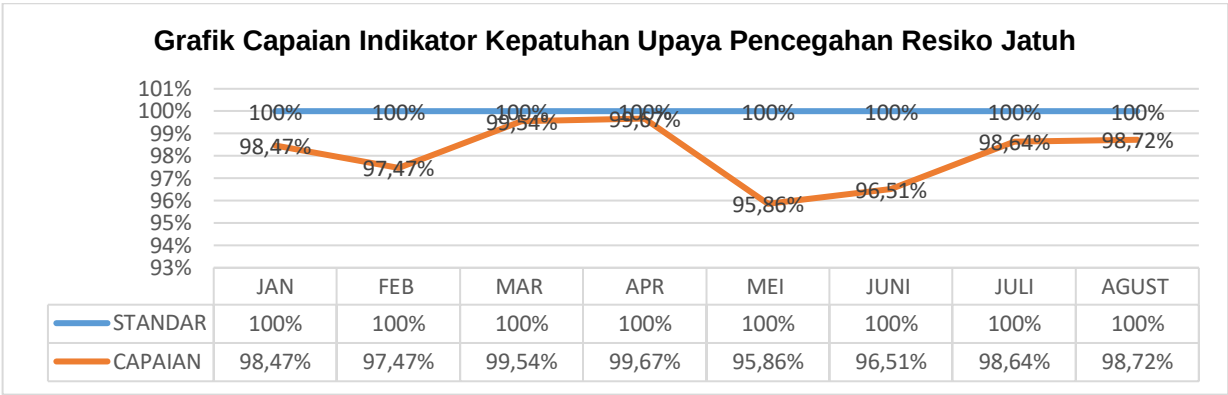


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,44%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

			4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatnkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

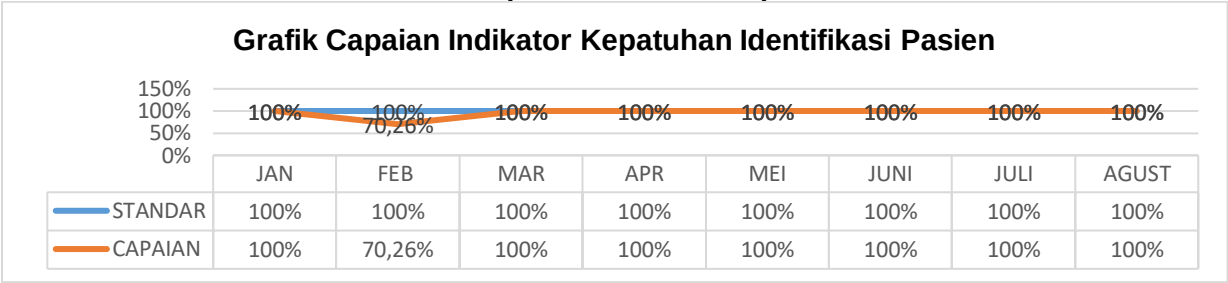
3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%	78,13%	74,88%	71,82%	72,73%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%	58,52%	54,92%	50,64%	53,25%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	2

8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%

3.6.1.2.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.2.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari hingga Agustus capaian telah mencapai standart 100%. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasien beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Meningkatkan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

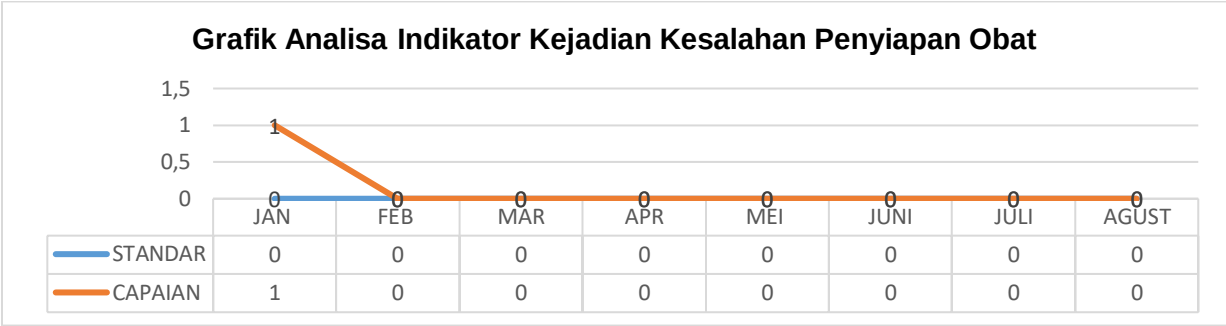
3.6.1.2.2.2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

3.6.1.2.2.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



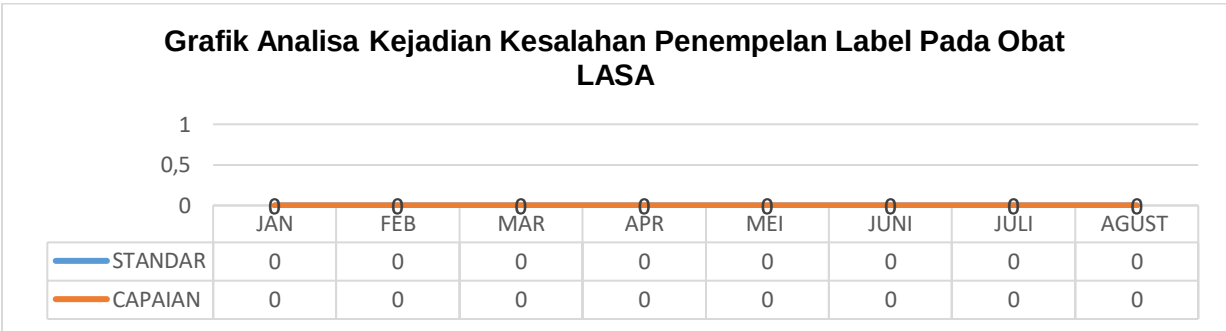
Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.2.3 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat
3.6.1.2.2.3.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga Agustus tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	1. Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan 2. Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat 3. Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

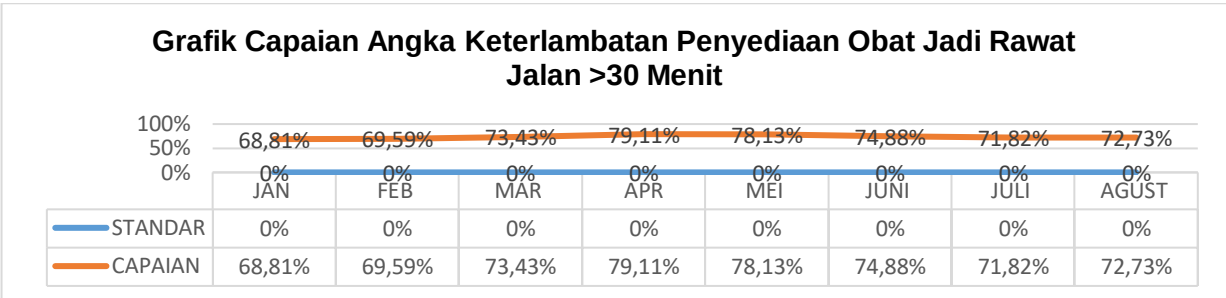
3.6.1.2.2.4 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA
3.6.1.2.2.4.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024.

3.6.1.2.2.5 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

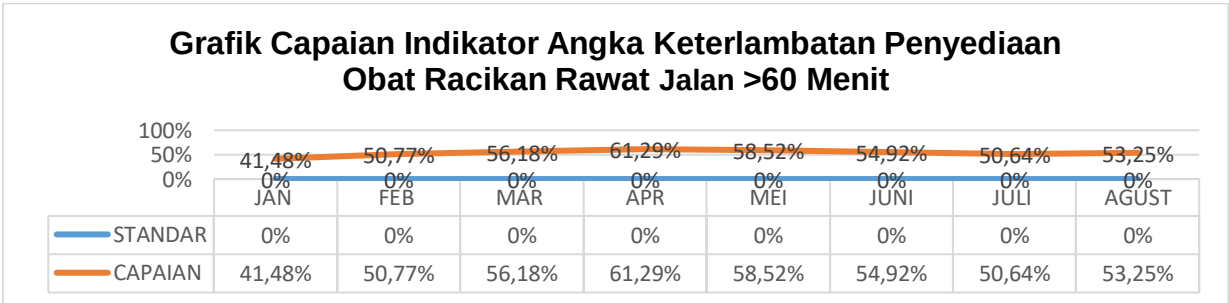
3.2.1.2.2.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	7. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 1. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 2. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : 1. Pasien cendereung naik beberapa hari. 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

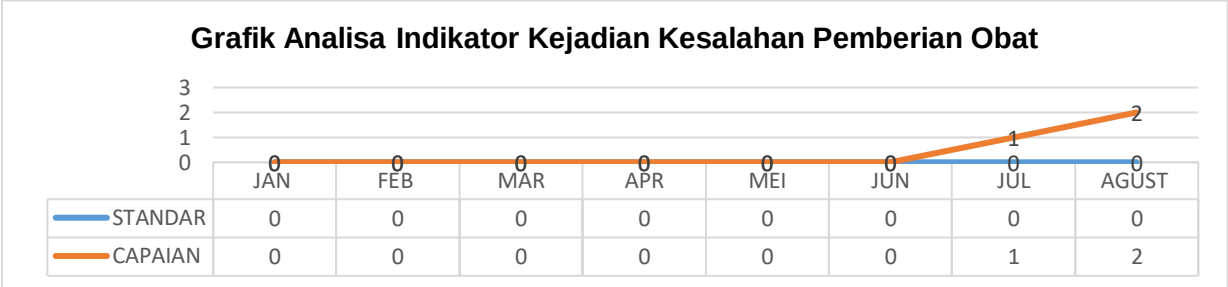
3.6.1.2.2.6 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

3.6.1.2.2.6.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : 1. Pasien cendereung naik beberapa hari 2. Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai 3. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.7 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat
 3.6.1.2.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

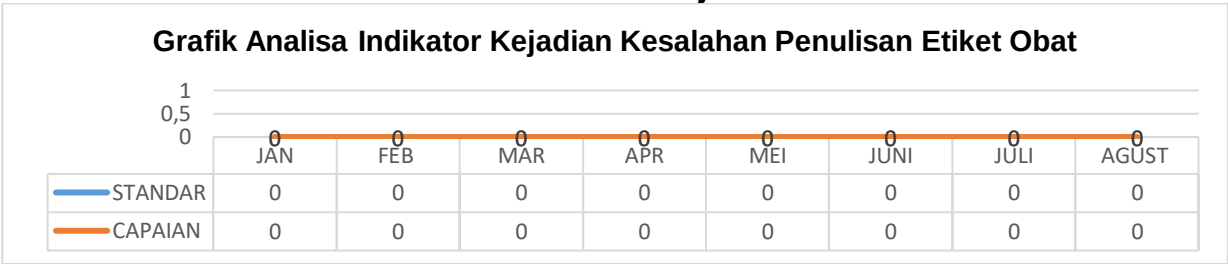


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kejadian kesalahan pemberian obat hingga mencapai standart yaitu 0 kejadian				
DO	4. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien yang mendapatkan resep 1. Melakukan rapat berasama kepala instalasi farmasi guna melakukan supervisi terkait kepatuhan identifikasi pasien dalam proses pemberian obat.				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Juni tahun 2024 tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat. Pada bulan Juli tahun 2024 ditemukan 1 kejadian kesalahan pemberian obat dan pada bulan Agustus ditemukan 2 kejadian kesalahan pemberian obat. Kesalahan pemberian obat disebabkan karena petugas tidak teliti muali proses penyiapan hingga pemberian obat ke pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Mengurangi angka kejadian kesalahan pemberian obat	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	1. Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan 2. Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

			melakukan identifikasi dengan benar.		
--	--	--	--------------------------------------	--	--

3.6.1.2.2.8 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

3.6.1.2.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat

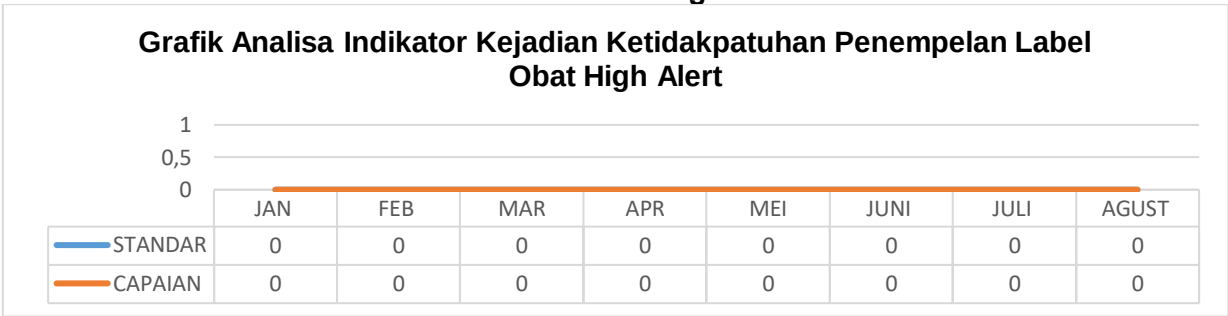


Analisis :

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2024.

3.6.1.2.2.9 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

3.6.1.2.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

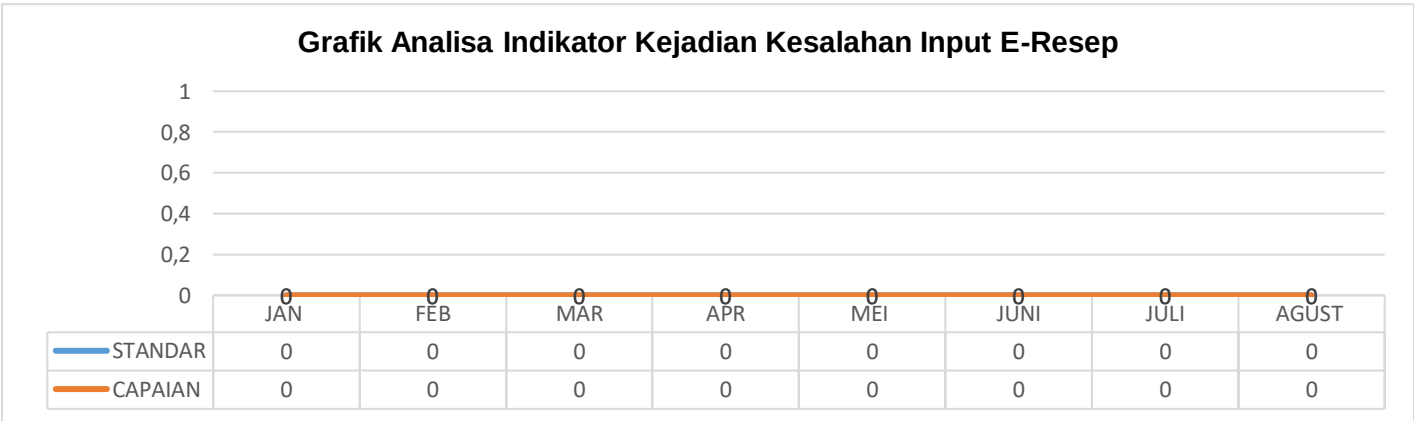


Analisis:

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2024.

3.6.1.2.2.10 Kejadian Kesalahan Input E-Resep

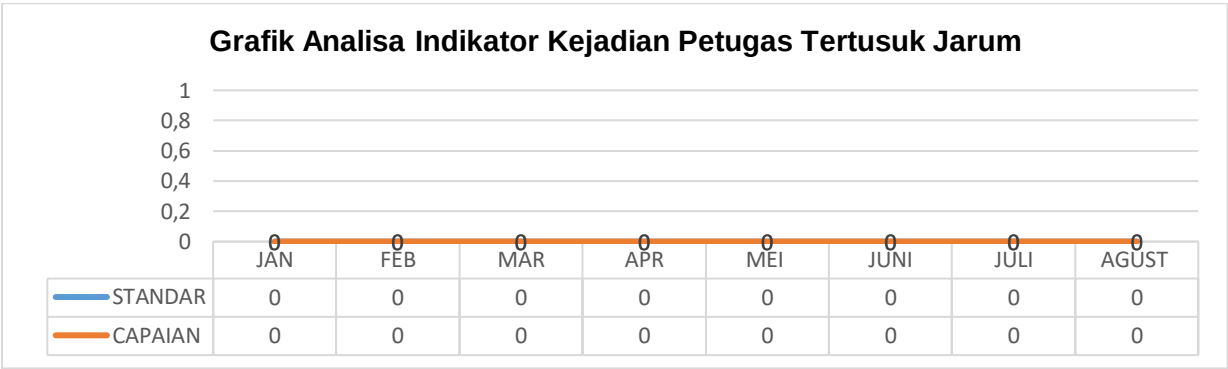
3.6.1.2.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep



Analisis :

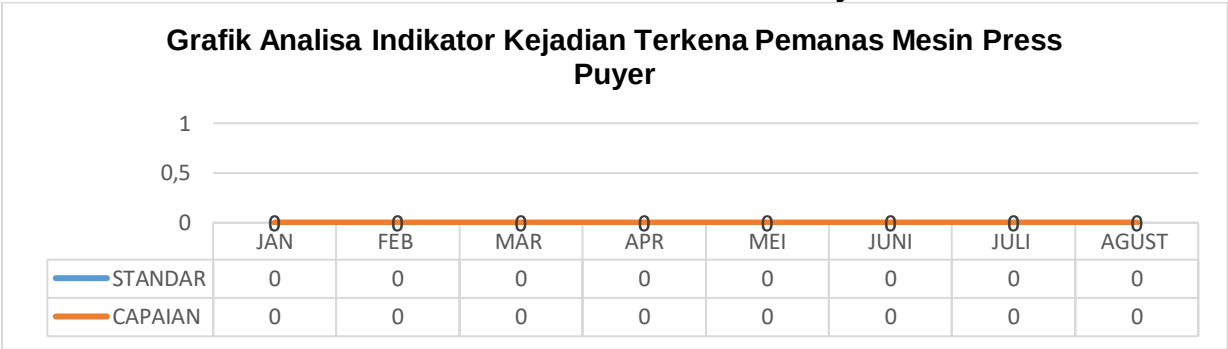
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024.

3.6.1.2.2.11 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
3.6.1.2.2.11.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



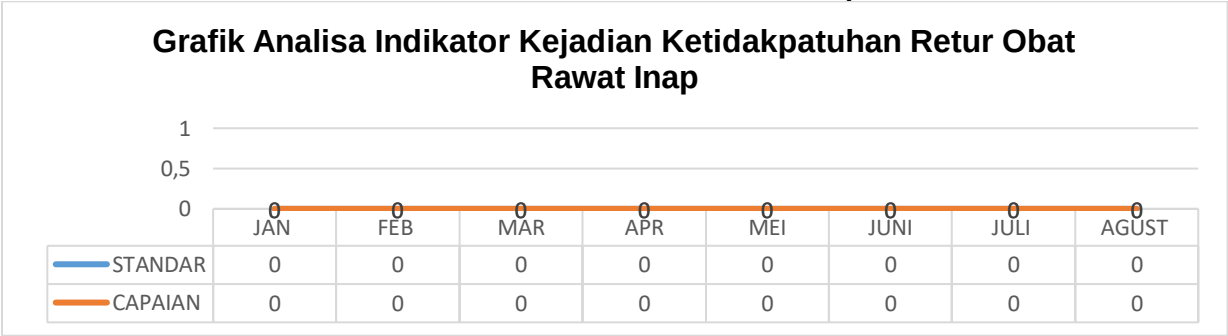
Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2024.

3.6.1.2.2.12 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer
3.6.1.2.2.12.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



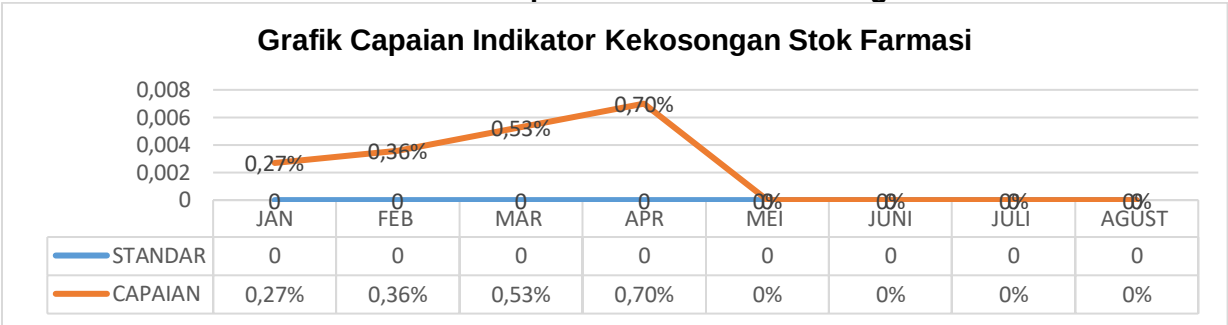
Analisis :
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2024.

3.6.1.2.2.13 Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap
3.6.1.2.2.13.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidapatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisis Capaian :
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidapatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2024.

3.6.1.2.2.14 Kekosongan Stok Sediaan Farmasi
3.6.1.2.2.14.1 Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi

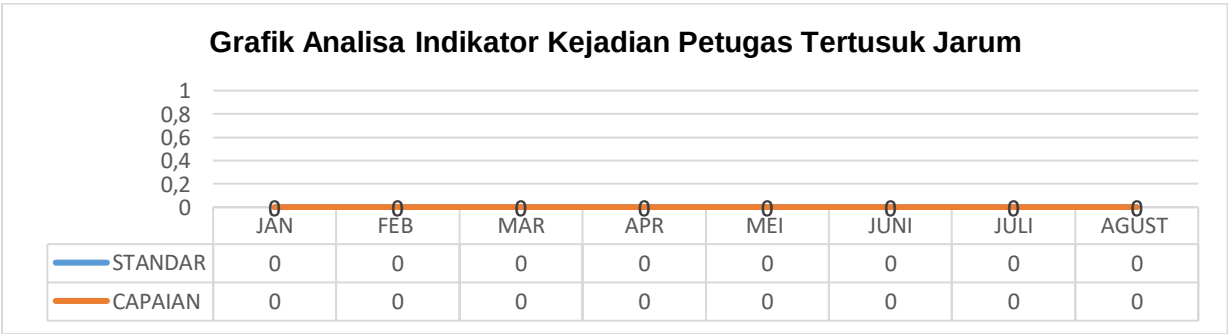


PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi pada bulan Januari hingga April. Pada bulan Mei hingga Agustus masih ada kekosongan obat teratasi dengan adanya substitusi sehingga tidak mengganggu pelayanan. Kekosongan obat farmasi disebabkan karena : 1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf 2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada 3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan 4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali 5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf 6. Ijin edar obat tertentu belum di setujui bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	1. Kepala Instalasi farmasi 2. Pengadaa n Farmasi PT	Satu bulan

3.6.1.2.3 Manajemen Resiko

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0

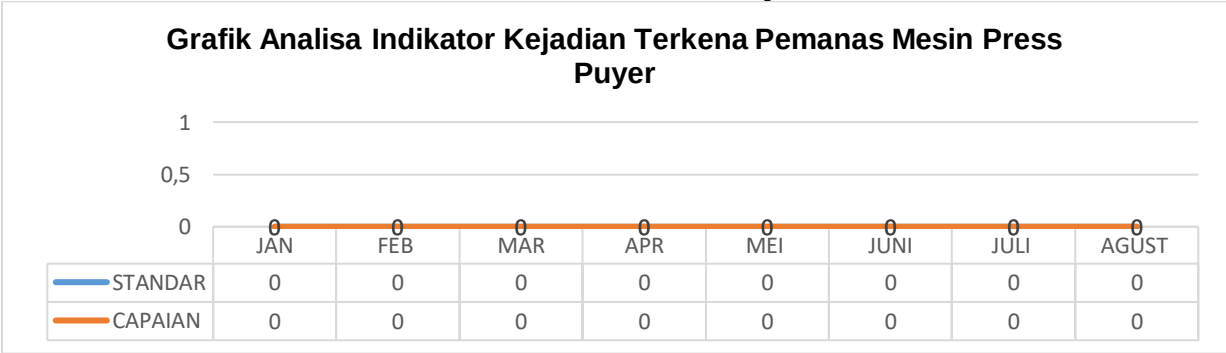
3.6.1.2.3.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
3.6.1.2.3.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	1. Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. 2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.3.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.1.2.3.2.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:
 Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2024.

3.6.1.3 Mutu Unit

3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25 %	100%	100%	100%	100%	97,35 %	100%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17%	0%	0,28%	0,15%	0,67%	0,15%	0,29%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85%	0,61%	0,73%	0,5%	2,61%	1,62%	1,82%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.2.1.3.2 IRNA 2A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%					97,64%	100%	100%	-
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%					45,54%	76,92%	90%	-
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%					-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%					100%	100%	100%	-
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%					0%	0%	0%	-
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%	-
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%					100%	100%	100%	-

3.2.1.3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41%	100%	97,22%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53%	74,84%	73,57%	73,23%	62,6%	62,6%	62,6%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-	0%	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93%	100%	93,75%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,03%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%	97,14%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	86,36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18 %	89,4%	91,28%	80,29%	87,79%	91,45%	86,99%	84,21%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,61%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96 %	87,65%	82,43%	83,94%	89,17%	91,45%	93,15%	92,11%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84%	78,23 %	86,54%	86,84 %	89,19 %	95%	95%	92,86%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-

4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,85%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,75 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	97,4%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%	0%	0,39%	0%	0,94%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07%	66,86%	64,86%	55,35%	67,48%	67,48%	66,67%	68,42%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%	0%	0%	0%	0%	0,52%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13%	97,75%	93,02%	96,38%	95,58%	95,58%	94,59%	96,33%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.7 IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11 %	79,63%	84,92%	83,21%	82,79%	76.47%	71,01%	79,69%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,39%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	3,57%	3,85%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.8 IRNA 7A										
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,22 %	76,67%	75%	84,56%	76,74%	63,78%	72,73%	72,44%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,67 %	100%	100%	100%	97,12%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%	0%	0,9%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	86,52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,09%	100%	100%

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A										
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	92,21 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39%	78,49 %	81,45 %	84,56%	71,76%	75,93 %	82,14%	89,23%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15 %	100%	100%	96,72%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	98,91 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.10 ICU										
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7%	100%	100%	94,4%	98,8%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%								
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8%	92,53 %	86%	90,4%	100%	100%	80%	90,2%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	83,33%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%	90,7%	95,4%	94,4%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-

3.2.1.3.2.11 HCU										
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien	100%	100%	100%	100%	96,3%	100%	100%	100%	100%

	Jatuh									
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	%

3.2.1.3.2.12 IRJA

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75 %	100%	95,71 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74 %	52,7%	63.8%	72,8%	80,97 %	85,74%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	84,42 %	82,35 %	84,04 %	84,04 %	70,04 %	81,72 %	81,72 %	81,88%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%	37,03 %	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.13 Maternitas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,63%	100%	94,67%
6	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0	0	0	4	0
10	Kejadian partus lama	0	1	0	0	0	0	3	4	1
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0	0	0	0	4
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85%	11,38%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%	5,69%	10,85%	11,38%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.14 NICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92 %	90,63 %	84,72 %	90,8%	84,82 %	82,35 %	88,79 %	81,01%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	0%	0%	3,7%	1,28%	4,55%	0%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.15 IKO

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10	10	10	10	10	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08 %	0%	0%	20,3%	20,96%	23,81%

3.2.1.3.2.16 Laboratorium

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48 %	97,5%	98,9%	99,68 %	100%	98,03%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2	2	12	15	11
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.17 Radiologi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,54 %	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%	3,81%	3,81%	1,63%	0%	0%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.18 Gizi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0	0	0	0	1

3.2.1.3.2.19 Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100 %	70,26 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,8 1%	69,59 %	73,43 %	79,11 %	78,13 %	75,45 %	71,82 %	71,82%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,4 8%	50,77 %	56,18 %	61,29 %	58,52 %	54,92 %	50,64 %	50,64%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGST '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.21 PPI

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGUST '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %	0,24 %	0 %	0,25 %	0,52%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%	0,15%	0,15%	0,04%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53 %	85,62%	85,62%	85,42%	%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%	93,73%	93,73%	93,92%	93,24%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%	92,19%	92,18%	92,07%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	1

3.2.1.3.2.22 PIPP

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGST '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89 %	99,63 %	99,82 %	99,63 %	99,63 %	99,63 %	99,38 %
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94 %	75,31 %	57,76 %	52,92 %	55,36 %	55,36 %	43,54 %	38,63 %

3.2.1.3.2.23 SDM

NO	JUDUL	STAN D	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGST '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0	1	2	0	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99 %	98,97 %	99,14 %	98,76 %	95,9%	98,93 %	98,96 %	99,62%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%	4,12%	5,09%	3,88%	3,48%

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGUST '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65 %	93,04 %	94,08 %	93,81 %	93,56 %	92,8%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06 %	9,44 %	7,88%	5,68 %	4,56 %	5,91%

3.2.1.3.2.25 Keuangan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGUST '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim	0%	7,7%	6%	3,86%	10,98 %	1,57%	0,78%	0,81%	1,1%

2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.26 K3RS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGUS T '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGUST '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04 %	0,78 %	0,97 %	0,87%	0,62%	0,89%	0,26%
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04 %	2,17 %	1,66 %	2,55%	1,66%	1,31%	2,21%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57 %	0,44 %	0,42 %	0,47%	0,46%	0,55%	0,26%
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1	0	0	0	1

3.2.1.2.28 IPSRS

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGUST '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%	89,47 %	91,67 %	91,67 %	91,84 %	100%

3.2.1.3.2.29 UMUM

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGST '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3	6	6	2	2
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2	4	5	9	6

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGST '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	0,25%	1,67 %	29,17 %	28,95 %	91,67 %	3,45%	8,7%	18,75%

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGST '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21 %	0%	20,69 %	78,38 %	48,72 %	26,67 %	36,59 %	42,5%

2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5%	71,83 %	56,25 %	41,67 %	0%	68,75%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71 %	86,21 %	22,73 %	17,86 %	0%	12,82%

3.2.1.3.2.31 Laundry

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGST '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95%	4,19%	1,35%	1,48%	0,96%	2,42%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.33 CSSD

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JULI '24	AGST '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1	1	1	2	1

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34	APR '24	MEI '24	JUNI '24	JULI '24	AGST '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17 %	90,88 %	100%	100%	100%	98,65 %	99,64 %	99,8%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82 %	92,82 %	91,73 %	87,44 %	94,21 %	92,72%

3.2.1.3.2.35 IT

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Respontime penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

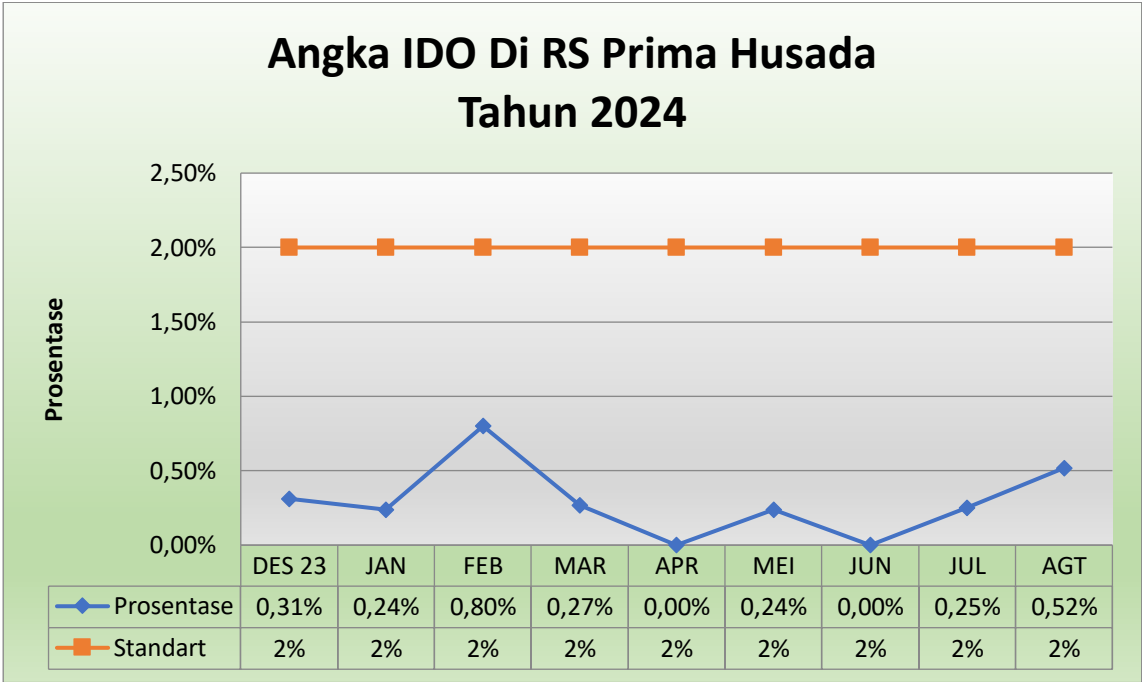
NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24	JUN '24	JUL '24	AGT '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.2.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

3.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):

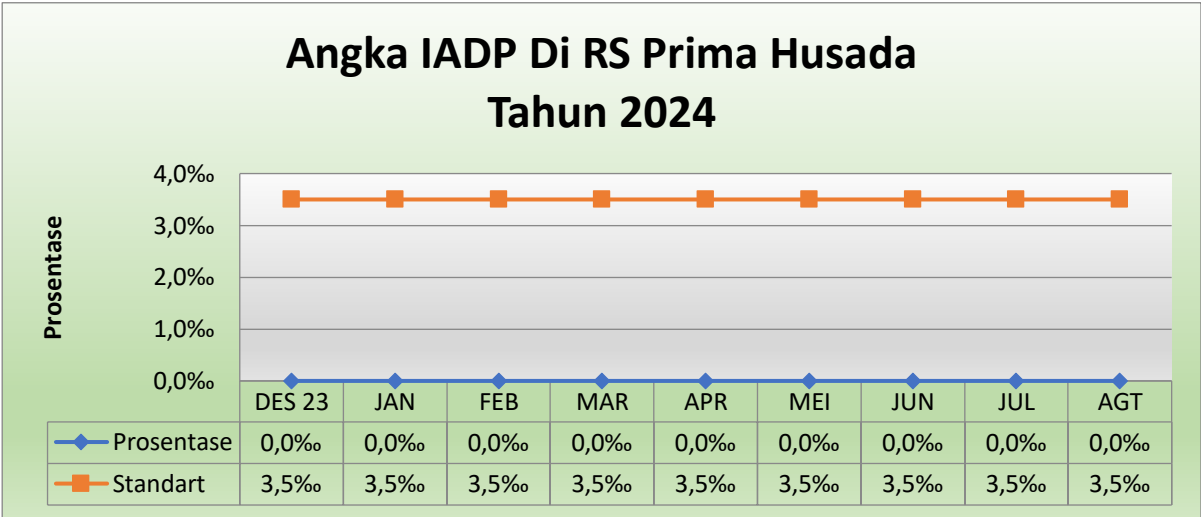


PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka IDO seminimal mungkin. (0%)				
DO	1. Melakukan koordinasi dengan DPJP obgyn terkait Teknik aseptik pada saat melakukan perawatan luka maupun prosedur operasi. 2. Melakukan koordinasi dengan tim Kamar operasi terkait penggunaan kamar operasi dan pembersihannya saat ada operasi estafet (memakai kamar operasi yang berbeda, jika kamar operasi lainnya kosong). 3. Melakukan koordinasi dengan petugas unit perawatan untuk tetap menjaga Teknik aseptic saat melakukan proses perawatan luka pasien. 4. Berkoordinasi dengan ahli gizi dan perawat unit untuk pemantapan proses edukasi pasien terutama diit pasien pada saat pasien dirawat atau akan KRS. 5. Monitoring pembersihan alat dan kebersihan ruang kamar operasi tetap dilakukan secara rutin. 6. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai SPO.				
STUDY	Ditemukan dua kasus IDO pada bulan ini pada pasien post SC. Salah satu pasien memiliki Riwayat hipertensi dan seperti alergi plester. Diit keseluruhan pasien juga normal. Satu pasien jadwal operasinya tidak bersamaan dengan pasien lainnya (tidak estafet). Pasien satunya memang dilakukan operasi pada saat estafet 5 pasien operasi dan pasien tersebut ada pada urutan ke 2 dengan selisih waktu 30 menit, dimana di ruang operasi lainnya juga sedang dilakukan operasi dengan DPJP lain. Pasien ke dua sebelumnya sudah mengalami leukositosis (peningkatan kadar leukosit), dimana berisiko untuk terjadinya IDO.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan bundle IDO.	Pertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IDO.	Kepatuhan audit bundle IDO meningkat 3% pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian handscon steril saat rawat luka. 3. Monitoring kepatuhan mandi dengan air sabun sebelum operasi. 4. Monitoring kepatuhan penggunaan alat cukur satu kali pakai dan pembersihan wadah alat cukur yang dipakai berulang. 5. Monitoring kepatuhan petugas dalam menjaga aseptic saat melakukan rawat luka/tindakan bedah.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

Evaluasi proses pembersihan kamar operasi	Meminimalisir risiko terjadinya infeksi daerah operasi.	Penurunan kasus IDO pada operasi estafet.	1. Koordinasi dengan Karu IKO terkait penjadwalan pasien operasi estafet. 2. Mendahulukan pasien operasi bersih (non infeksi) jika kamar operasi dipakai estafet. 3. Mengevaluasi proses pembersihan kamar operasi saat dilakukan operasi estafet.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN 5. CS	Satu bulan
---	---	---	--	---	------------

3.6.1.1.2 IADP

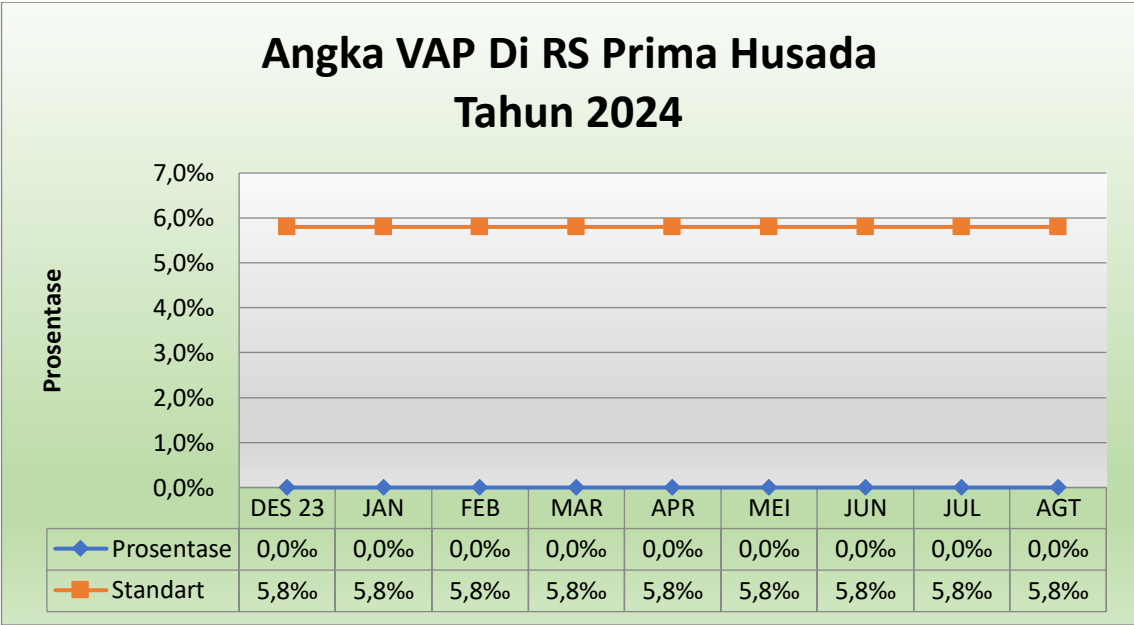
3.6.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka IADP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle IADP sesuai standart.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 7 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Kepatuhan bundle IADP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

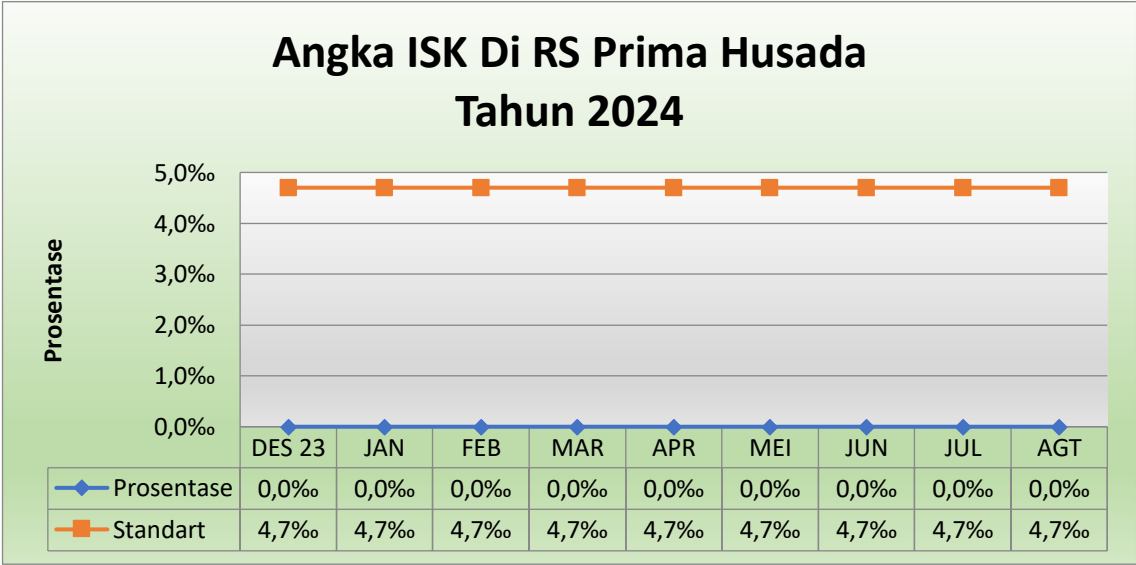
3.6.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka VAP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle VAP sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 45 hari lama pemasangan ventilator.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP.	Kepatuhan bundle VAP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral <i>hygiene</i> .	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.4 ISK

3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)

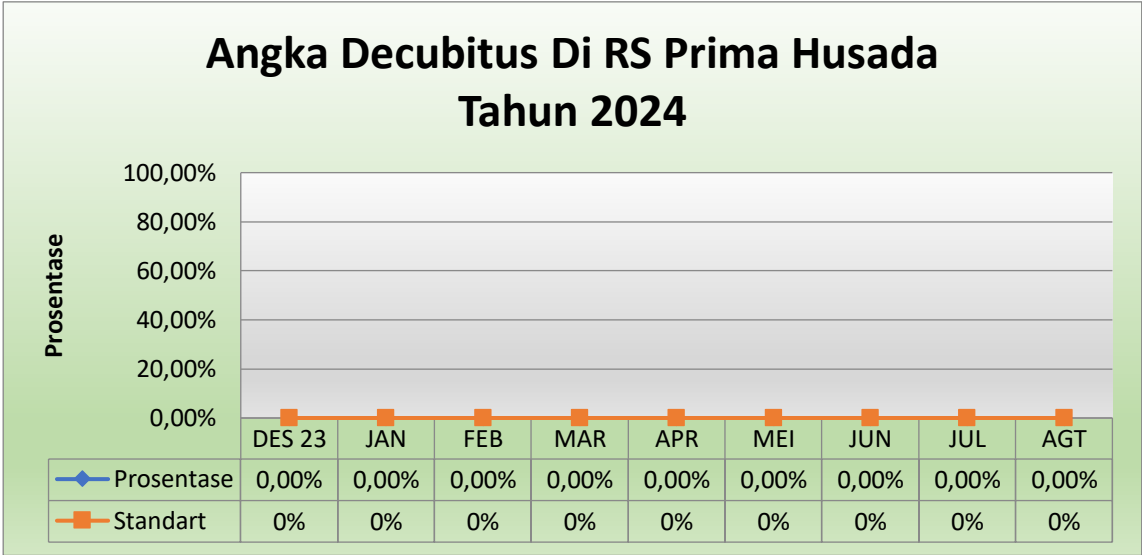


PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka ISK sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle ISK sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 957 hari lama pemakaian kateter pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
-----------------------------------	--	---	---	--	------------

3.6.1.1.5 Decubitus

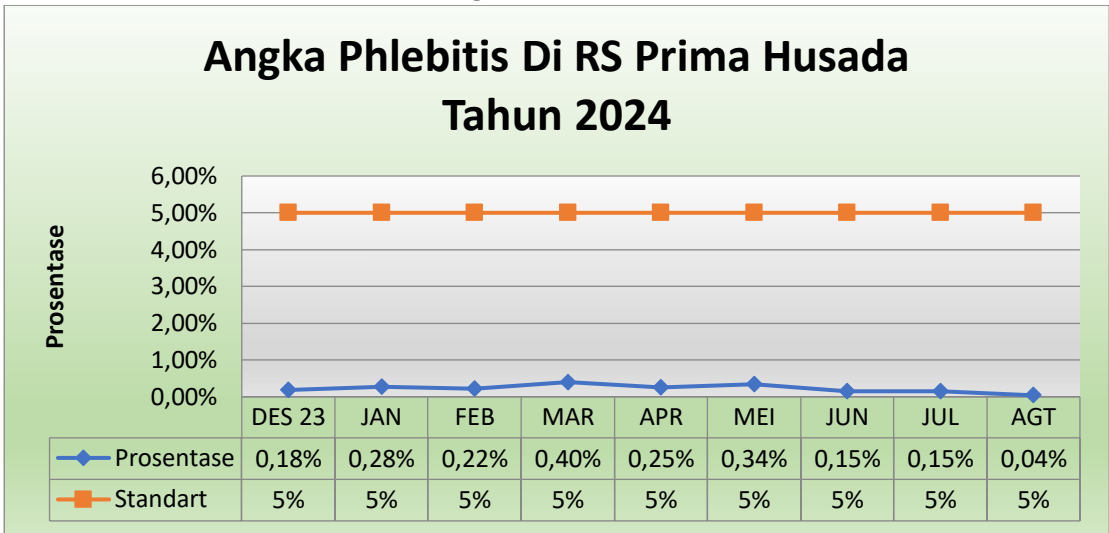
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka decubitus sesuai standart seminimal mungkin. (0%)				
DO	Monitoring pelaksanaan pencegahan decubitus pada perawatan pasien dengan tirah baring lama.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 23 pasien tirah baring lama (>3x24 jam).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Kepatuhan pencegahan dekubitus tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus. 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

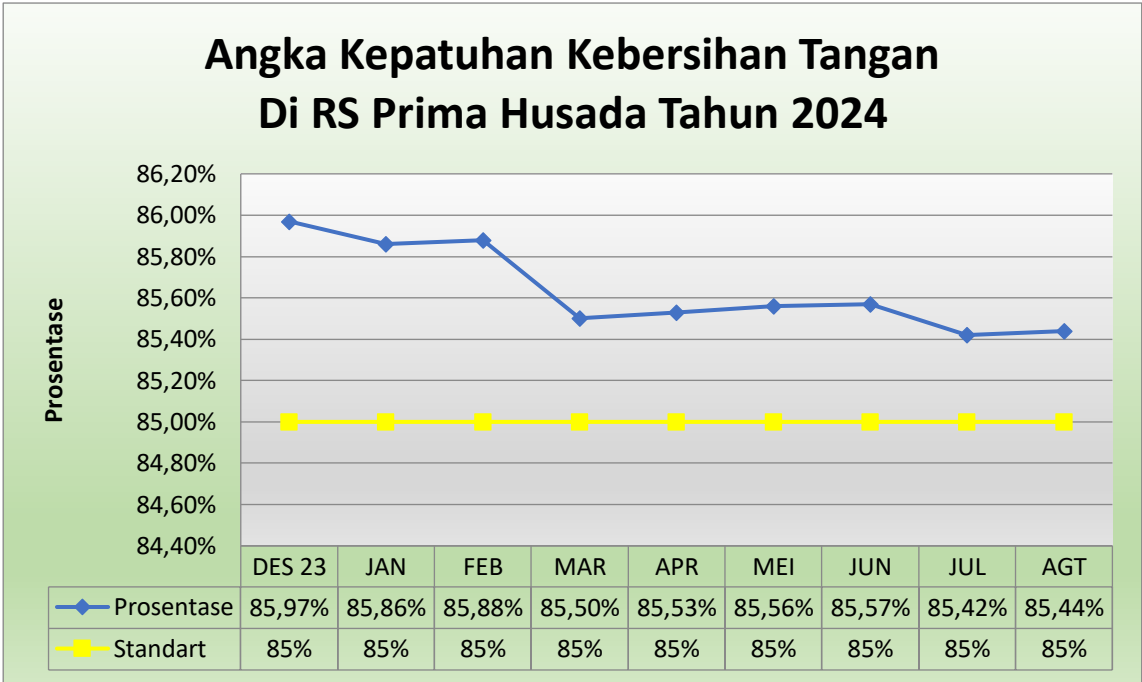


PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka phlebitis seminimal mungkin. (0%)				
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit bundle phlebitis sesuai SPO. 2. Melakukan sosialisasi kepada perawat tentang handhygiene dan pemakaian APD yang benar. 3. Berkolaborasi dengan komite keperawatan untuk melakukan supervisi berkala terkait prosedur pemasangan infus dan perawatan luka infus. 4. Monitoring pelaksanaan penyuntikan yang aman dan Teknik aseptic saat penyuntikan.				
STUDY	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2448 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,04%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, pasien yang mengalami phlebitis merupakan pasien dewasa yang mendapatkan terapi anti nyeri rutin. Karena obat yang pekat dapat menyebabkan risiko phlebitis lebih besar. Dari 4 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	1. Resosialisasi 5 moment cuci tangan. 2. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus. 3. Monitoring teknik aseptic dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 4. Monitoring penyuntikan yang aman. 5. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic. 6. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

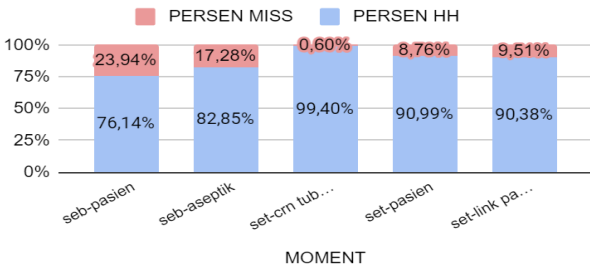
			pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. 7. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan.		
--	--	--	--	--	--

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

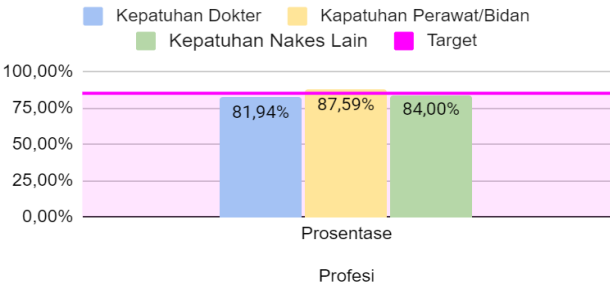
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



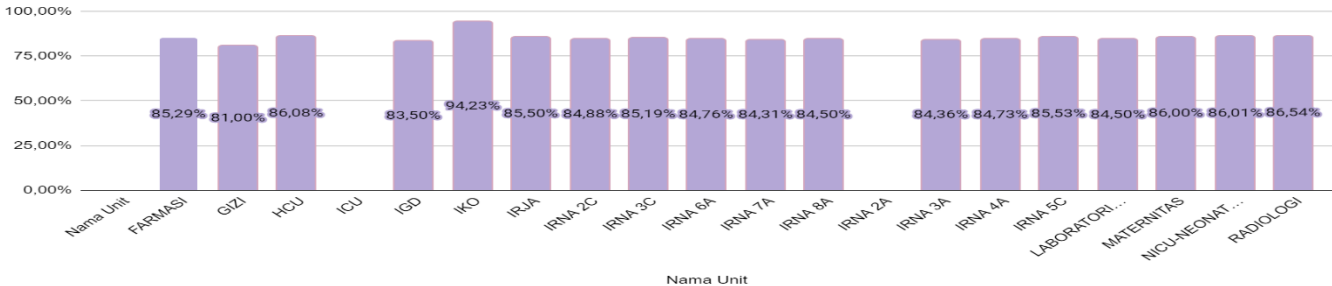
KEPATUHAN HH BERDASARKAN 5 MOMENT
AGUSTUS 2024



KEPATUHAN HH BERDASARKAN PROFESI
AGUSTUS 2024



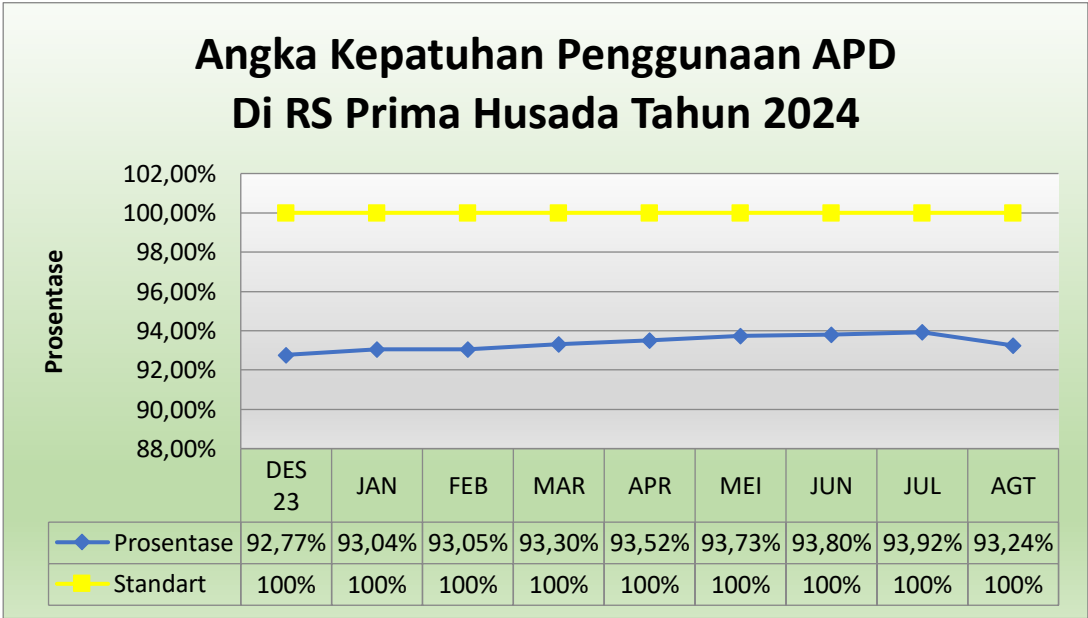
KEPATUHAN HH BERDASARKAN UNIT
AGUSTUS 2024



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. 2. Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. 3. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. 4. Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. 5. Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,44%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (81,94%) dan nakes lain (84,00%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (76,14%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Namun beberapa perawat sudah mengurangi penggunaan sarung tangan bedah sesuai dengan kebutuhannya saja. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	1. Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. 2. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 3. Memberikan reward-pembelajaran. 4. Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

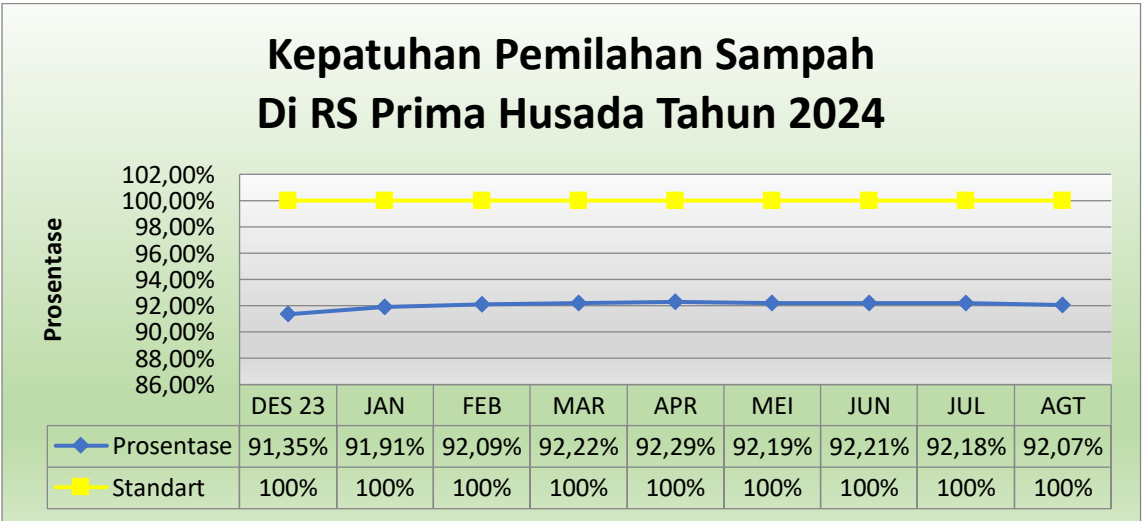
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	1. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,24% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit sudah mulai sedikit paham dan bisa menggunakan APD yang sesuai.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	1. Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. 2. Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidakpatuhan teman-teman di unitnya. 3. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 4. Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



	2. Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. 3. Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. 4. Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini ditemukan 1 kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) karena kecerobohan petugas IGD yang tidak langsung membuang sampah benda tajam (jarum) setelah digunakan dan bercampur dengan sampah domestic disekitar bed pasien sehingga mencelakakan petugas kebersihan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	JUN	JUL	AGT	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

Analisis : Beberapa unit mengalami penurunan dalam melakukan edukasi kelompok di unit

Rencana Tindak Lanjut : Koordinais dengan tim pkrs untuk evaluasi penurunan dan meningkatkan kembali penyuluhan komunitas

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	JUN	JUL	AGT	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	12	12		Isi sesuai	Ya	-
2	SBAR	12	12		Isi sesuai	Ya	-
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	12	10	2	Isi sesuai	Ya	Nama Petugas tidak terisi lengkap
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	12	12		Isi sesuai	Ya	
5	KIE Informed Consent	12	12		Isi sesuai	Ya	Nama Petugas Tidak terisi lengkap
6	CPPT	12	12		Isi sesuai	Ya	-
7	Ringkasan Pasien Pulang	12	12		Lengka p	Ya	Rujukan Edukasi berkelanjutan tidak diisi
8	Discharged Planning	12	12				
9	Edukasi kolaborasi	12	12		Isi sesuai	Ya	Pengisian setiap hari oleh perawat tidak dilakukan
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	1	1		Isi sesuai		
12	Form AMA	1	1		Isi Sesuai	Ya	
13	Semua Form yang ada Pemberian Informasi Ke Pasien	12	12		Isi Sesuai	Ya	
14	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	1	1		Isi Sesuai	Ya	

Analisis : Seluruh DRM edukasi terisi, akan tetapi pda penulisannya beberapa masih belum lengkap.

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi Ulang

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

NO	UNIT	TARGET	KEGIATAN	JUN	JUL	AGT	%	MANDOK	KET
1	Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						
2	Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	50%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Hypnoterapi						
			KIE						
3	Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
			Karya wisata						
4	Komunitas Shirothul Jannah Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

	Laki								
5	Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	Ada	
6	General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		100%		100%		Terlaaksana Kegiatan memperingati HUT RI	
7	Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	JUN	JUL	AGT	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	100%	100%		
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	100%	100%		
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	100%	100%		
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	50%	50%		
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		

- Analisis**
 : PROGNAS telah memulai Kegiatan Edukasi di bulan Juli
- Rencana Tindak Lanjut**
 : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat uningkatkan produktivitas Tim Prognas

3.6.4 Tim Prognas

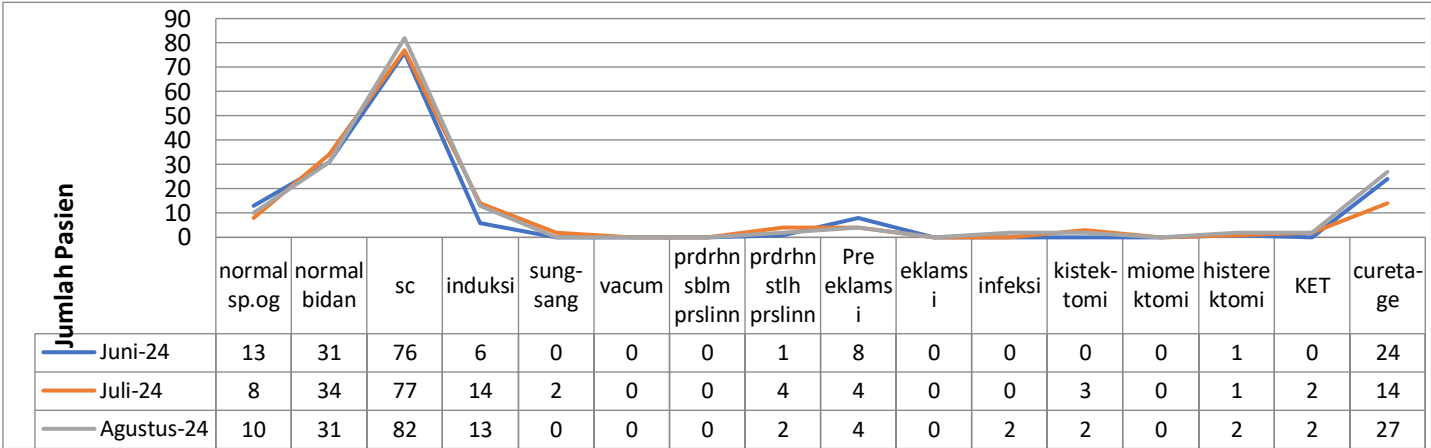
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Agustus 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	13	8	10
	b. Persalinan Normal Bidan	31	34	31
	c. <i>SectioCaesaria</i>	76	77	82
2				
	a. Induksi / Drip	6	14	13
	b. Sungsang	0	2	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	4	2
	c. Pre Eklamsi	8	4	4
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	0	0	2
4				

a. Curretage	24	14	27
b. Kistektomi	0	3	2
c. Miomektomi	0	0	0
d. Histerectomy	1	1	2
e. KET	0	2	2

3.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Agustus 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 82 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan Agustus 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 10 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 31 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Tidak ada persalinan dengan sungsang pada bulan Agustus dan Juni 2024, sedangkan pada bulan Juli 2024 terdapat 2 persalinan sungsang. Sedangkan untuk persalinan dengan vacum pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2024 tidak ada.
4. Induksi Persalinan pada bulan Agustus mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya yaitu 13 pasien
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Juli dan agustus 2024 tetap sejumlah 4 pasien, sedangkan pada bulan Juli 2024 sejumlah 8 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2024.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan Agustus meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 27 pasien. *Curretage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.

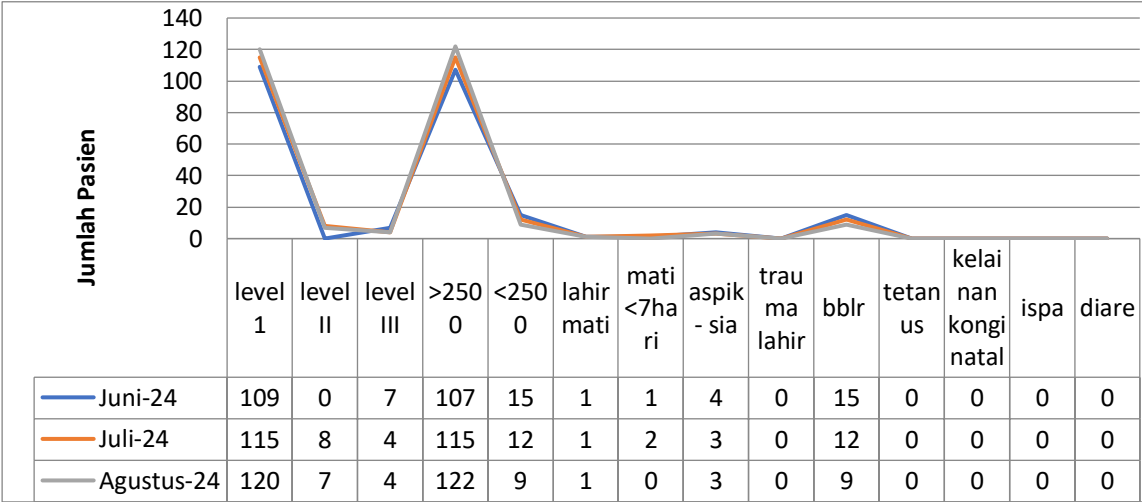
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponек Agustus 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1				
	a. Level 1	109	115	120
	b. Level II	6	8	7
	c. Level III	7	4	4
2				
	a. ≥ 2500 gram	107	115	122
	b. ≤ 2500 gram	15	12	9
3				
	a. Kelahiran Mati	1	1	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	1	2	1
4				
	a. Asphyxia	4	3	3
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	15	12	9
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

- Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Agustus 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 120 bayi. Dan pada level 2 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 7 bayi. Sedangkan pada level 3 tetap seperti dengan bulan sebelumnya yaitu 4 bayi.

- 2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Agustus 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya tetap sebanyak 122 bayi.
- 3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Agustus 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4. Kasus BBLR pada bulan Agustus 2024 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 9 bayi.
- 5. Kasus kelahiran mati pada bulan Juni sampai Agustus tetap yaitu sebanyak 1 kasus
- 6. Tidak ada kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Agustus, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 2 bayi, dan 1 bayi pada bulan Juni

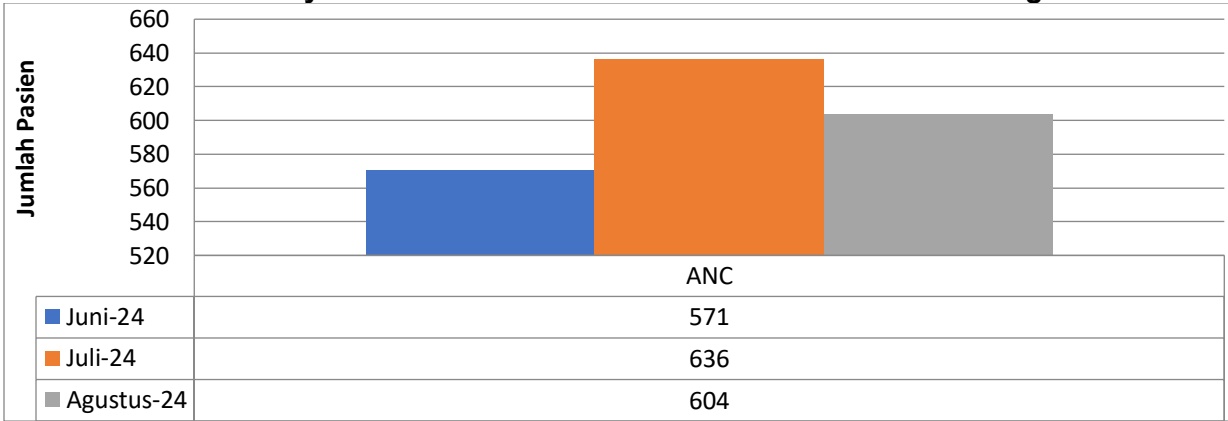
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek Agustus 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	ANC	571	636	604

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024

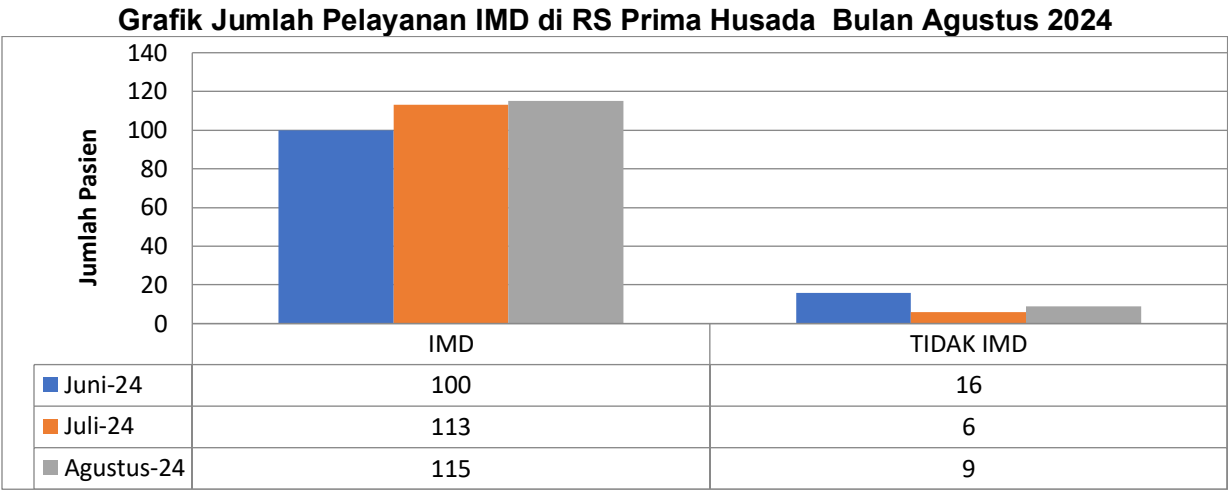


Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Agustus 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 604 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Agustus 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	IMD	100	113	115
2	Tidak IMD	16	6	9



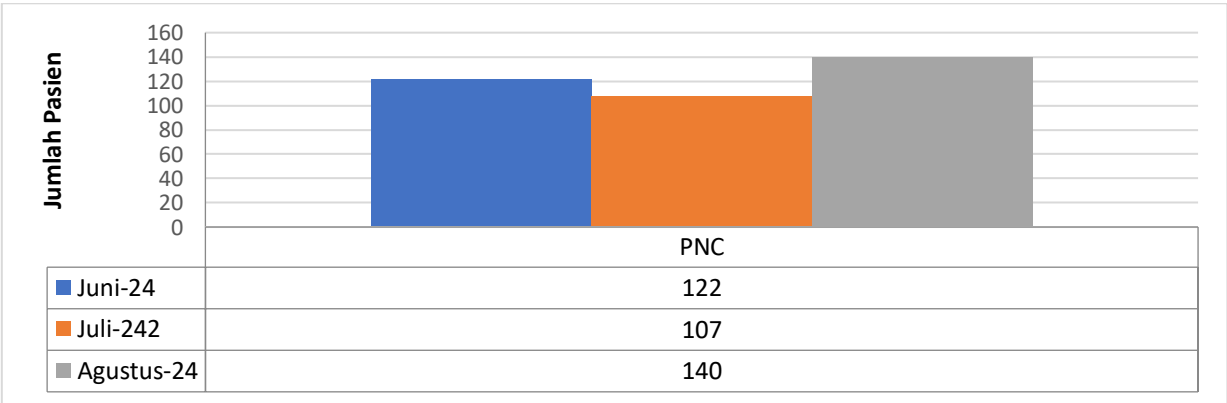
- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Agustus 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 115 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Agustus 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Agustus 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	PNC	122	107	140

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



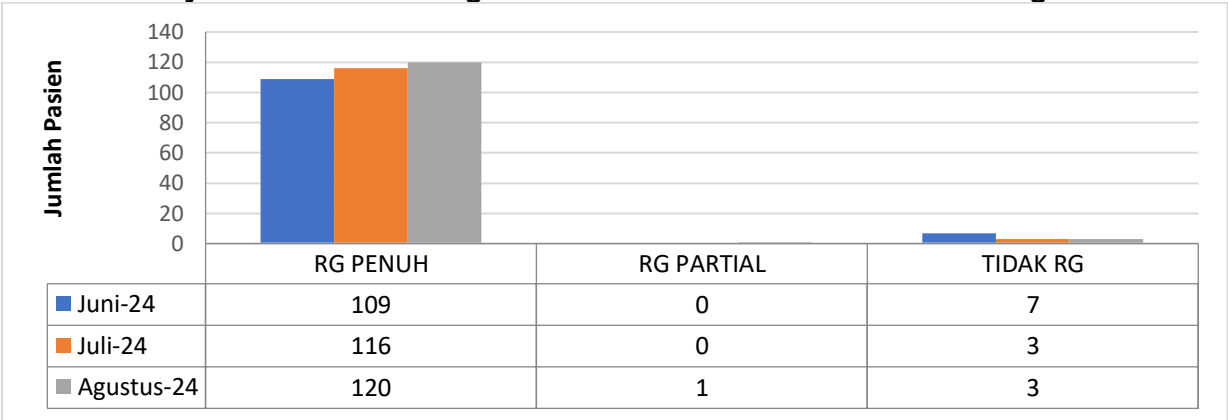
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 140 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Agustus 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	Rawat gabung penuh	109	116	120
2	Rawat gabung partial	0	0	1
3	Tidak Rawat gabung	7	3	3

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

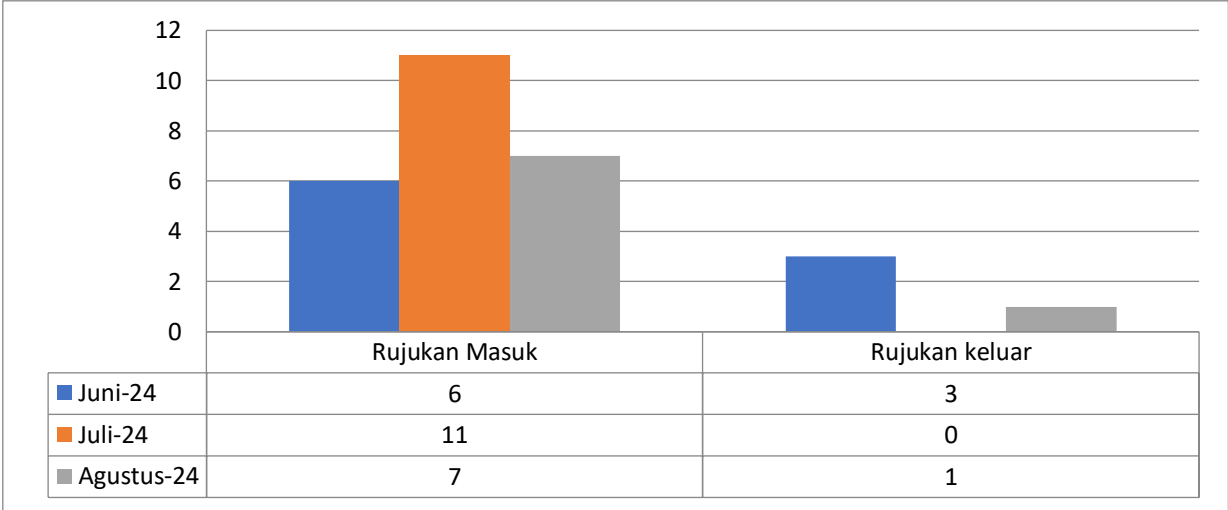
- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Agustus 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 120 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Agustus sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 3 bayi.
Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponek Agustus 2024

NO	RUJUKAN	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	Rujukan Masuk	6	11	7
2	Rujukan keluar	3	0	1

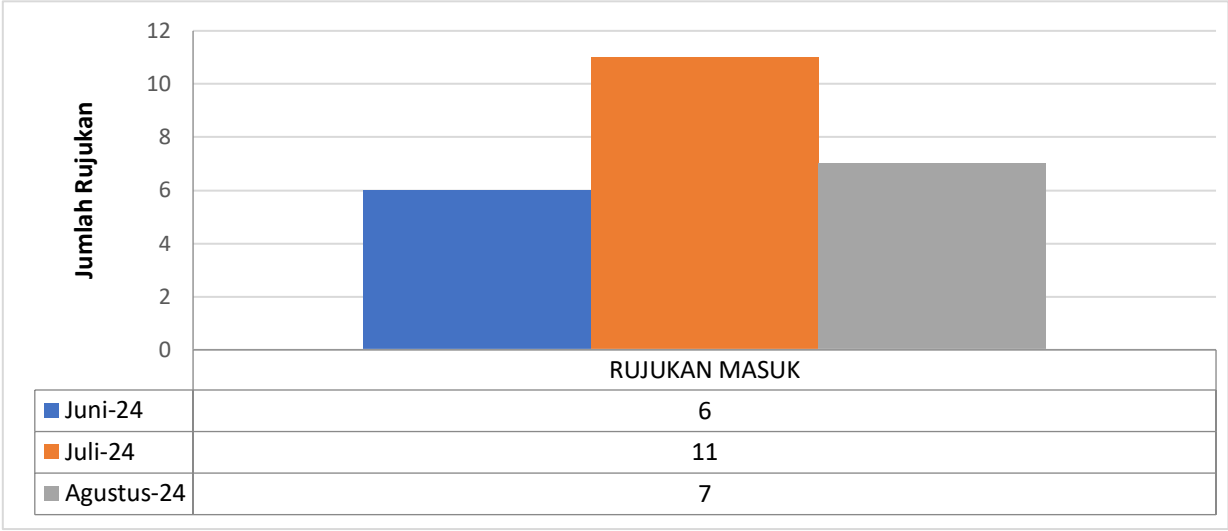
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Agustus 2024

BULAN JUNI 2024		
1	G3 P2002 Ab000 UK 31-32 mgg dg PEB + PPI + PTS	RS Permata Bunda
2	G3 P2002 Ab000 UK 12-14 mgg dg HEG	Klinik Mutiara Sehat
3	G2 P1001 Ab000 UK 40 – 41 mgg dg PE	BPM Indah M
4	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Tri Widiyawati
5	G4 P0302 Ab000 UK 28-30 mgg dg Letsu + BSC + KIFA	BPM Dillah Sobirin
6	G3 P1001 Ab100 UK 39-40 mgg dg Kala 1 fase aktif	BPM Susmui
BULAN JULI 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg KPD	BPM Siti Rubaiyah
2	P2002 Ab000 dg Post partum H-10 + late HPP	BPM Tri Widiyawati
3	G2 P1001 Ab000 Uk 37 mgg dg KIFA	BPM Suci Astuti
4	G3 P1001 Ab100 UK 38-39 mgg dg HT	BPM Sofia Faridah
5	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg Dg KPD + kala 2 lama	BPM Titik S
6	G3 P2002 Ab000 Uk 8 -10 mg dg Abortus Imminen + Apendicitis Akut	RS Permata bunda
7	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg dg TPHA reaktif	PKM Singosari
8	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFL + KPD + IUGR	PKM Singosari
9	G1 P0000 Ab000 UK 39 – 40 mgg dg HT Gestasional	PKM Singosari
10	G3 P0010 Ab100 UK 11-12 mgg dg abortus Inkomplit	PKM Singosari
11	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg PRM + OBS Febris+ leukositosis	PKM Ardimulyo
BULAN AGUSTUS 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 20-21 mgg dg KPD + PPI	PKM Singosari
2	G1 P0000 Ab000 UK 34-36 mgg dg KPD	Klinik Muslimat
3	G2 P1001 Ab000 UK 36-37 mgg dg KIFA + KPD	BPM Susmui
4	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg PEB + Obesitas	PKM singosari
5	G2 P1001 Ab000 UK 22-24 mgg dg IUFD	BPM Nukina
6	P2002 Ab000 dg post partum dg ruptur perineum	BPM Heni
7	Prematur + BBLSR + Asfiksia	BPM Sofia

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

Jumlah rujukan masuk pada bulan Agustus 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 7 rujukan masuk.

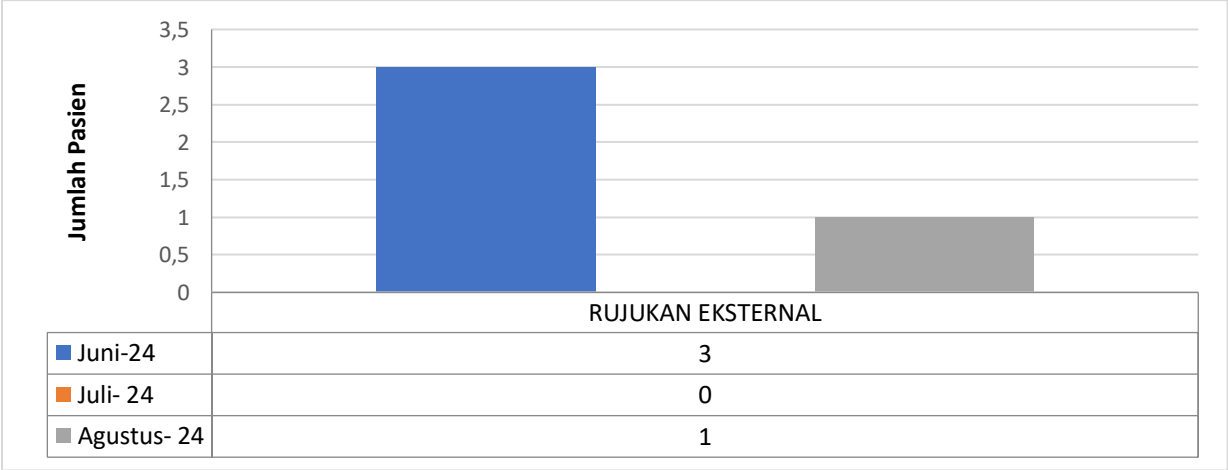
Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponek Agustus 2024

BULAN JUNI 2024		
1	G1 P0000 Ab000 Uk 37-38 mgg dg Kala 2 + letak Sungsang	RS Prasetya Husada
2	G3 P0101 Ab000 Uk 32-34 mgg dg PPI + DF+ Trombositopenia	RS Saiful Anwar
3	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar
BULAN JULI 2024		
BULAN AGUSTUS 2024		
1	RDS + BBLR	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

Pada bulan Agustus ada 1 pasien yang dirujuk keluar, sedangkan pada bulan Juli tidak ada pasien yg dirujuk dan 3 pasien pada bulan Juni 2024

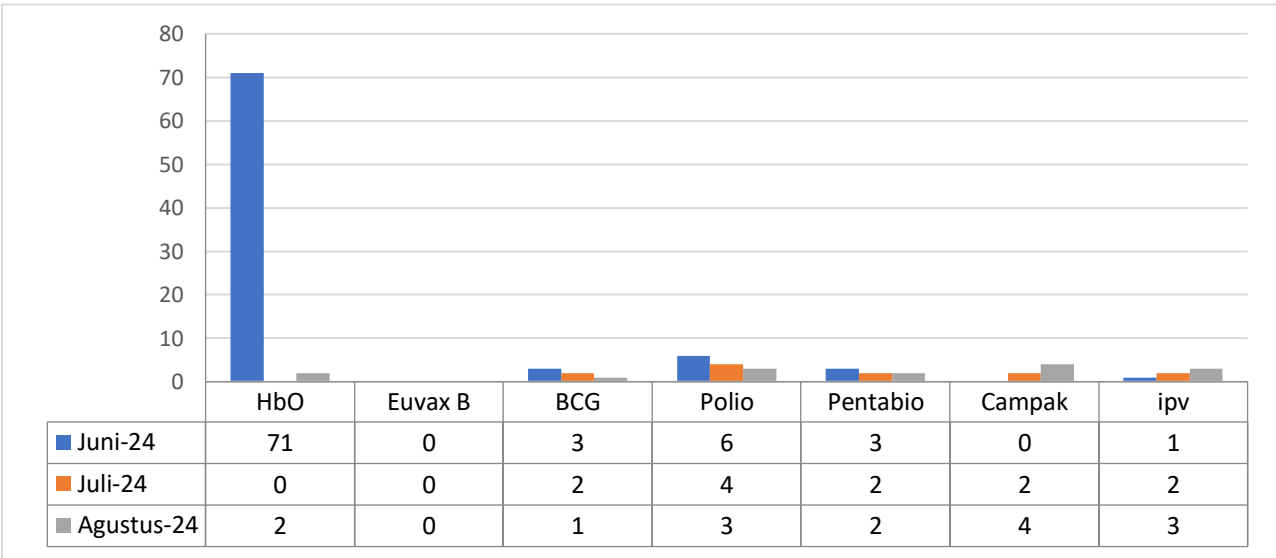
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Agustus 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	HbO	71	0	2
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	3	2	1
3	Polio	66	4	3
4	Pentabio	63	2	2
5	Campak	0	2	4
6	IPV	1	2	3

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Agustus 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Agustus 2024 sebanyak 2 bayi, dan tidak ada pada bulan Juli. Hal ini dikarenakan ketidakterSEDianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Agustus sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 3 bayi
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Agustus 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
5. Pada periode Agustus 2024 Imunisasi Campak mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 4 bayi
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Agustus 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 3 bayi
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Agustus 2024 sama dengan bulan Juli yaitu 2 pasien

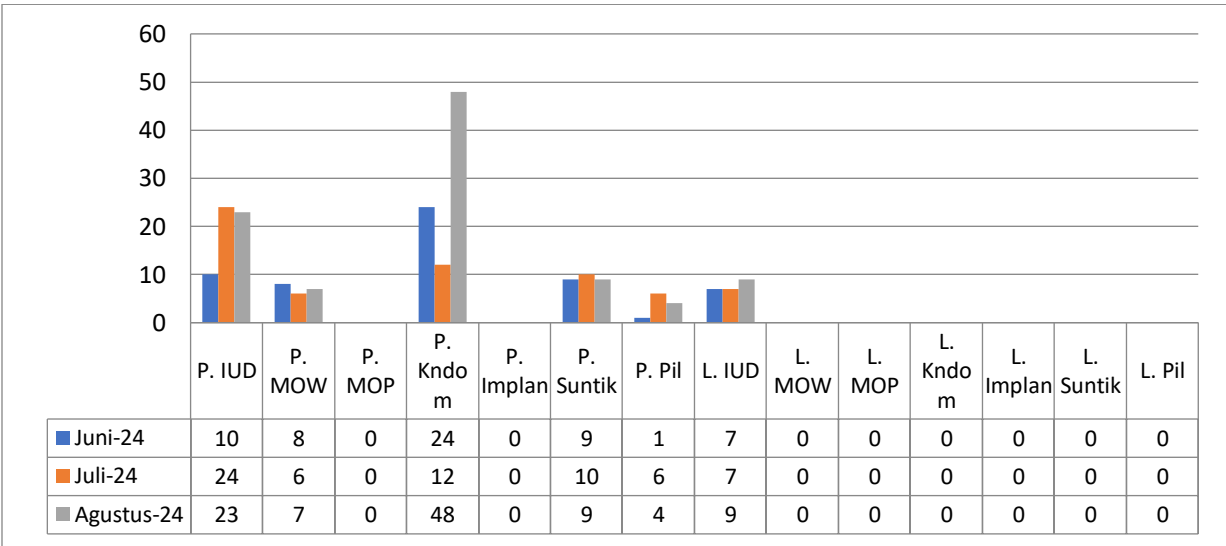
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek Agustus 2024

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024	BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	IUD	10	24	23	7	7	9
2	MOW	8	6	7	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	24	12	48	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	9	10	9	0	0	0
7	Pil	1	6	4	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Agustus sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 23 akseptor yang terdiri dari 10 akseptor IUD Nova T dan 13 akseptor IUD copper T
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Agustus 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 7 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu hanya 48 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Agustus 2024 mengalami sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 4 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Agustus 2024 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 penggunaan

Rencana dan Tindak Lanjut :

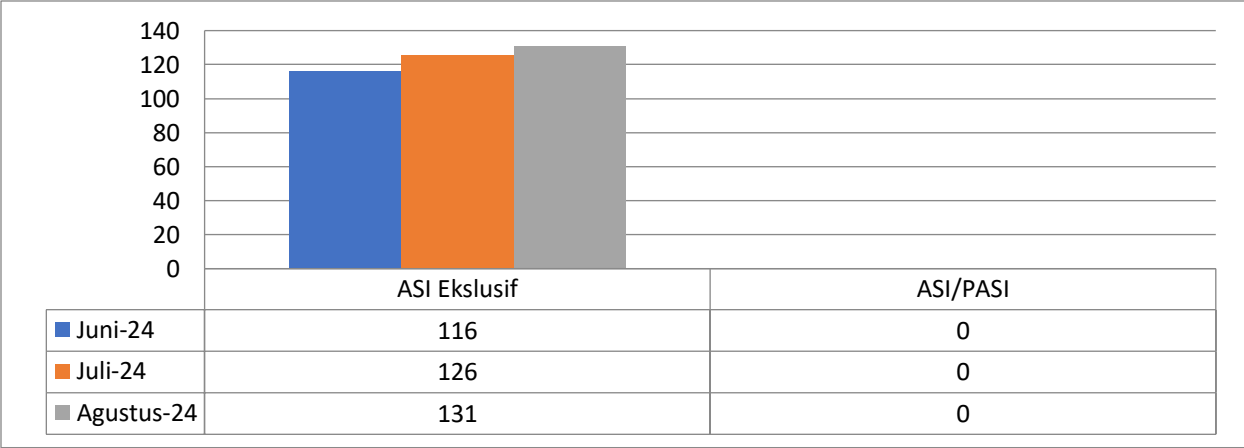
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponek Agustus 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	Asi eksklusif	116	126	131
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



- Analisis :
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 131 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

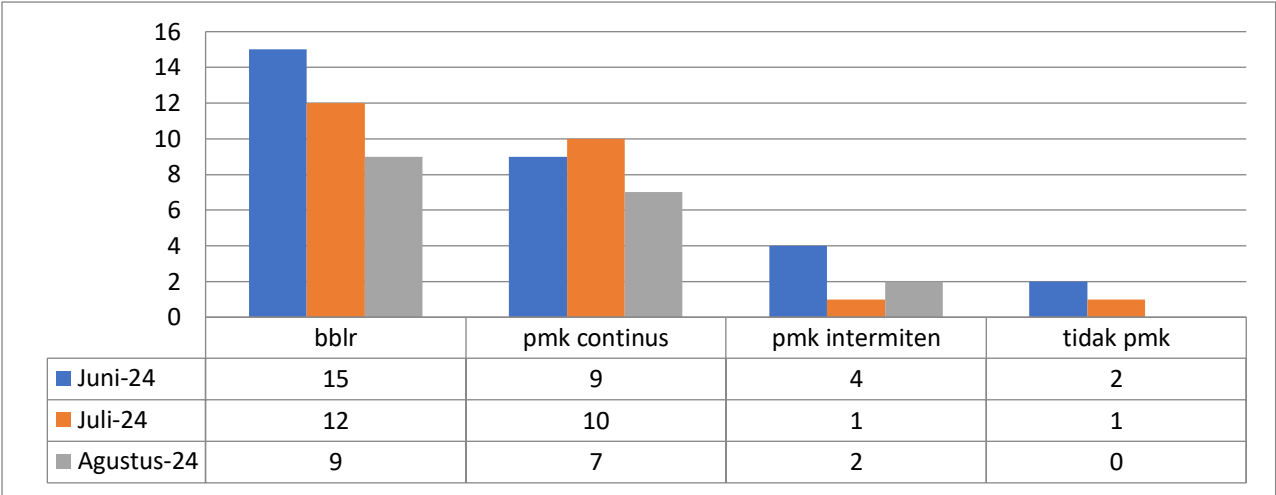
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Agustus 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	Bayi BBLR	15	12	9
2	PMK continuos	9	10	7
3	PMK Intermiten	4	1	2
4	Tidak PMK	2	1	0

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Agustus 2024 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, menjadi 2 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Agustus 2024 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 7 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan tidak ada bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Agustus 2024, sedangkan pada bulan Juli terdapat 1 bayi. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

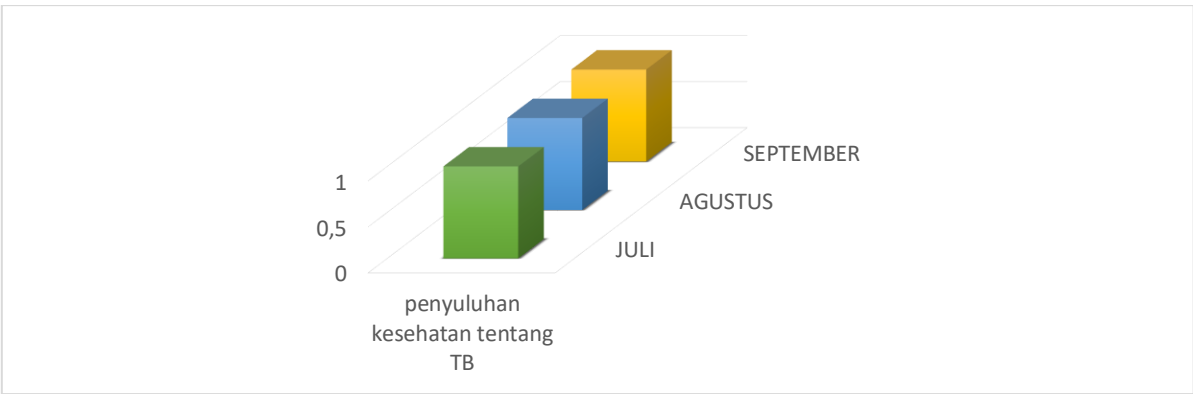
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

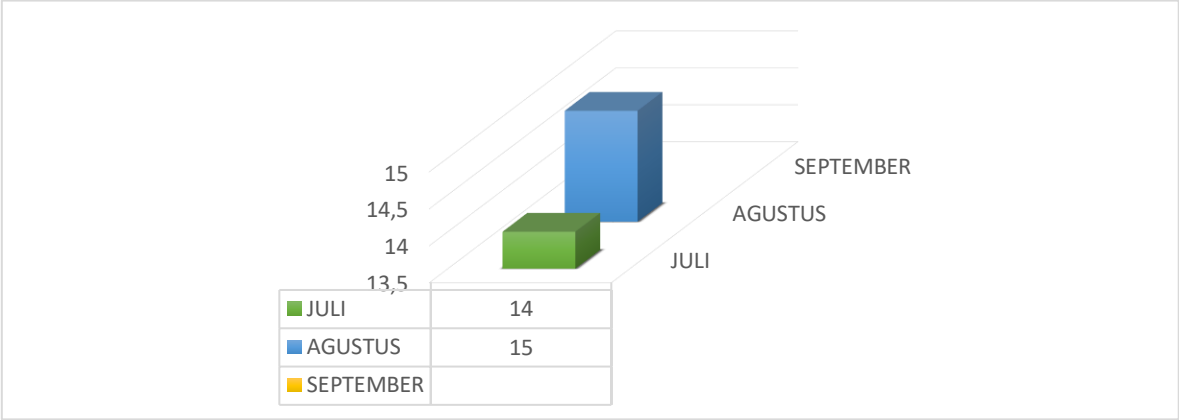
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dlls.

3.1.2.2.2 Skringing Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian Masker	14	15	

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skringing Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada



Analisis :

Pada bulan Agustus 2024 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

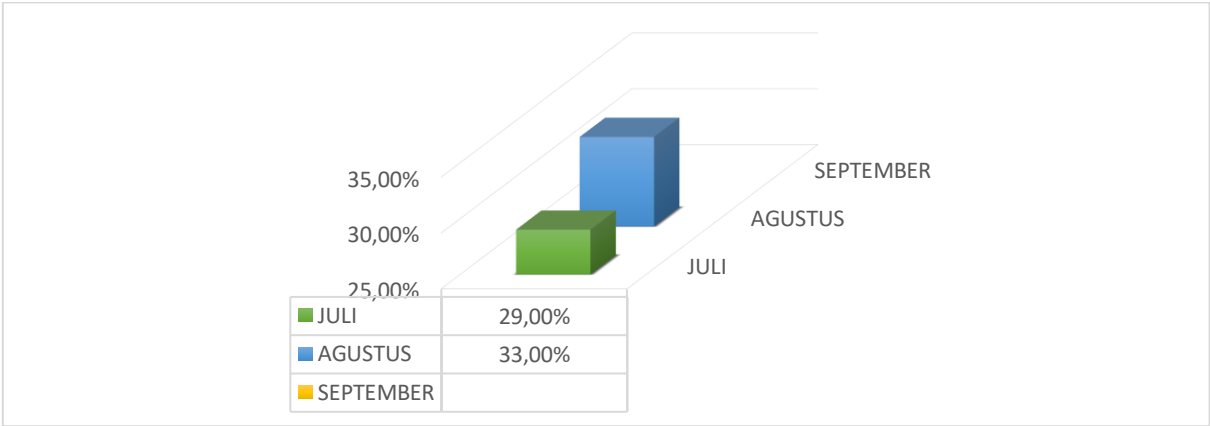
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	29	33	

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 29
- 2. Pada bulan Agustus 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 33

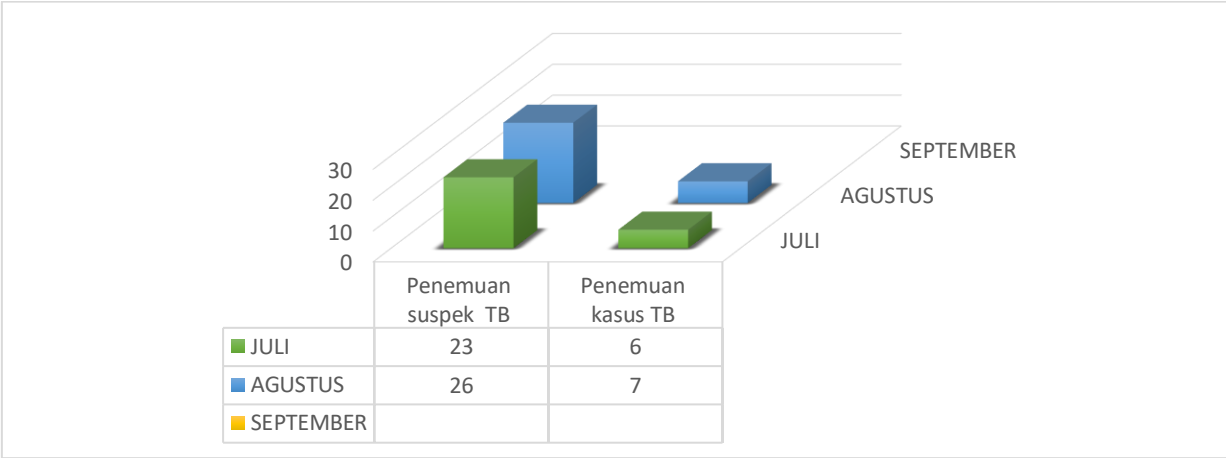
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penemuan suspek TB	23	26	
2	Penemuan kasus TB	6	7	

Grafik Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien
- 2. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien

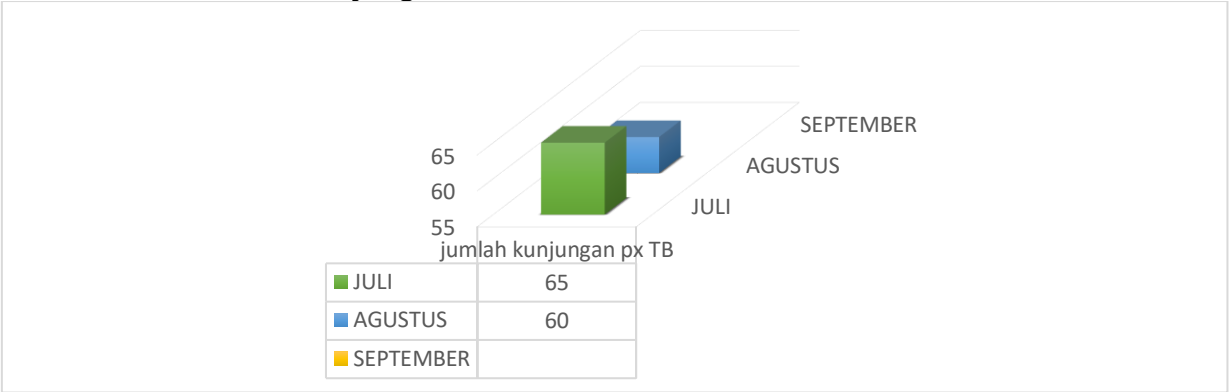
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	65	60	

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

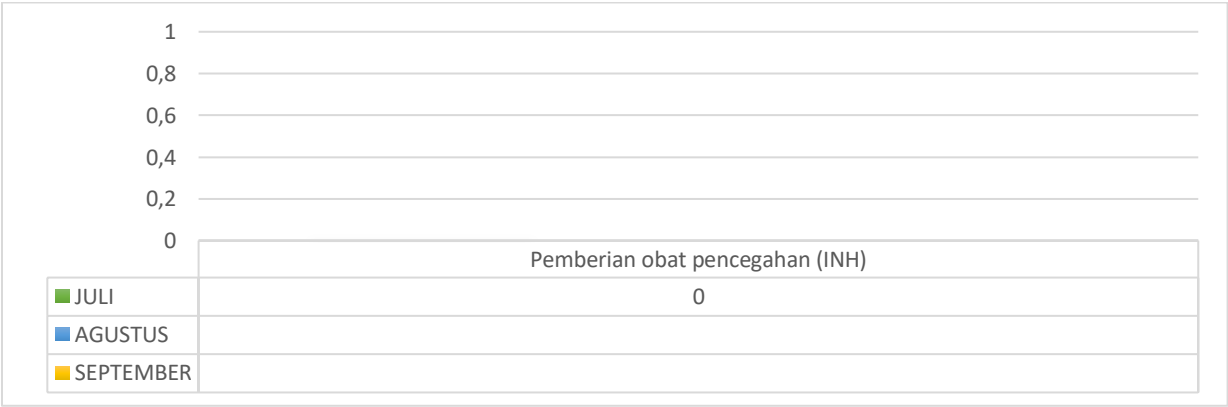
- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan JULI 2024 di poli pasien TBC mencapai 65 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan AGUSTUS 2024 di poli pasien TBC mencapai 60 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	

Grafik Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima



Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

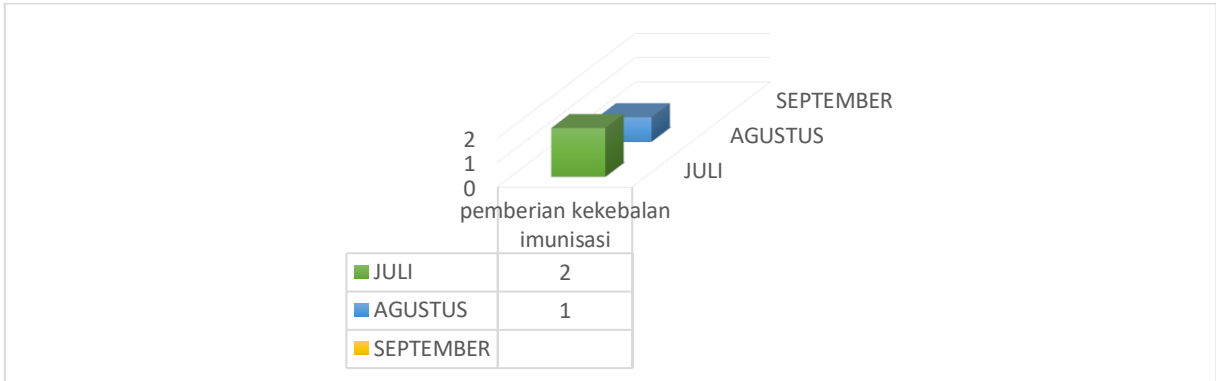
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	2	1	

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :
Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan JULI

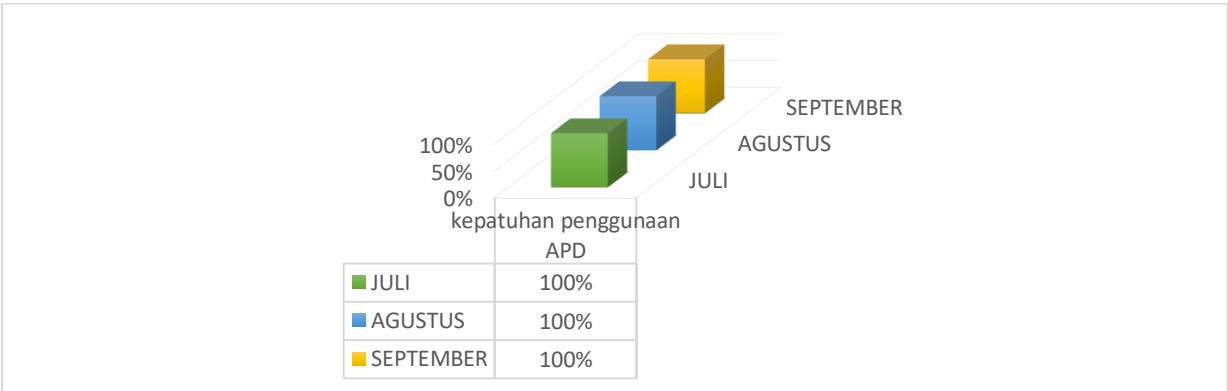
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



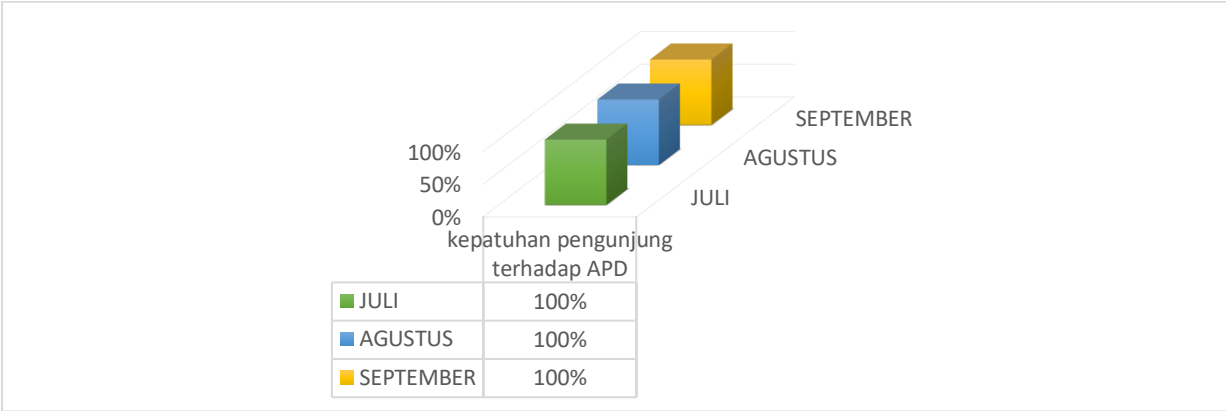
Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada



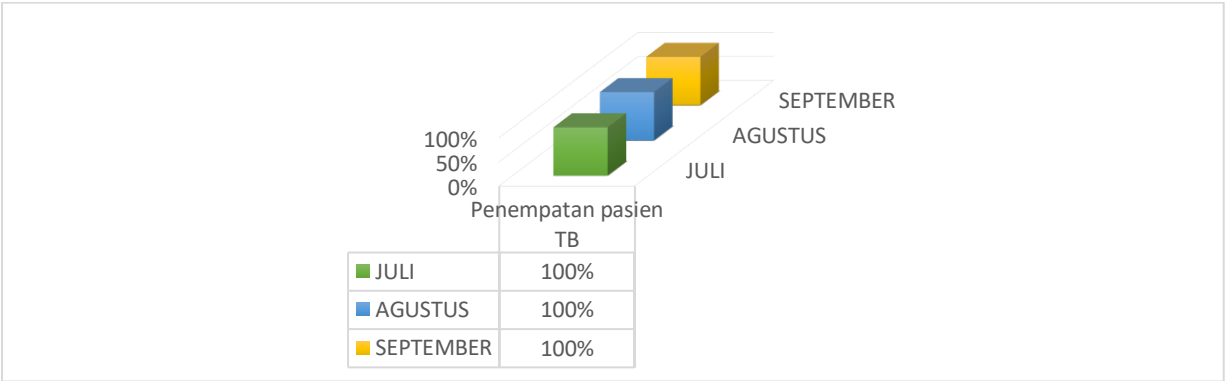
Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



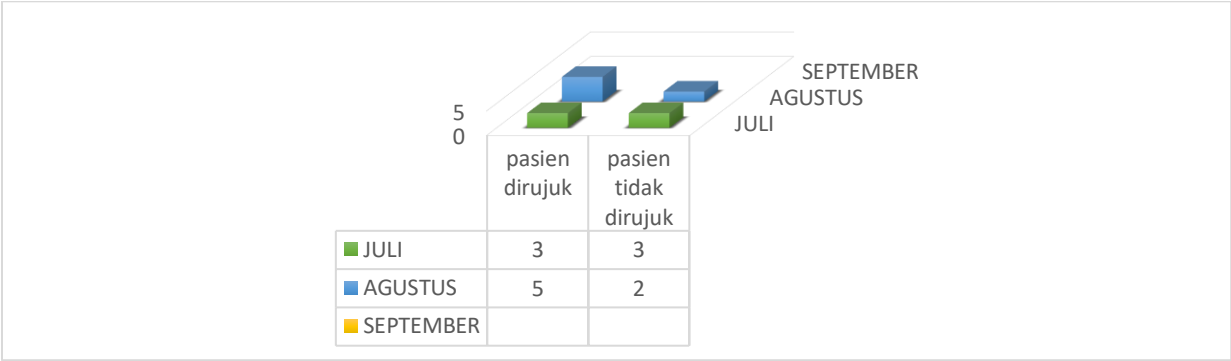
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB yang dirujuk	3	5	
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	3	2	

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli 2024 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 2. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya

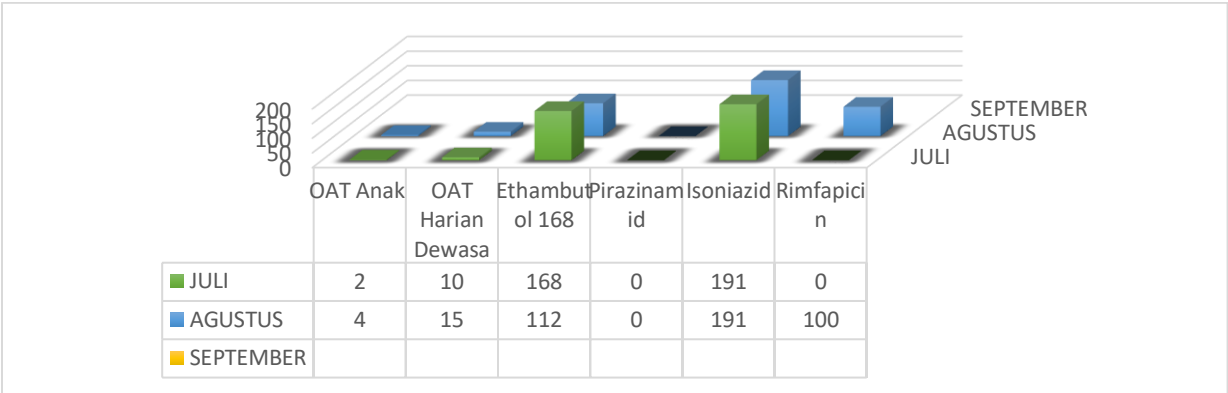
Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	OAT Anak	2	4	
2.	OAT Dewasa	10	15	
3.	Kombipak	0	112	
4.	TPT	0	0	
5.	Ethambutol	168	191	
6.	Pirazinamid	0	100	
7.	Isoniazid	191	4	
8.	Rimfapicin	0	15	

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



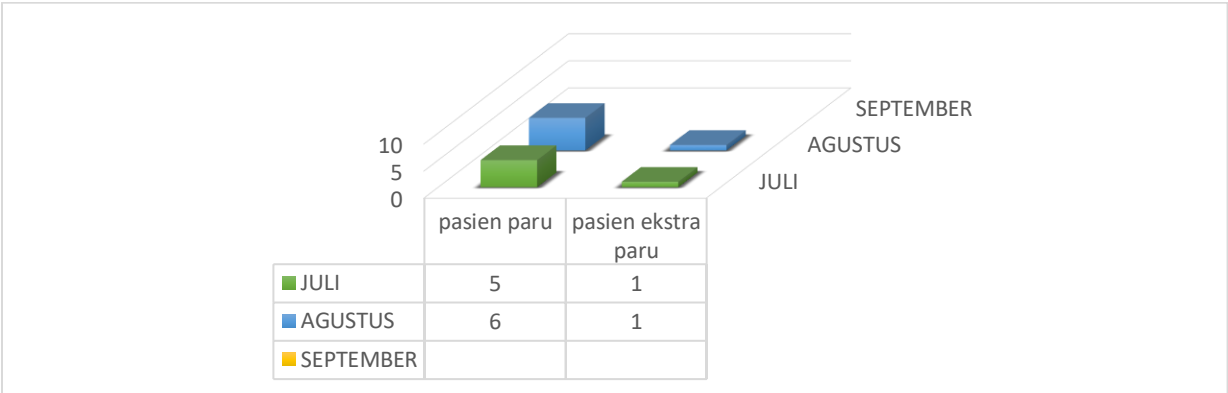
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien paru	5	6	
2.	Pasien Ekstra paru	1	1	

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

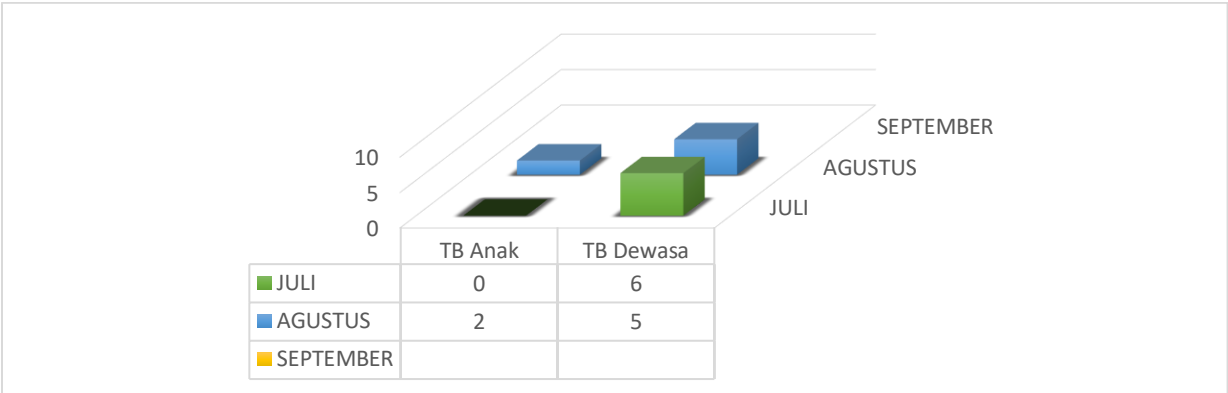
- 1. Pada bulan Juli 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
- 2. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien Anak	0	2	
2.	Pasien Dewasa	6	5	

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 6 pasien
- 2. Pada bulan Agustus terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P				
3.	Dr. Yunita, Sp. P	Tn. P	V		
		Ny. S	V		

Analisis :

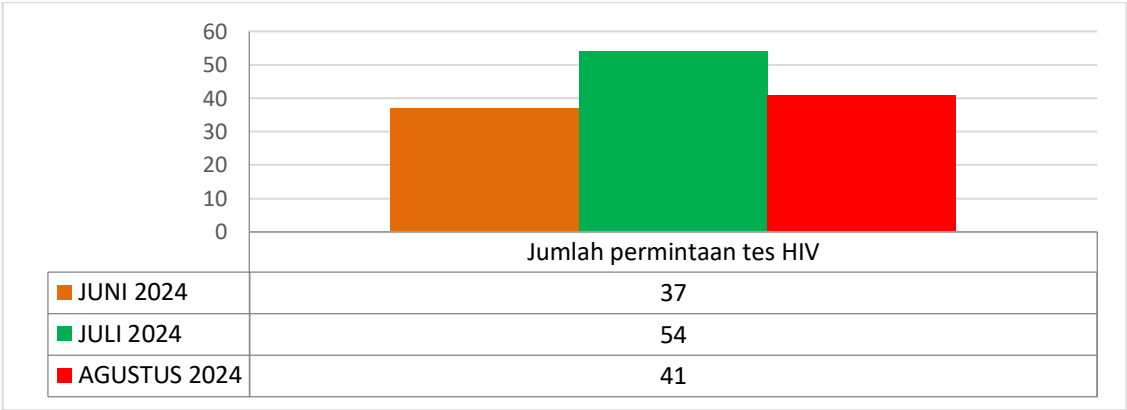
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Permintaan Test HIV	37	54	41

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



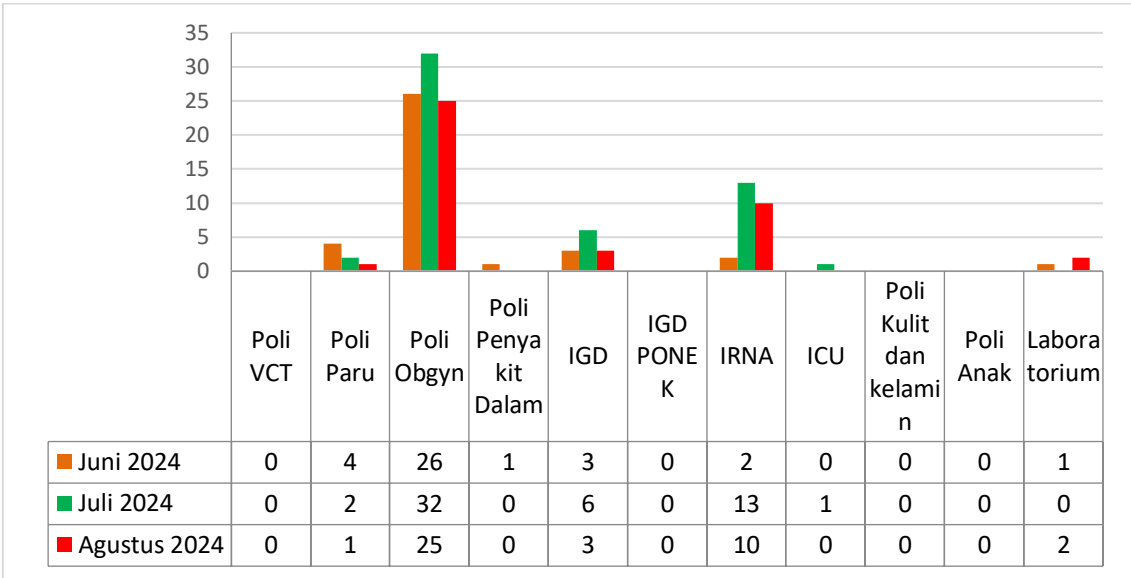
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Agustus sebanyak 41 pemeriksaan, pada bulan Juli 2024 sebanyak 54 pemeriksaan. Pemeriksaan naik dibandingkan dengan bulan Juni 2024 sebanyak 37 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	2	1
3	Poli Obgyn	26	32	25
4	Poli Penyakit Dalam	1	0	0
5	IGD	3	6	3
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	2	13	10
8	ICU	0	1	0
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	1	0	2

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Agustus 2024



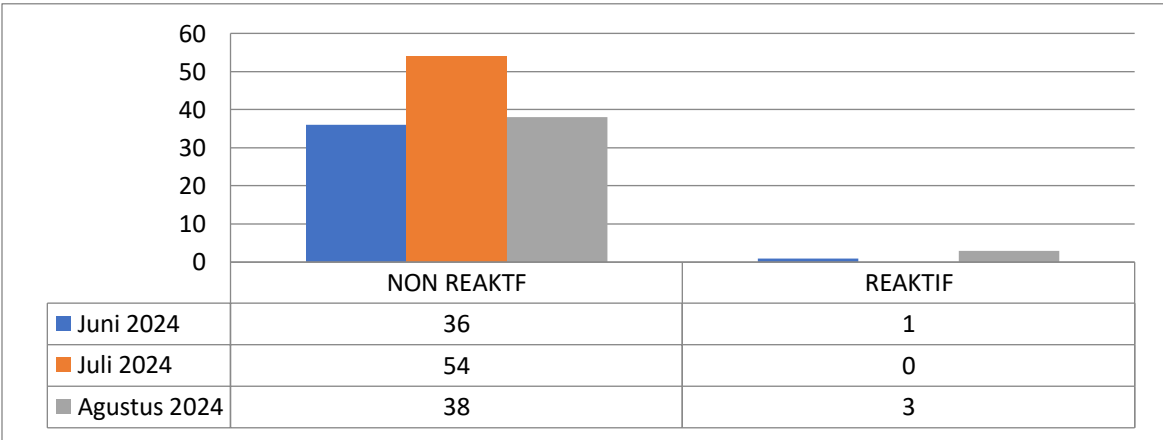
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan Juni 2024 sebanyak 26 pasien. pada bulan juli sebanyak 54 pasien. Sedangkan pada bulan agustus 2024 sebanyak 25 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Non Reaktif	36	54	38
2	Reaktif	1	0	3

Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan 3 pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan Agustus 2024. Yag didapatkan dari 1 pasien IRNA dan 2 pasien IGD.

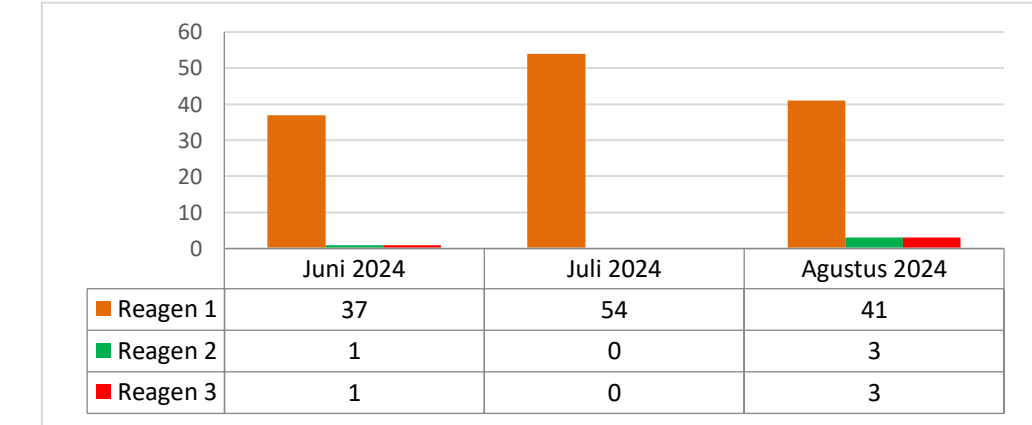
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah Sakit Prima Husada Malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Reagen 1	37	54	41
2	Reagen 2	1	0	3
3	Reagen 3	1	0	3

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada bulan Juni memakai sampai dengan reagen 3. pada bulan Juli 2024 memakai reagen 1 saja. Hal ini dikarenakan pada bulan juni 2024 ditemukan pasien dengan hasil HIV Reaktif sebanyak 1 paisen. Sedangkan pada bulan Juli 2024 tidak ditemulan pasien dengan HIV Reaktif. Pada bulan agustus 2024 pemakaian reagen sampai dengan reagen 3 dikarenakan pada bulan agustus 2024 ditemukan pasien dengan HIV reaktif sebanyak 3 pasien.

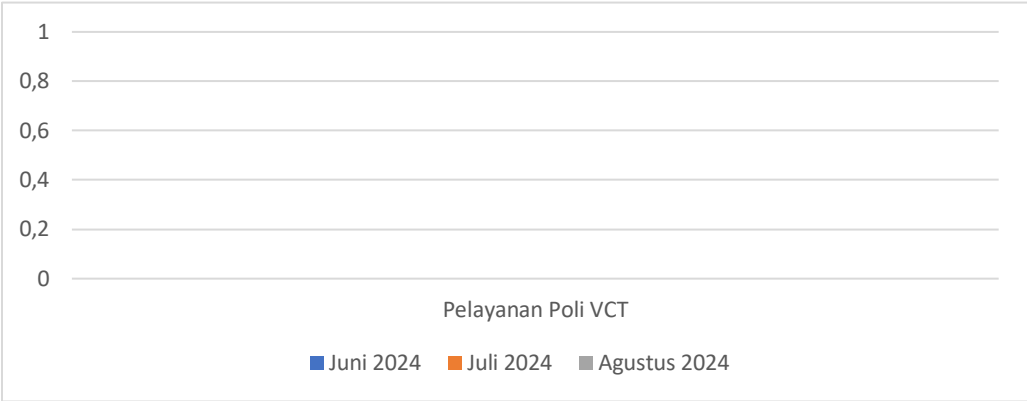
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3. Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Agustus 2024



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

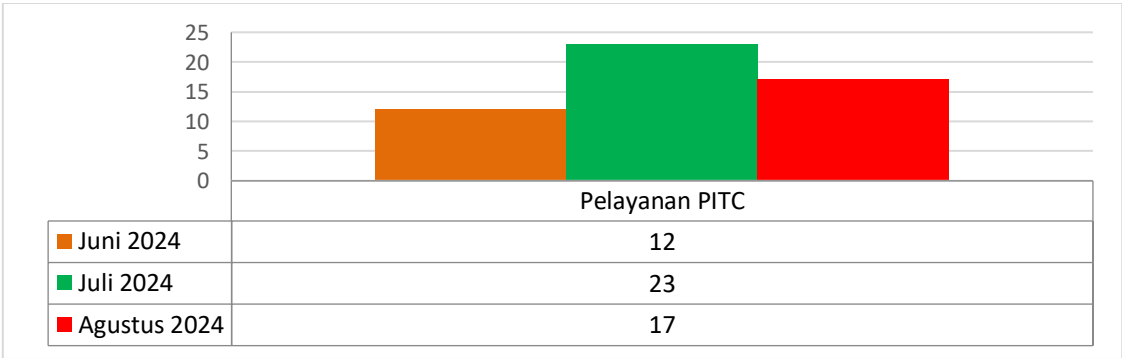
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Pelayanan PITC	12	23	17

Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan Juni 2024 sebanyak 12 pasien. pada bulan juli 2024 sebanyak 23 pasien. Sedangkan pada bulan agustus 2024 sebanyak 17 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

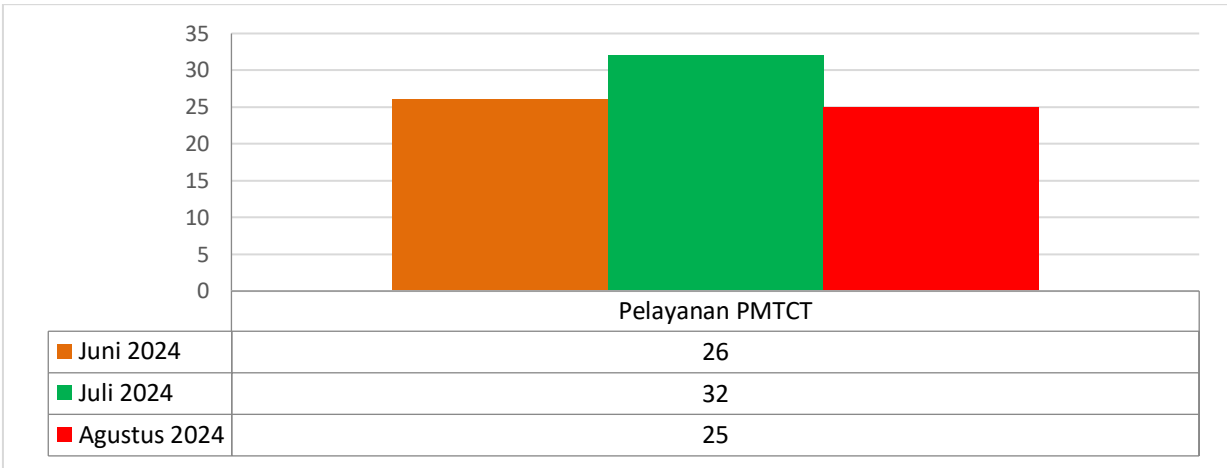
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Pelayanan PMTCT	26	32	25

Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan juni 2024 sebanyak 26 pasien. pada bulan Juli 2024 sebanyak 32 pasien. Sedangkan pada bulan agustus 2024 sebanyak 17 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

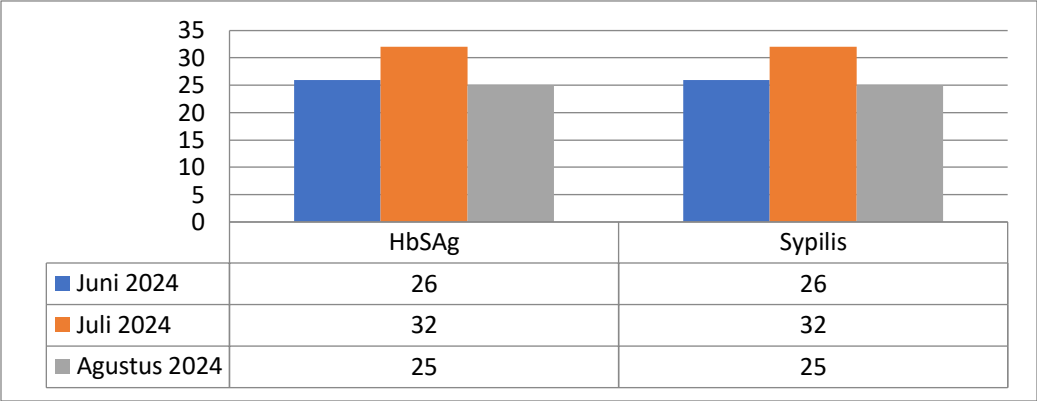
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bisa dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	HbSAg	26	32	25
2	Sypilis	26	32	25

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Syphilis pada bulan juni 2024 sebanyak 26 pasien, pada bulan Juli 2024 sebanyak 32 pasien sedangkan pada bulan agustus 2024 sebanyak 25 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Syphilis bisa dilakukan.

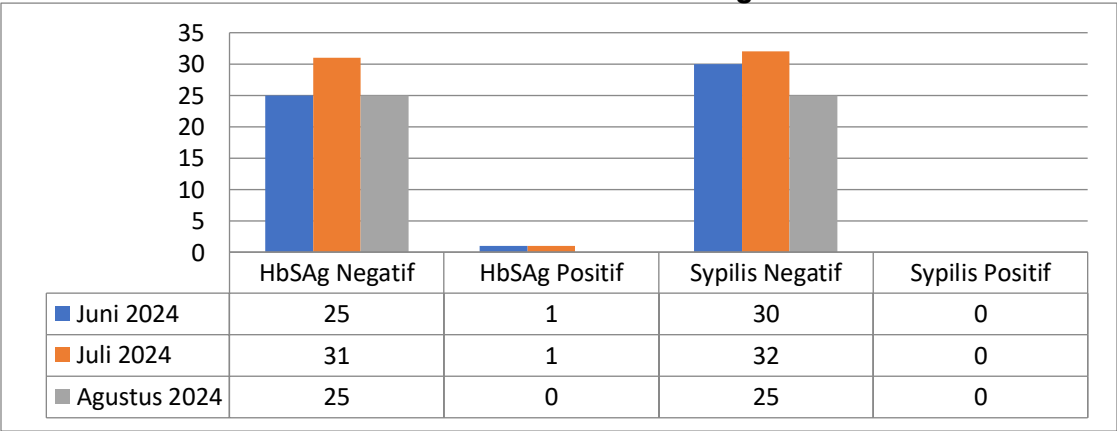
Rencana Tindak lanjut :

Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	HbSAg			
	Negatif	25	31	25
	Positif	1	1	0
2	Sypilis			
	Negatif	30	32	25
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Juni 2024 didapatkan 1 pasien dengan HbSAg positif. pada bulan Juli 2024 ditemuka 1 pasien dengan HbSAg Positif. Sedangkan pada bulan Agustus 2024 tidak ditemukan pasien HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

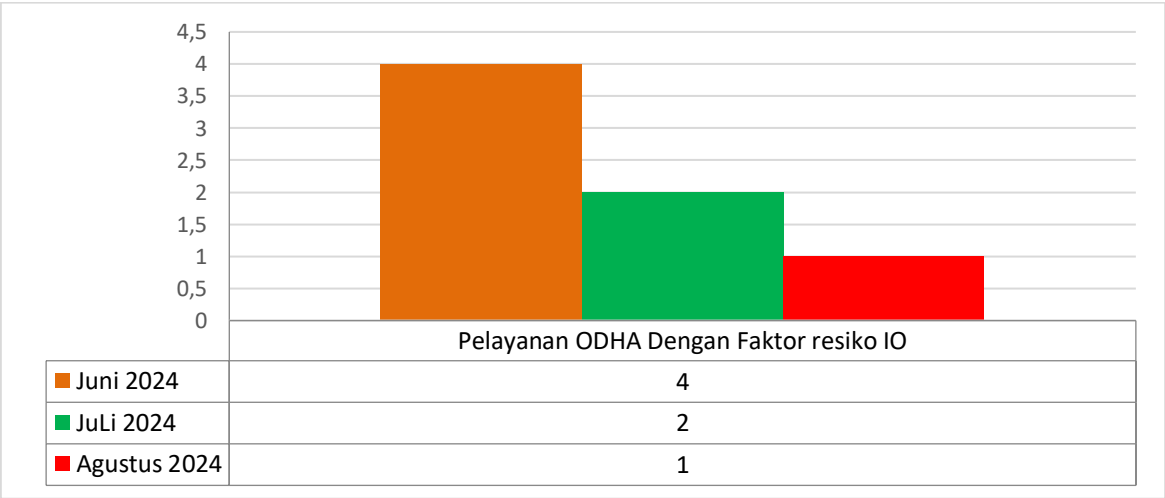
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran akan ada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Syphilis
- Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	2	1

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan juni 2024 sebanyak 4 pasien. pada bulan juli di dapatkan 2 pasien. sedangkan pada bulan agustus 2024 didapatkan 1 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

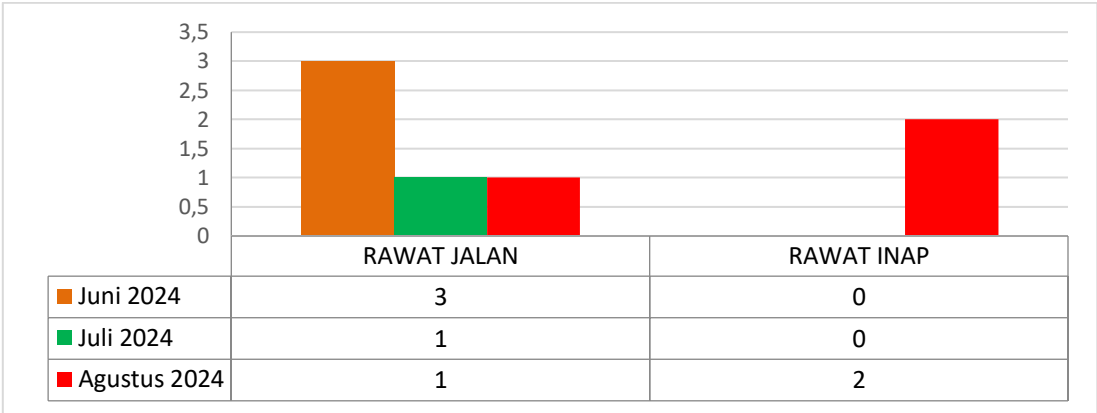
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
1	Rawat Jalan	3	1	1
2	Rawat Inap	0	0	2

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan Pada bulan juni terdapat 3 pasien HIV yang dilakukan rujuk yang berasal dari rawat jalan. pada bulan juli didapatkan data pasien yang dilakukan rujuk yaitu 1 pasien dari poli rawat jalan (poli kandungan) dengan pasien membawa hasil pemeriksaan sendiri dari PKM domisili pasien. Sedangkan pada bulan agustus terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk yaitu 2 dari rawat inap dan 1 dari poli IPD. Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Agustus 2024

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan

	eksklusif	2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Pada Bulan Juni tidak terdapat Kerjasama dengan komunitas eksternal
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
- Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
 Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	2	0
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

	pemberian vitamin A					
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	0	2	0
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

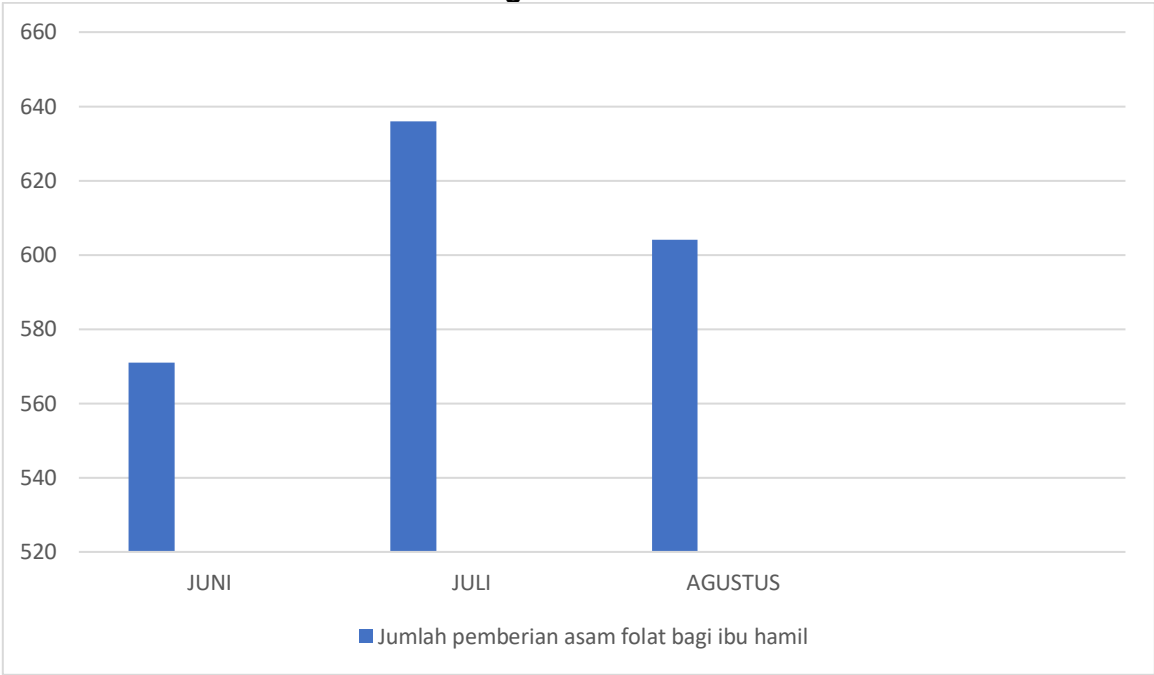
Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	571	636	604

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun pada bulan Agustus yaitu 604 ibu hamil yang mendapat tablet besi folat.

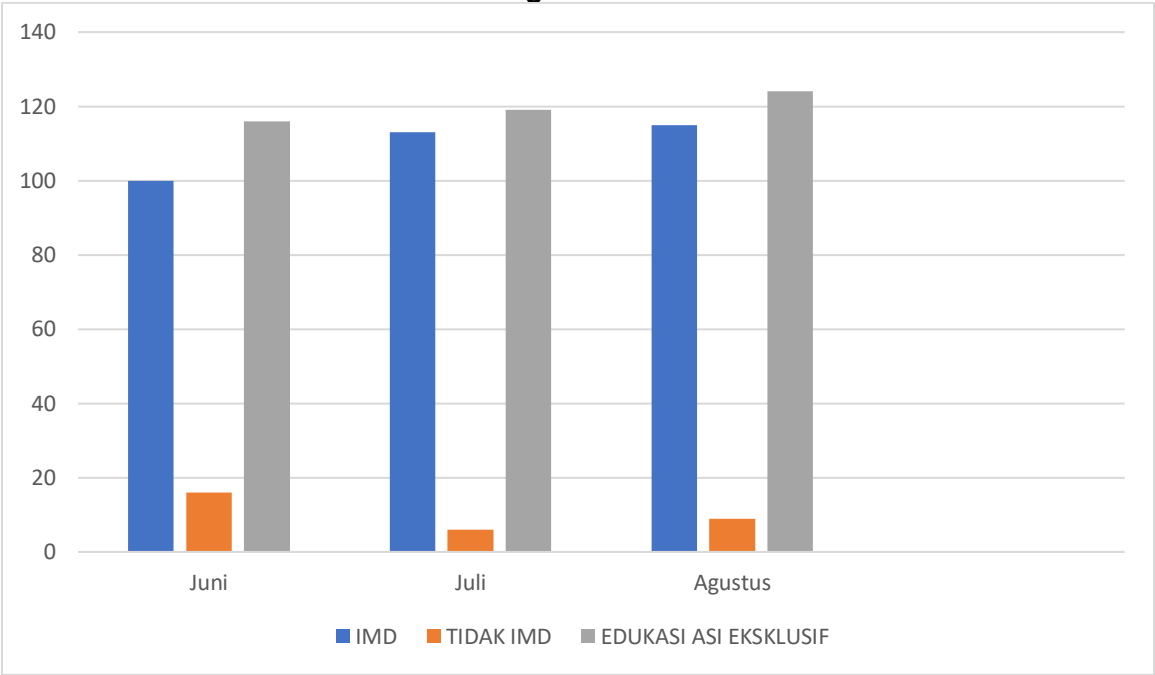
- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	IMD	100	113	115
2	Tidak IMD	16	6	9
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	116	119	124

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 115 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Agustus 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Agustus 2024 yaitu sebanyak 124 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

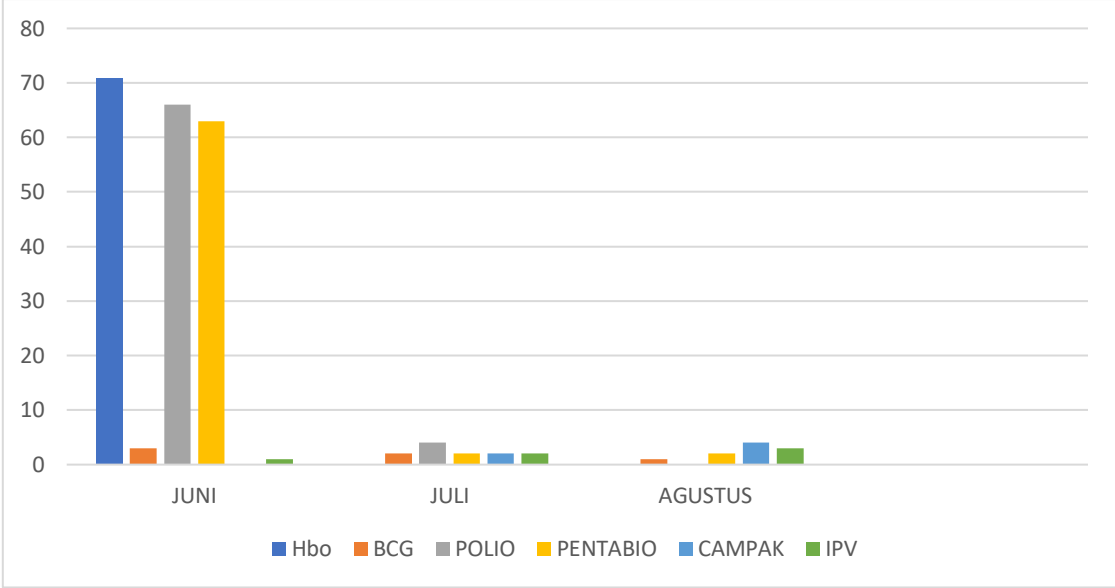
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	HbO	71	0	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	3	2	1
3	Polio	66	4	0
4	Pentabio	63	2	1
5	Campak	0	2	4
6	IPV	1	2	3

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis:

- 1. Tidak ada Imunisasi Hbo pada bulan Agustus dikarenakan ketidakterseidanya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 2. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Agustus sedikit meningkat pada bulan Juli yaitu 3 bayi.
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Agustus 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
- 4. Pada periode Agustus 2024 terdapat bayi yang melakukan Imunisasi Campak yaitu 4 bayi.
- 5. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Agustus 2024

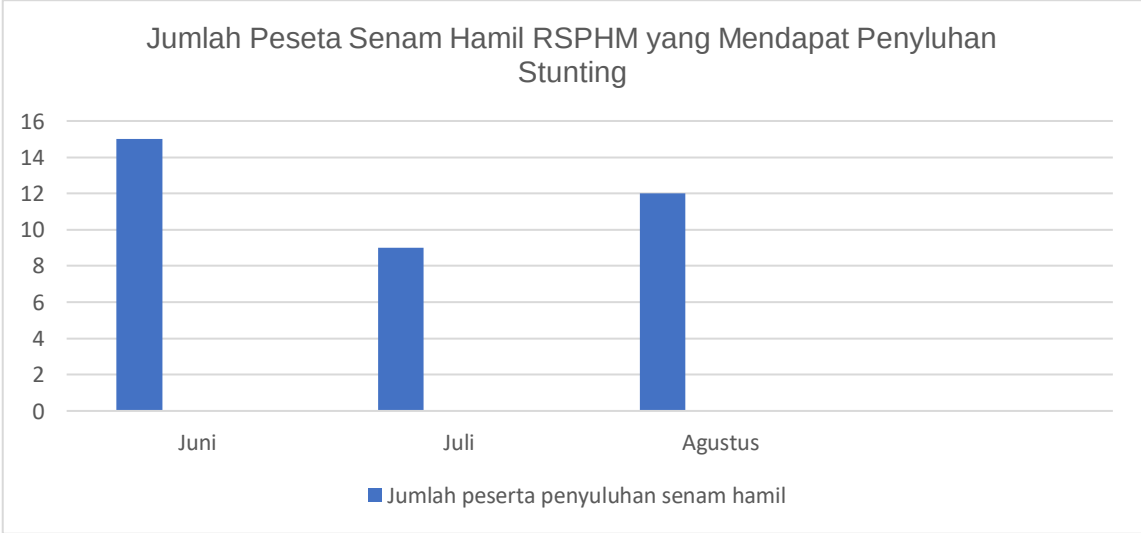
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	15	9	12
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Agustus 2024



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Jumlah peserta edukasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebanyak 12 orang

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-



Analisis :

Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:

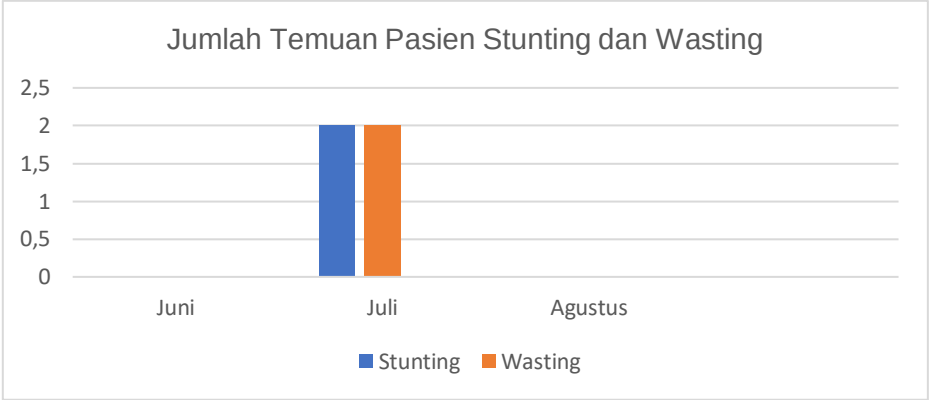
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JUNI 2024	JULI 2024	AGT 2024
Jumlah Pasien Stunting	0	2	0
Jumlah Pasien Wasting	0	2	0

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Terdapat 2 pasien stunting dan wasting pada bulan Juli. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan.

Rencana Tindak Lanjut :

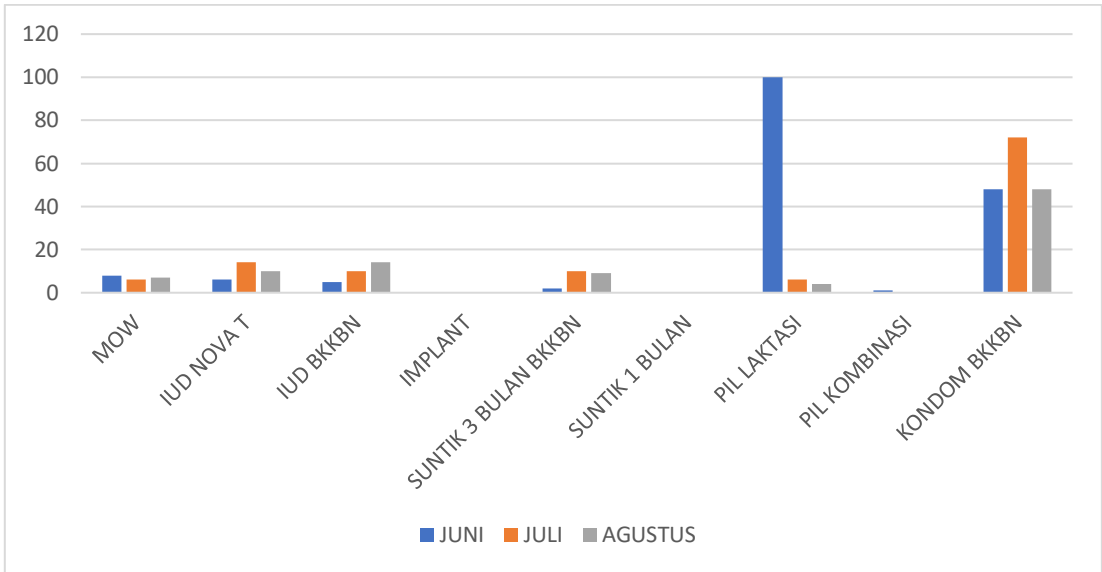
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

3.1.2.5 KBRS

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	MOW	8	6	7
2	IUD Nova T	6	14	10
3	IUD BKKBN	5	10	14
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	2	10	9
6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL KOMBINASI	1	0	0
8	PIL LAKTASI	0	6	4
9	KONDOM BKKBN	48	72	48

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Juni (8) Juli (6) Agustus naik (7)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Juni (6) meningkat Juli (14) Agustus (10)
- 3. Peserta IUD BKKBN, pada bulan Juni (5) Juli (10) meningkat agustus (14)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan Juni (2) Juli (10) Agustus (9)
- 5. Peserta KB pil kombinasi pada Juni (1) karena stok kosong Gudang bkkbn Juli (0) Agustus (0) ,Pil KB laktasi Juli (6) Agustus (4)
- 6. Peserta KB Kondom pada bulan Juni (48) meningkat Juli (72) Agustus (48)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

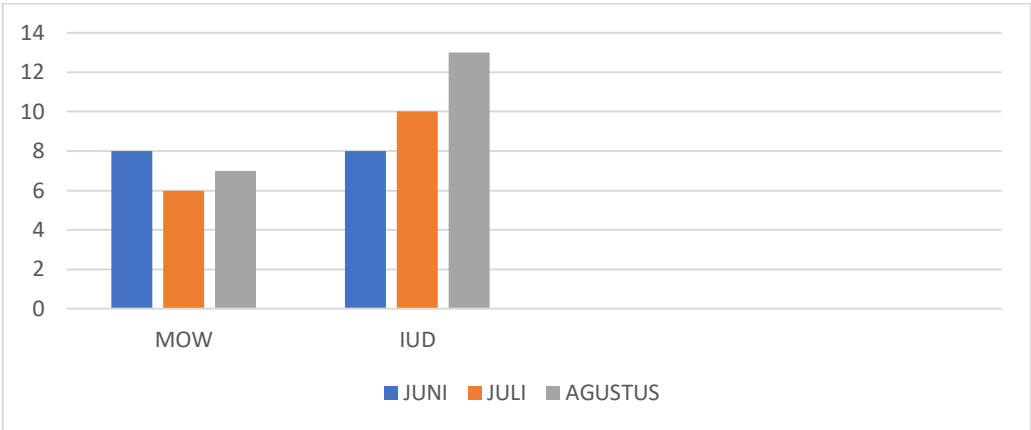
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

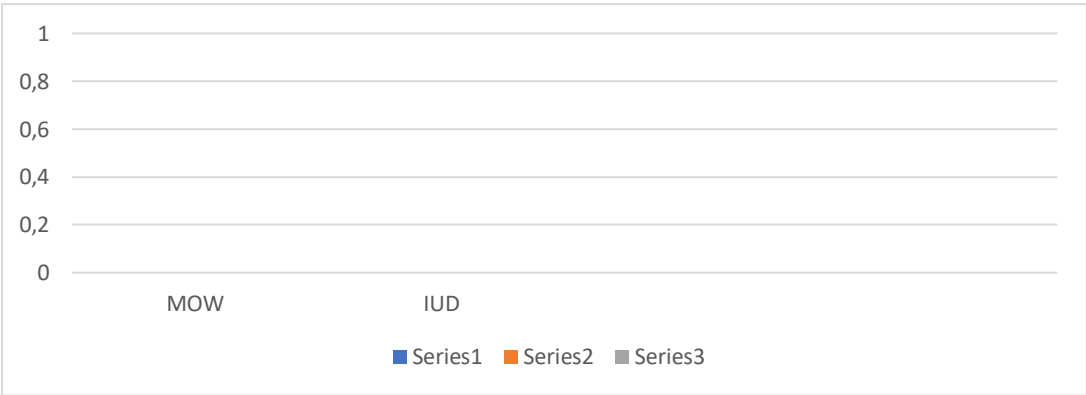
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	MOW	8	6	7
2	IUD	8	10	13

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JUNI 2024	BULAN JULI 2024	BULAN AGT 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Juni-Juli-Agustus meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Mei-Juni-Juli menetap

Analisis

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2024

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	M Furqon B	L/36	dr. Nimim, Sp.THT	214625	Abses Mandibula	29/05/2024	01/06/2024	4	Clindamycin po	3	3x0,3	2,7	1,8	1,5
									Ceftriaxone		2x1	8	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	4,5	2	2,25
2	Jumiati	P/54	dr. Ardhi, Sp.PD	164052	Volume Depletion	29/05/2024	01/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
3	Abdi Suroyo	L/43	dr. Ardhi, Sp.PD	203535	Febris / Fever	02/06/2024	05/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
4	Ni'ah	P/74	dr. Yoga, Sp.JP	214835	Chest Pain	02/06/2024	06/06/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin po		3x0,5	3	0,5	6
5	Hasanuddin	L/55	dr. Ardhi, Sp.PD	214904	Volume Depletion	03/06/2024	06/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
6	Rubakyah	P/42	dr. Heri, Sp.PD	078562	Vomiting	05/06/2024	10/06/2024	6	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pipemidat		2x0,4	3,2	0,8	4
7	Rochmayati	P/47	dr. Sigit, Sp.BP	215130	Post Repair Soft Tissue	07/06/2024	12/06/2024	6	Ceftiaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	10	2	5
8	Dyah Ramadhanty	P/23	dr. Zaki, Sp.B	215147	Colic Abdomen	08/06/2024	11/06/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
9	Sumartono	L/38	dr. Andy, Sp. P	215239	Athsma	09/06/2024	12/06/2024	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
10	Liman Harsono	L/70	dr. Edi, Sp. U	214658	Calculus of Ureter	10/06/2024	12/06/2024	3	Cefizoxime	1	1x2	2	4	0,5
11	Ni'matus S	P/27	dr. Aida, Sp.OG	104116	SC	13/06/2024	16/06/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

12	Rubinem	P/62	dr. Zaki, Sp.B	203990	Tumor Paru	14/06/2024	16/06/2024	3	Cefoperazone sodium	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftiaxone		2x1	4	2	2
13	Endang Wahyuni	P/29	dr. Andy, Sp.P	215638	Febris / Fever	18/06/2024	20/06/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	4	2	2
									Azitromycin po		2x0,5	2	0,3	6,67
14	Suwandi	L/53	dr. Farid, Sp.N	210236	Dyspnea	20/06/2024	24/06/2024	5	Meropenem	2	3x1	15	3	5
									Levofloxacin inf		1x0,75	3,75	0,5	7,5
15	Ida Marlinawati	P/49	dr. Heri, Sp. B	100853	Shock hipovolemik, anemia	20/06/2024	24/06/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
16	Sujiono	L/59	dr. Zaki, Sp.B	116131	Colic abdomen	23/06/2024	27/06/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Metronidazole inf		3x0,5	5	1,5	3,3
17	Rochmatul J	P/24	dr. Humaira, Sp.OG	215870	SC	24/06/2024	26/06/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
18	Firmansyah	L/39	dr. Meyrna, Sp.THT	215875	Sinuses	24/06/2024	28/06/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Metronidazole inf		3x0,5	6	1,5	4
19	Ferlyna Vivi	P/31	dr. Humaira, Sp.OG	151815	Kista	26/06/2024	28/06/2024	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicilline tab		2x0,5	3	1,5	2
20	Paino	L/66	dr. Anton, Sp.B	215965	Necrotizing fasciitis pedis	26/06/2024	28/06/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	4,5	2	3,5

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juli 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Ngatemin	L/76	dr. Heri, Sp.PD	080191	Syok Hipokalemi	25/06/2024	03/07/2024	9	Ceftiaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefixime		2x0,1	1,4	0,4	3.5
2	Dian Nuriana	P/37	dr. Anton, Sp.B	216048	Acute Appendicitis	27/06/2024	01/07/2024	5	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Ceftriaxone		3x1	9	2	4,5
									Metronidazole po		3x0,25	2,25	2	1,125
3	Asmat	L/46	dr. Andy, Sp.P	216224	Dyspnea	30/06/2024	04/07/2024	5	Ceftriaxone	3	2x1	6	2	3
									Azitromycin po		2x0,5	1	0,3	3,33
									Levofloxacin inf		1x0,5	1	0,5	2
4	Rihat Rico	L/29	dr. Zaki, Sp.B	216335	Ulcus Diabeticum	02/07/2024	05/07/2024	4	Cefoperazone sodium	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftiaxone		2x1	7	2	3,5
5	Roberto Bagio	L/21	dr. Yunita, Sp. P	169390	Obs Dyspneu dd Athsma dd COPD	03/07/2024	05/07/2024	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	2	0,75
6	Agus Wahyudi	L/36	dr. Ardhi, Sp.PD	083488	Gastroneocitis	08/07/2024	12/07/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4
									Ciprofloxacin po		2x0,5	5	1	5
7	Ernawati	P/44	dr. Vika, Sp.K	192126	Anogenital	09/07/2024	11/07/2024	3	Dohixat	1	2x0,1	0,6	0,1	6
8	Iwan Darsoni	L/39	dr. Yunita, Sp. P	208370	Dyspnea	09/07/2024	13/07/2024	5	Levofloxacin inf	1	1x0,75	3,75	0,5	7,5
9	Meirul Wahyu	L/21	dr. Kuntadi, Sp.OT	216664	Fingertrip Injury	10/07/2024	12/07/2024	3	Ceftiaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Kasiadi	L/48	dr. Yoga, Sp.JP	216773	DM Type 2	12/07/2024	18/07/2024	7	Ceftiaxone	2	2x1	14	2	7
									Levofloxacin po		1x0,5	1,5	0,5	3
11	Ngatemi	P/63	dr. Ardhi, Sp.PD	198384	DM Type 2	15/07/2024	18/07/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	8	2	4

									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
12	Suwarni	P/64	dr. Heri, Sp.PD	216944	DM Type 2	15/07/2024	20/07/2024	6	Ceftriaxone	3	2x1	9	2	4,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
									Asam pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2
13	Ngatemin	L/77	dr. Heri, Sp.PD	080191	Abdomal Pain	16/07/2024	18/07/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	5	2	2,5
									Sulfasalazine		2x0,5	2,5	2	1,25
14	Ren Wijayanti	P/46	dr. Anton, Sp.B	216962	Necrotizing Faciitis	16/07/2024	18/07/2024	4	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
15	Ibrahim Muhammad	L/63	dr. Heri, Sp.PD	184234	DF	18/07/2024	21/07/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	3	2	1,5
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
16	Suyono	L/59	dr. Ardhi, Sp.PD	130971	Colic Abdomen	22/07/2024	25/06/2024	4	Ceftiaxone	2	2x1	6	2	3
									Asam Pipemidat		2x0,4	2	0,8	2,5
17	Suli'ati	P/43	dr. Humaira, Sp.OG	130746	Cervix uteri	24/07/2024	25/07/2024	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin po		3x0,5	1,5	1,5	1
18	Munirotul K	P/43	dr. Andi, Sp. B	217219	TU Mamae (S)	24/07/2024	26/07/2024	3	Cefoperazone sodium	1	1x2	2	4	0,5
19	Ngatminah	P/45	dr. Anton, Sp.B	217296	Soft Tissue of Thorax	24/07/2024	26/07/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	0,75
20	Rizki Wulandari S	P/28	dr. Aida, Sp.OG	171126	SC	24/07/2024	26/07/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1

3.2.2.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Agustus 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Siti Rubaiyah	P/47	dr. Heri, Sp.PD	174600	Volume Depletion	29/07/2024	02/08/2024	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
2	Alfiyah	P/64	dr. Heri, Sp.PD	068249	DM Type 2	30/07/2024	05/08/2024	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
3	Etik Supriatin	P/64	dr. Anton, Sp.B	217659	Necrotizing	31/07/2024	02/08/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
4	Siti Lutfiyah	P/48	dr. Zaki, Sp.B	060461	Post of Debridement	02/08/2024	04/08/2024	3	Ceftriaxone	2	2x1	3	2	1,5
									Metronidazole inf		3x0,5	1,5	1,5	1
5	Syafira Widya	P/19	dr. Anton, Sp.B	217481	Ganglion Elbow (D)	02/08/2024	04/08/2024	3	Ceftizoxime	3	1x2	2	4	0,5
									Ceftizoxime		1x1	1	4	0,25
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	0,2
6	Sudjilah	P/75	dr. Miryanti, Sp.JP	185511	Chest Pain	03/08/2024	04/08/2024	2	Meropenem	1	2x1	3	3	1
7	Nining Nur Wahyu	P/33	dr. Aida, Sp.OG	122283	SC	03/08/2024	05/08/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
8	Siti Qomariah	P/22	dr. Zora, Sp. PD	124748	GEA + Volume Depletion	03/08/2024	05/08/2024	3	Ciprofloxacin inf	1	2x0,2	1	0,8	1,25
9	Masudah	P/47	dr. Zora, Sp.PD	174600	Unspecified renal colic	06/08/2024	09/08/2024	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	2,8	0,8	3,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
10	Siaman	L/59	dr. Arianto, Sp.OT	136807	Injury to the foot due to infection	08/08/2024	10/08/2024	3	Ceftraixone	2	1x1	4	2	2
									Metronidazole inf		1x0,5	1,5	1,5	1
11	Azizah Aprila	P/22	dr. Anton, Sp.B	210157	Nectrotizing Facitis Pedis	11/08/2024	13/08/2024	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftiaxone		2x1	5	2	2,5
12	Yunita Indrayana	P/37	dr. Aida, Sp.OG	218352	PEB	13/08/2024	14/08/2024	2	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Metronidazole inf		1x0,5	1	1,5	0,67

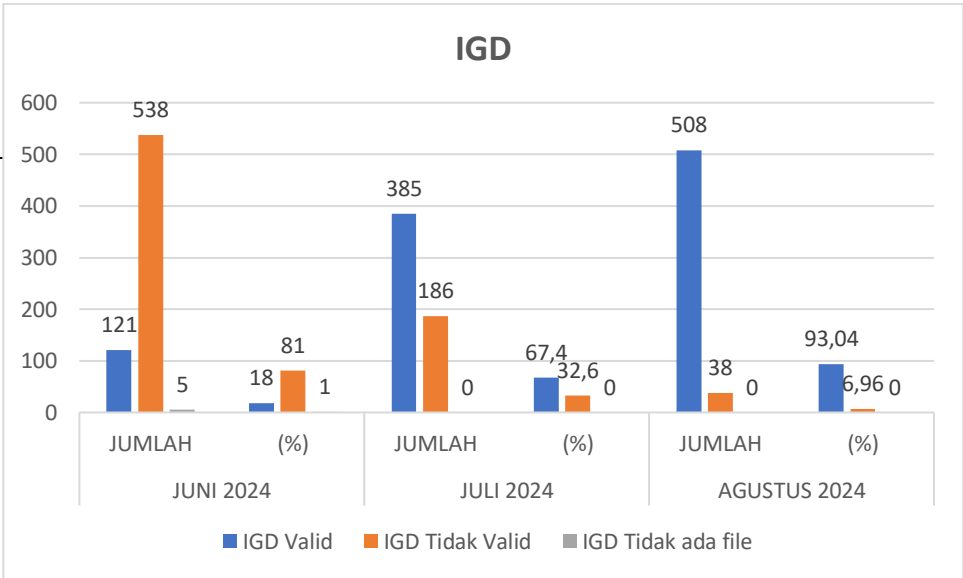
13	Wiwit Triani	P/52	dr. Anton, Sp.B	217659	Limpadenopathy Inguinal	16/08/2024	18/08/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,75	2	0,875
14	Syaiful Yuniasih	L/38	dr. Andy, Sp.P	218504	Dyspnea	17/08/2024	19/08/2024	3	Ceftiaxone	2	2x1	5	2	3,5
									Levofloxacin inf		1x0,75	2,25	0,5	4,5
15	Samiat	P/65	dr. Yoga, Sp.JP	218531	DOC, Syok Cardiogenic	18/08/2024	21/08/2024	4	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	2	0,5	4
16	Musdalifah	P/53	dr. Arianto, Sp.PD	148673	Ganglion	19/08/2024	21/08/2024	3	Cepoferazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cepoferazone		2x1	2	4	0,5
17	Nisa Tri Y	P/35	dr. Humaira, Sp.OG	097429	SC	21/08/2024	23/08/2024	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
18	Boby Juli	L/26	dr. Zaki, Sp.B	218719	Appendicitis	21/08/2024	25/08/2024	5	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	12	3
19	Sunarmi	P/63	dr. Miryanti, Sp.JP	109487	CHF	21/08/2024	26/08/2024	6	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Levofloxacin inf		1x0,75	3,75	0,5	7,5
20	Bunga Perdana P	P/36	dr. Humaira, Sp.OG	209242	Oligohydramnios	29/08/2024	30/08/2024	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Amoxicillin		2x0,5	1	1,5	0,67

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

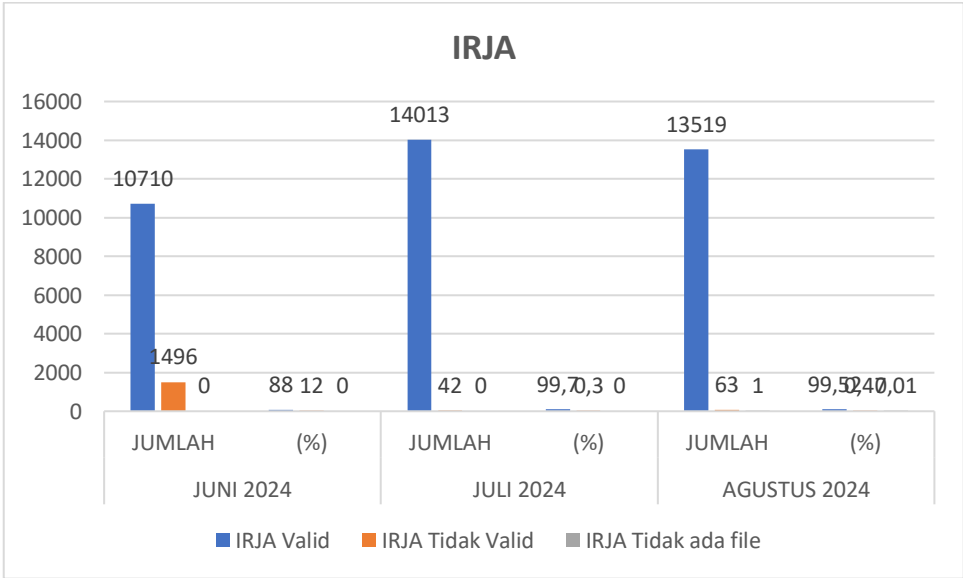
3.6.6.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Juni - Agustus 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			JUNI 2024		JULI 2024		AGUSTUS 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1.	IGD	Valid	121	18	385	67,4	508	93,04
		Tidak Valid	538	81	186	32,6	38	6,96
		Tidak ada file	5	1	0	0	0	0
Total			664		571		546	
2.	IRJA/POLI	Valid	10710	88	14013	99,7	13519	99,52
		Tidak Valid	1496	12	42	0,3	63	0,47
		Tidak ada file	0	0	0	0	1	0,01
Total			12206		14055		13583	

3.6.6.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Juni - Agustus 2024



3.6.6.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Juni - Agustus 2024



Analisis :

- 1. Terjadi kenaikan signifikan pada data valid di IGD sebanyak 508 Data E-RM dari 546 Data E-RM atau sebesar 93.04%, hal ini disebabkan adanya perubahan alur penyetoran data kunjungan pasien per hari ke Instalasi Rekam Medis oleh Karu IGD.
- 2. Masih ditemukan 6.96% Data E-RM tidak valid di IGD, hal ini disebabkan masih

- ditemui form yang belum sinkron antara form IGD dan rekam medis, setelah ditelusur sudah pengkajian awal IGD sudah diisi lengkap tetapi tidak terbaca, system bermasalah.
3. Terjadi peningkatan tidak signifikan data tidak valid di IRJA, tetapi tidak lebih dari 1%. Ditemukan 1 berkas yang tidak ada file, hal ini disebabkan inputan perawat tidak muncul di RM sehingga tidak bisa dilakukan validasi.

Masalah :

1. Pengkajian awal medis gigi tidak bisa terbuka oleh rekam medis, sedangkan fitur tersebut muncul di SIMRS perawat.
2. Permasalahan di IGD tidak bisa diperbaiki langsung karena tidak bisa batal kunjungan, pembatalan harus melalui PT.
3. Berikut link permasalahan yang ditemui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

Rencana Tindak Lanjut :

- Ketidakiengkapan ERM sudah membaik dari pada bulan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan alur terkait penyetoran berkas pasien per hari, yaitu :
1. Alur sebelumnya perawat menyetor berkas casemix ke kasir jaminan, mulai awal Bulan Juni 2024 perawat menyetor berkas ke rekam medis untuk dilakukan cek kelengkapan ERM oleh tim rekam medis.
 2. Petugas rekam medis menandatangani lembar casemix sebagaibukti bahwa sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap dan valid.
 3. Setelah selesai dilakuan validasi oleh petugas rekam medis, perawat meyetorkan berkas ke kasir jaminan.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Barang FS belum sesuai dengan biling	P	Menganalisa barang yang tidak sesuai dengan FS
		D	Koordinasi dengan pihak farmasi dan programmer
		S	Beberapa Fs biling tidak sesuai dengan biling
		A	Folloup berkala sehingga FS sesuai dengan biling
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
2	Vinyl dan lampu IKO perlu diganti	P	Mengganti lampu IKO
		D	Follow up Pengadaan barang yang belum datang Penjadwalan penggantian vinyl dan lampu
		S	Vinyl belum menemukan vendor yang sesuai
		A	Follow up berkala

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Masih ada masalah di ERM yang tidak sesuai dengan rekam medis	P	Melakukan telusur penyebab ketidakseamaan antara ERM IGD dan ERM yang muncul di unit RM
		D	Koordinasi dengan programmer
		S	ERM dari IGD sudah diisi dengan lengkap namun tidak muncul di RM artinya terdapat kesalahan sistem

		A	Meminta programmer untuk memperbaiki system
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Dokter IGD kurang lengkap dalam pengisian ERM yang ada di IGD	P	Melakukan telusur alasan dokter IGD kurang lengkap dalam pengisian ERM yang ada di IGD
		D	Kordinasi dengan kabid pelayanan untuk perbaikan pengisian ERM untuk dokter IGD
		S	Beberapa rekam medis yang tidak lengkap di data dan di laporkan ke dr IGD secara langsung
		A	Melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap dr IGD untuk pengisian rekam medis

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Daftar tilik obat DPO tidak lengkap	P	Menyiapakn DPO saat ada OB
		D	Selalu mengecek dalam penulisan dpo
		S	Terdapat banyak kasus,daftar tilik obat DPO tidak terisi dengan lengkap
		A	Keapla ruangan supervisi berkala pengecekan DPO
2	Hasil pembacaan USG oleh 1 DPJP radiologi yang meragukan sehingga LOS memanjang karena DPJP	P	Mencari Solusi terkait keraguan hasil bacaan USG DPJP radiologi ini
		D	Koordinasi dengan DPJP dan ketua Komite Medik
		S	1 DPJP radiologi tersebut menyatakan bahwa hasil bacaannya sudah benar
		A	Mengadakan forum komunikasi

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	PRB belum mencapai target	P	Merencanakan bertemu dengan dpjp untuk sosialisasi PRB yang belum tercapai
		D	Menyiapkan spo untuk PRB
		S	Banyak kasus prb belum tercapai
		A	Komunikasi dengan setiap DPJP terkait PRB
2	Kasir tidak bisa mengetahui notif pasien yang sudah pelunasan penunjang jika ada tambahan lab maupun rontgen	P	Berkoordinasi dengan kasir dan asisten untuk pembayaran
		D	Mem fix kan dulu agar pasien tidak berkali-kali untuk pembayaran ke kasir
		S	Adanya kasus soal ada pasien yang tidak ada notif untuk pembayaran lab
		A	Saling mengingatkan antara asisten dan kasir

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 72.74% dan waktu tunggu obat racikan 53.22%	P	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuatkan fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Follow up ke Programmer.

			2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang.
2.	Penulisan kartu stok tidak lengkap, baik di Depo Farmasi maupun di Depo IKO.	P	Memperbaiki supervise petugas farmasi.
		D	Menentukan PJ supervise setiap unit, yaitu Asharul Fahrizi (PJ Rawat Inap), Diryati Barin (PJ Rawat Jalan), Fadilah Maulana (PJ Depo IKO).
		S	1. Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok. 2. Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
		A	Semua staff farmasi sudah mendapatkan teguran lisan dan membuat surat pernyataan komitmen penulisan kartu stok.
3.	Kesalahan pemberian obat berulang.	P	Memperbaiki supervise petugas farmasi.
		D	Melakukan supervise dan teguran kepada petugas, memperbaiki alur.
		S	Double checking oleh petugas konseling tidak berjalan.
		A	1. Melakukan konseling kepada petugas yang bersangkutan dan memberikan teguran SP-1. 2. Membuat kebijakan, petugas konseling hanya dilakukan oleh Apoteker dengan memperhatikan ISEP, double checking antara obat dan etiket, dan identifikasi pasien dengan benar.
4.	Retur penjualan obat yang tidak diambil pasien, di retur ke Gudang farmasi di fitur penerimaan hibah lainnya namun resep kronis tidak di hapus di apotek online, dan tidak dihapus di Penjualan Farmasi	P	Memperbaiki alur retur penjualan obat yang tidak diambil pasien.
		D	Koordinasi dengan Kabid, Keuangan, Verifikator dan Managemen PT DPM kesepakatan alur retur penjualan obat yang tidak diambil pasien.
		S	1. Selama ini di input penerimaan farmasi lain namun hanya menambah stok Gudang retur tapi tidak menghapus data penjualan. Sehingga ketika retur diganti obat selesai maka data tidak akan muncul di tim verif (Berkas obat kronis). 2. Tidak ada laporan tarikan data pasien khusus BPJS kesehatan karena berkaitan dengan data pasien yang akan di hapus datanya di apotek online. 3. Obat belum direturn ke apotek online beserta racikannya. Hasil keputusan PT racikan di anggap kerugian maka racikan tetap di retur tapi dihapus dari penjualan.

		A	Hasil kesepakatan antara Manajemen RS, Keuangan, Verifikator dan Manajemen PT DPM, sbb : 1. Pengambilan obat maksimal 3x24 jam. 2. Jika obat tidak diambil dalam batas waktu yang dilakukan maka dilakukan retur dalam waktu seminggu. 3. Petugas melakukan reture penjualan dan menghapus resep di Apotek Online.
5.	Waktu tunggu pelayanan farmasi rawat jalan lama sehingga banyak complain pasien.	P	Mengurangi waktu tunggu di Farmasi. Mendisiplinkan DPJP dalam penginputan e-resep per pasien (tidak dilakukan rapel).
		D	Koordinasi dengan Kabid Pelayanan untuk mengedukasi DPJP.
		S	Jumlah pasien rawat jalan per kunjungan tidak ada batasan sehingga terjadi penumpukan pasein di Poli sampai menunggu di Farmasi.
		A	1. Pasien ditawarkan PRIMANTARA agar tidak menunggu obat lama. 2. Resep obat diinput per pasien oleh DPJP.
6.	Terjadi kekosongan obat amitriptilin, haloperidol 5 mg, spironolakton 100 mg, Asam Salicylad, ,Myllacid Susp 60ml.	P	Melakukan pengadaan menggunakan e-katalog.
		D	Pengajuan akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
		S	1. Kekosongan obat terjadi karena kosong distributor dan pabrik. 2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis. 3. Koordinasi dengan DPJP terkait substitusi obat.
		A	Menunggu approve dari Kemenkes.
7.	Ruangan LAF tidak sesuai standar.	P	Mengajukan ruang LAF sesuai dengan pedoman dasar dispensing sediaan steril.
		D	Melakukan list pengajuan perpindahan ruangan dan ditujukan ke PT.
		S	Pedoman dasar dispensing sediaan steril.
		A	Dalam proses mengajukan perpindahan ruangan.

3.7.6
Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikam

			dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Pengadaan BDRS belum berjalan.	P	Membuat target pelaksanaan BDRS di Labortaorium RSPH Malang.
		D	Follow up ke Pengadaan PT.
		S	BDRS belum berjalan dikarenakan masih menunggu penawaran vendor.
		A	Follow up berkala ke Pengadaan PT.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Ketidaksesuaian antara fitur e-rm poli dengan rekam medis.	P	Memperbaiki fitur e-rm poli dan rekam medis.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk meminimalisir data yang tidak valid akibat ketidaksesuaian fitur.
		S	Mencatat temuan permasalahan e-rm dan dilaporkan kepada Programmer.
		A	Melakukan koordinasi dengan Programmer setiap ditemuka masalah e-rm.

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1. Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2. Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid	P	Memperbaiki pencacatan menggunakan digital.

		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai di Bulan September 2024.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Penurunan jumlah pemeriksaan CT Scan karena alat rusak.	P	Mengajukan pembelian sparepart untuk perbaikan alat. Meningkatkan kunjungan radiologi setelah alat siap digunakan.
		D	Koordinasi dengan ATEM dan Humas&Marketing.
		S	Melakukan rujuk ke luar RS untuk pemeriksaan penunjang, pendapatan RS berkurang.
		A	Koordinasi dengan ATEM dan Humas&Marketing.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	S1 Apoteker	43	14	0	14	0
		S1 Farmasi		4	0	4	0
		S1 Analis Farmasi		1	0	1	0
		D3 Farmasi		16	4	12	0
		SMK		7	0	7	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	11	1	0	1	0
		D3 Rekam Medis		8	0	8	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		1	1	0	0
10	CSSD	D3 Keperawatan	5	2	1	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
		SMK		2	1	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	5	4	1	2	1
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	1
12	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	0	2	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	0	2	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0

		SMA		3	0	3	0
		SMP		2	2	0	0
13	Humas & Marketng	Profesi Ners	2	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
14	ICU dan HCU	Profesi Ners	11	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		7	0	7	0
15	IGD	Profesi Ners	26	11	1	10	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Kebidanan		3	0	3	0
		D3 Kebidanan		2	0	2	0
16	IKO	Profesi Ners	12	7	2	5	0
		D3 Keperawatan		4	1	3	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	S1 Teknik Elektro	6	1	0	1	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	0	1	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	0	3	0
19	IRJA	Profesi Ners	27	6	3	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		16	6	10	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
20	IRNA 2C	Profesi Ners	7	4	1	3	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		2	0	2	0
21	IRNA 3A & 4A	Profesi Ners	20	16	0		
		D3 Keperawatan		4	0	4	0
22	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	16	6	0	6	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		8	0	8	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
23	IRNA 5C	Profesi Ners	9	2	0	2	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Keperawatan		6	0	6	0
24	IRNA 6A & 7A	Profesi Ners	24	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		D3 Keperawatan		12	0	12	0
25	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	0	2	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
26	Neonatologi	Profesi Ners	8	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	1	4	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
27	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		2	1	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		3	3	0	0
		SMA		1	0	1	0

28	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	10	2	0	2	0
		D3 Analis Kesehatan		8	0	8	0
29	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
30	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	4	6	0
31	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Ilmu Sosial		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	0	1	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	2	4	0
		SMK		5	0	5	0
		SMA		1	1	0	0
32	PIPP & MPP	Profesi Ners	6	2	1	1	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
33	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
34	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
35	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
36	Sekteraris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
37	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	0	3	0
38	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	2	1	1	0	0
39	Cleaning Service	SMK	45	25	5	20	0
		SMA		15	0	15	0
		SMP		5	0	4	0
40	Security	SMK	12	7	4	3	0
		SMA		5	2	3	0
41	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	0	1	0
		SMA		2	0	2	0
		SMP		2	0	2	0
42	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
43	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
44	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
45	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
46	Dokter Spesilais Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0

51	Dokter Spesialis THT-KL	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Gigi Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Gigi Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Gigi Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Umum	Pendidikan Profesi Dokter	8	8	1	7	0
Total			471				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarananya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Agustus 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Agustus 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 September 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	INSTANSI	NAMA PKS	NOMOR RS	NOMOR INSTANSI	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017	12 Desember 2017	Berlaku
2	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
3	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku
4	PT Prudential Life Insurance	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		3143/PMN-PA/IV/2020	13 April 2020	Berlaku
5	PT AIA Financial	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	069/DPM/E-PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020	4 November 2020	Berlaku
6	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	150/ PKS-RSPRIMAHUSADA-MAT/DIR/XI/2016		28 November 2016	Berlaku
7	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015	19 September 2019	Berlaku
8	PT. Suprima Mitra Adihusada	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019	26 agustus 2019	Berlaku
9	PT. Equity Life IND-Corporate	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		091/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
10	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013	15 Agustus 2013	Berlaku
11	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012	9 Oktober 2012	Berlaku

	Sinarmas Msig	Kerjasama Pelayanan Kesehatan				
12	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	010/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019	9 April 2019	Berlaku
13	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015	16 Maret 2015	Berlaku
14	PT. Equity Life IND-Cassles	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		090/ELI/LGL/X/19	14 Oktober 2019	Berlaku
15	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013	24 Oktober 2013	Berlaku
16	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018	17 September 2018	Berlaku
17	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	082/RSPH/E-IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716	24 Juli 2019	Berlaku
18	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	025/RSPH/E-PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015	28 April 2018	Berlaku
19	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	070/DPM/E-PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019	10 Oktober 2019	Berlaku
20	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015	25 Februari 2015	Berlaku
21	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	508/RSPH/E-IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017	02 Januari 2017	Berlaku
22	PT. Asuransi Jiwa	Perjanjian	017/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020	2 Maret 2020	Berlaku

	Manulife Indonesia	Pelayanan Kesehatan Peserta Individu				
23	PT. AJ Central Asia Raya (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019	29 November 2019	Berlaku
24	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C	21 Agustus 2020	Berlaku
25	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019	30 Oktober 2019	Berlaku
26	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS.031/GHASKES/157-1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020	28 Agustus 2020	Berlaku
27	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	490/RSPH/I-IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016	7 September 2020	Berlaku
28	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	017/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-PHMS/VIII/2020	31 Agustus 2020	Berlaku
29	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	-	-	4 Januari 2014	Berlaku
30	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022	10 maret 2022	Berlaku
31	PT. Asuransi Jiwa BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan Kesehatan	149/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023	10 Oktober 2023	Berlaku
32	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang			11 September 2012	Berlaku
33	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	55/Perj/HMS/IX/2014	1 Juni 2014	Berlaku
34	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019	26 Agustus 2019	Berlaku

		Pemeriksaan Medicak Chek Up				
35	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan			1 April 2013	Berlaku
36	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85	5 Januari 2012	Berlaku
37	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019	9 Januari 2019	Berlaku
38	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)			1 Oktober 2014	Berlaku
39	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan			20 Maret 2015	Berlaku
40	Harris Hotel & Convensions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018	14 Oktober 2019	Berlaku
41	PT. Duha Mulya Abadi	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac			11 Januari 2019	Berlaku
42	RS Sahabat Pasuruan	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2021		2 Desember 2016	Berlaku
43	PT. Asuransi Dayin Mitra TBK		003/MKT/HLT/PKS/II/2015	PH/IKS/269/XII/2014	1 Mei 2015	Berlaku
44	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022	4 Juli 2022	Berlaku
45	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan			7 Februari 2023	Berlaku

		Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan				
46	Klinik Pratama Rawat Jalan Mawar Waskitha Husada	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024		23 Januari 2024	Berlaku
47	Klinik Losari Medika	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024		6 Februari 2024	Berlaku
48	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850	1 September 2022	Berlaku
49	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022	10 Oktober 2022	Berlaku
50	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023	26 Juni 2023	Berlaku
51	ASABRI	PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PERJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023	13 Desember 2023	Berlaku
52	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023	15 April 2023	Berlaku
53	Klinik Tirto Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023	18 September 2023	Berlaku
54	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23	24 April 2023	Berlaku
55	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023	3 Juli 2023	Proses di Pihak Kedua

56	Klinik Jantung Hasna Medika Malang	Pelayanan Asuhan Pasien & Penunjang	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR/HMMALANG/XII/2023	1 Desember 2023	Berlaku
57	Klinik Rawat Inap Wijaya Husada	Rujukan Asuhan Pasien	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	15 April 2023	Berlaku
58	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH	21 Juli 2023	Berlaku
59	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	188/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023	3 Oktober 2023	Berlaku
60	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	131.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023	31 Mei 2023	Berlaku
61	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023	5 Juni 2023	Berlaku
62	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	142.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023	22 Juni 2023	Berlaku
63	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023	1 November 2023	Berlaku
64	PT. Arthawena Sakti Gemilang	Pelayanan Rujukan kesehatan	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	-	15 Juni 2023	Berlaku
65	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit			22 April 2022	Berlaku
66	CV. Aumireta Anggun	Rujukan Pelayanan Kesehatan	164.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	-	28 Agustus 2023	Berlaku
67	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023	30 Oktober 2023	Berlaku
68	RS Islam Unisma Malang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	MENUNGGU SEKRETARIAT	1 Januari 2024	Berlaku
69	RS Puri Bunda	Rujukan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024	6 Februari 2024	Berlaku

		Pelayanan Kesehatan dan Penunjang				
70	RSUD Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	245.1/E-PKS/DIR/II/2024	074.3/35.07.302.102/2024	1 Maret 2024	Berlaku
71	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023		24 Agustus 2023	Berlaku
72	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123	30 Januari 2023	Berlaku
73	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan Pasien	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-	10 Januari 2022	Berlaku
74	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			2 Agustus 2022	Berlaku
75	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	200.11/DPM/I-PKS/DIR/I/2022		5 Januari 2022	Berlaku
76	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	112.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022	2 Agustus 2022	Berlaku
77	PT. Jaya Obayashi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	360/DPM/I-PKS/VIII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
78	PT. Malang Intermedia Pers	Pelayanan Kesehatan	025/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020	1 Juli 2020	Berlaku
79	PT. Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	032/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020		1 Juli 2020	Berlaku
80	PT. Yamaha Musical Product Indonesia	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP BAGI KARYAWAN DAN KELUARGA	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/II/II/2020	1 Juni 2022	Berlaku
81	PT. Tirta Investama	PELAYANAN			31 Agustus 2020	Berlaku

		KESEHATAN KARYAWAN & KELUARGA				
82	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023	1 Januari 2023	Berlaku
83	PT. Kemas Super Indonesia (KSI)	Pelayanan Kesehatan				Berlaku
84	PT. Nayaka Era Husada	Pelayanan Kesehatan	143.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023	30 Mei 2023	Berlaku
85	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	768/E-PKS/DIR/V/2023	#REF!	1 Juni 2023	Berlaku
86	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1790/E-PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023	20 November 2023	Berlaku
87	RS Lavalette	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	155.2/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124	10 Agustus 2023	Berlaku
88	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019	21 Februari 2022	Berlaku
89	RS Panti Nirmala	Kerjasama Pelayanan Rujukan	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022	7 Oktober 2022	Berlaku
90	PT Kimberly Clark	Pasokan produk		106/KCS-PNS/MOU/II/2023	1 Januari 2024	BERLAKU
91	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	267/RSPHS/E-PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019	18 September 2019	Berlaku
92	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	015/DPM/E-PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2	28 Januari 2020	Perpanjang Otomatis
93	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan	1879/E-PKS/DIR/XII/2023	602/KTR/VII-05/1223	1 Januari 2024	Berlaku

		Bagi Peserta Program JKN				
94	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022	1 Januari 2023	Berlaku
95	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	031/DPM/E-PKS/DIR/III/2022		10 Maret 2021	Progres Pihak Kedua
96	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	347/DPM/I-PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021	16 Juni 2021	Progres Pihak Kedua
97	PT. Etercon Pharma	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien Maternitas	132.1/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023	1 Juni 2023	Proses Pihak Kedua
98	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	339.6/E-PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022	1 Maret 2022	Proses Review Kabid
99	PT. Kencana Tiara Gemilang (KTG)	Pelayanan Kesehatan	174.1/DPM/E- PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021	12 Desember 2021	Berlaku
100	PT. Rentokil	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	173.1/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG-37/52400326/IX/2023	11 September 2023	Berlaku
101	PT. Pillar Utama Cortindo	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023	1 Juni 2023	Progres di PT
102	PT. Global Trans Jaya Mulia & PT Global Enviro Nusa	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	115/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	044/SPK-T/DPM-GTJM/GEN/IV/2024	15 April 2024	Berlaku

103	PT. Uniplastindo Interbuana	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	302/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021	8 Juni 2023	Proses TTD Pihak Kedua
104	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019	1 November 2022	Berlaku
105	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	152.40/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022	16 September 2022	Berlaku
106	RS Siti Miriam Lawang	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022	4 Oktober 2022	Berlaku
107	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	234/DPM/E-PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024	1 November 2024	Berlaku
108	RSU Muhammadiyah (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	159.1/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023	21 Agustus 2023	Disposisi SIMRS
109	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	1183/E-PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023		PROSES PERMOHONAN
110	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			23 Februari 2024	Berlaku
111	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan				PROSES TTD DILUAR

112	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan				PROSES DISPOSISI SIM
113	PT Teknologi Pamadya Analitika (Meditap)	Asuransi Pelayanan Keshatan				PROSES PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN PKS
114	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	294/E-PKS/DIR/I/2024		17 Januari 2024	Berlaku
115	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Protesa Ortesa				PROSES DISPOSISI SIM
116	PT Pesta Pora Abadi	Rujukan Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024			Review Pihak kedua
117	Batas Media 99	Rujukan Pelayanan Kesehatan			5 Juni 2024	Berlaku
118	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Rujukan Pelayanan Kesehatan				TTD Dir PT
119	PT Tentrem Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
120	Klinik Utana Rawat Jalan Akasia	Rujukan Pelayanan Kesehatan	25 April 2024		Berlaku	
121	PT Ustegra	Rujukan Pelayanan Kesehatan			Review Pihak kedua	
122	PT Pancamas Elite	Rujukan Pelayanan Kesehatan	12 Juni 2024		Berlaku	
123	PT Unggul Anugerah Sejahtera	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
124	PT Bestari Murni Anugerah	Rujukan Pelayanan Kesehatan	4 Juni 2024		Berlaku	
125	PT Indonesian Marine	Rujukan			Review Pihak kedua	

126	PT Randi Cones Indonesia	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					
127	PT Indonesian Tobacco	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
128	PT Tonggak Ampuh	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					Review Pihak kedua
129	Klinik Beauty Medika	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	145/DPM/E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2004	25 Mei 2024		Berlaku
130	Ibazz Aesthetic and Medical Center	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	180/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024		14 Juni 2024		Berlaku
131	RS Universitas Brawijaya	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	178/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024				Review Pihak kedua
132	PT Citra Karsa Dinamika	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan					Proses TTD Pihak Kedua
133	PT Moor Sukses Internasional	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	200/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	001/MSI/VI/2024	8 Juli 2024		Berlaku
134	BPM Nia Irawati	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	081/DPM/E-PKS/DIR/III/2024		7 Februari 2024		Berlaku
135	Instruktur Zumba	Instruktur Zumba Rujukan Pelayanan Kesehatan			23 Februari 2024		Berlaku
136	Klinik Esweje	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9120200211338	1 Maret 2024		Berlaku
137	PT Alfiza Medika Utama	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024	7 Maret 2024		Berlaku
138	PT Medilink Digital Medika	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024	22 Maret 2024		Berlaku

139	BPM Riza Khutmi	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
140	BPM Indah Maharany	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
141	PT Indostar Building Material	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
142	Rajawali Plastik	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Proses TTD Pihak Kedua
143	Green Mountain Natural Foods	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak kedua
144	PT Indonusa Algaemas Prima	Rujukan Pelayanan Kesehatan				Review Pihak Kedua
145	RSUD Bangil	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024	22 Juli 2024	Berlaku